

Bunga Rampai

SIKLUS HIDUP PEREMPUAN

PERSPEKTIF KEBIDANAN BERBASIS
BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

Priscilla Jessica Pihahay • Meli Doloksaribu • Vera Suzana Dewi Haris
Yan Deivita • Defacto Firmawati Zega

Editor: Siti Maryam



BUNGA RAMPAI

SIKLUS HIDUP PEREMPUAN: PERSPEKTIF KEBIDANAN BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

Penulis:

Priscilla Jessica Pihahay SKM., M.K.M.
Bdn. Meli Doloksaribu, S.Tr.Keb., M.Keb.
Vera Suzana Dewi Haris, SST., Bdn., M.Ken.
Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb.
Defacto Firmawati Zega, SST., M.Kes.

Editor:

Bdn.Siti Maryam, S.ST., MPH.



BUNGA RAMPAI SIKLUS HIDUP PEREMPUAN: PERSPEKTIF KEBIDANAN BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

Penulis: Priscilla Jessica Pihahay SKM., M.K.M.

Bdn. Meli Doloksaribu, S.Tr.Keb., M.Keb.

Vera Suzana Dewi Haris, SST., Bdn., M.Ken.

Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb.

Defacto Firmawati Zega, SST., M.Kes.

Editor: Bdn.Siti Maryam, S.ST., MPH.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7426-12-3

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku Bunga Rampai Siklus Hidup Perempuan: Perspektif Kebidanan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal dapat hadir di tengah para pembaca. Kehadiran buku ini merupakan sebuah upaya kolektif untuk menghadirkan literatur kebidanan yang komprehensif, yang tidak hanya menekankan pada aspek medis dan ilmiah, tetapi juga mengangkat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi bagian integral dari kehidupan perempuan Indonesia.

Siklus hidup perempuan adalah perjalanan panjang yang dimulai sejak masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lansia. Setiap fase kehidupan tersebut diwarnai oleh perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial yang khas. Dalam konteks kebidanan, setiap tahap kehidupan perempuan memerlukan pendekatan yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik serta dipengaruhi oleh lingkungan budaya tempat ia berada. Tradisi, kepercayaan, dan praktik lokal sering kali menjadi pedoman dalam menjaga kesehatan perempuan, dan hal ini tidak dapat dipisahkan dari pelayanan kebidanan yang berorientasi pada masyarakat.

Buku ini hadir sebagai wujud refleksi bahwa pelayanan kebidanan yang efektif tidak hanya bertumpu pada evidence-based practice semata, tetapi juga perlu peka budaya (cultural sensitivity). Kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi sering kali memuat nilai kesehatan yang relevan, bahkan dapat menjadi bagian penting dalam strategi promotif dan preventif kesehatan. Integrasi antara ilmu modern dengan praktik budaya lokal bukanlah bentuk kontradiksi, melainkan sebuah peluang untuk memperkuat asuhan kebidanan yang lebih humanis, kontekstual, dan berkesinambungan.

Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk mengupas berbagai perspektif tentang siklus hidup perempuan, mulai dari kesehatan remaja, masa reproduktif, kehamilan, persalinan, nifas, hingga periode menopause dan lansia. Penulis menyajikan uraian mendalam tentang bagaimana nilai budaya dan praktik tradisional dapat diharmonisasikan dengan praktik kebidanan berbasis bukti. Dengan pendekatan interdisipliner dan interprofesional, buku ini berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih utuh tentang perempuan, bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas dan sistem sosial budaya.

Kekuatan buku ini terletak pada keberagaman pemikiran yang dihimpun dari para penulis dengan latar belakang akademik dan pengalaman yang beragam. Setiap tulisan

memperlihatkan komitmen untuk menghadirkan gagasan yang berakar pada realitas masyarakat, sekaligus berpijak pada standar ilmiah dan penelitian terkini. Dengan demikian, buku ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen sebagai referensi akademik, tetapi juga relevan bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lain dalam praktik pelayanan sehari-hari.

Kami berharap, kehadiran Bunga Rampai Siklus Hidup Perempuan: Perspektif Kebidanan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal dapat memperkaya literatur kebidanan di Indonesia dan menjadi inspirasi dalam pengembangan praktik yang lebih inklusif, peka budaya, dan menghargai keberagaman. Lebih jauh, semoga buku ini juga mampu menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai tahap kehidupannya, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional dan global.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh penulis, mitra akademik, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini bermanfaat luas, menjadi sumber pengetahuan yang berharga, serta menjadi inspirasi untuk melahirkan inovasi pelayanan kebidanan yang berakar pada budaya dan kearifan lokal, namun tetap berpijak pada fondasi ilmiah yang kuat.

Oktober, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
CHAPTER 1 SIKLUS HIDUP PEREMPUAN DAN BUDAYA.....	1
Priscilla Jessica Pihahay, SKM., M.K.M.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Siklus Hidup Perempuan dalam Perspektif Global.....	2
C. Siklus Hidup Perempuan dalam Konteks Indonesia	4
D. Implikasi bagi Kesehatan, Pendidikan, dan Kebijakan Publik.....	6
E. Simpulan.....	9
F. Referensi	9
G. Glosarium	13
CHAPTER 2 RITUAL KEHAMILAN DAN PERSALINAN BERBASIS BUDAYA	
.....	15
Bdn. Meli Doloksaribu, S.Tr.Keb., M.Keb.	15
A. Pendahuluan/Prolog	15
B. Pentingnya Memahami Ritual Budaya dalam Kehamilan dan Persalinan	16
C. Jenis-jenis Ritual Kehamilan dalam Berbagai Budaya	18
D. Ritual Persiapan Menjelang Persalinan Berbasis Budaya	19
E. Praktik Ritual Selama Persalinan dan Setelah Melahirkan.....	21
F. Peran Bidan dalam Mengakomodasi Ritual Budaya dalam Pelayanan Kebidanan	23
G. Studi Kasus: Ritual Kehamilan dan Persalinan dalam Budaya Lokal Indonesia	24
H. Tantangan dan Strategi Bidan dalam Mengintegrasikan Ritual Budaya dengan Praktik Medis Modern.....	26
I. Simpulan.....	27
J. Referensi	28
K. Glosarium	30

CHAPTER 3 TRADISI DALAM PERAWATAN BAYI BARU LAHIR	33
Vera Suzana Dewi Haris, SST., Bdn., M.Keb.	33
A. Pendahuluan/Prolog	33
B. Pembahasan	35
C. Simpulan	43
D. Referensi	46
E. Glosarium	48
 CHAPTER 4 KEARIFAN LOKAL DALAM PENGASUHAN BALITA	 51
Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb	51
A. Pendahuluan/Prolog	51
B. Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pengasuhan Balita	52
C. Praktik Tradisional dalam Pengasuhan Balita	54
D. Kearifan Lokal dalam Pemenuhan Nutrisi dan Kesehatan Balita	57
E. Studi Kasus Implementasi Kearifan Lokal dalam Pengasuhan Balita	59
F. Tantangan dalam Mengintegrasikan Kearifan Lokal dan Solusinya	61
G. Peran Orang Tua, Tenaga Kesehatan, dan Pemerintah dalam Melestarikan Kearifan Lokal	64
H. Prospek Kearifan Lokal dalam Pengasuhan Balita di Masa Depan	66
I. Simpulan	69
J. Referensi	70
K. Glosarium	71
 CHAPTER 5 MENARCHE, PERNIKAHAN DINI, DAN BUDAYA LOCAL	 75
Defacto Firmawati Zega, SST., M.Kes.	75
A. Pendahuluan/Prolog	75
B. Konsep Dasar Menarche	77
C. Pernikahan Dini dalam Perspektif Sosial dan Budaya	79
D. Peran Budaya Lokal dalam Menentukan Sikap terhadap Menarche dan Pernikahan Dini	83
E. Dampak Interaksi Menarche dan Pernikahan Dini dalam Budaya Lokal	85
F. Strategi Pencegahan Pernikahan Dini dengan Pendekatan Berbasis Budaya Lokal	87
G. Tantangan dan Hambatan dalam Perubahan Norma Sosial dan Budaya	89

H. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Menarche dan Pencegahan Pernikahan Dini	92
I. Simpulan.....	94
J. Referensi.....	95
K. Glosarium	96
PROFIL PENULIS	99

CHAPTER 1

SIKLUS HIDUP PEREMPUAN DAN BUDAYA

Priscilla Jessica Pihahay, SKM., M.K.M.

A. Pendahuluan/Prolog

Perempuan menjalani perjalanan hidup yang sarat dengan dinamika biologis, psikologis, dan sosial. Setiap tahap kehidupan, mulai dari masa kanak-kanak hingga lanjut usia, bukan sekadar proses alami, tetapi juga dipengaruhi secara kuat oleh budaya dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Pendekatan *life course* menekankan bahwa kehidupan manusia harus dipahami sebagai sebuah rangkaian berkesinambungan, di mana pengalaman pada satu fase akan memengaruhi fase berikutnya (Elder, Johnson, & Crosnoe, 2003). Bagi perempuan, fase-fase kehidupan ini sering diwarnai oleh simbolisme budaya, aturan moral, bahkan regulasi sosial yang menjadikan tubuh perempuan sebagai arena perdebatan sosial dan politik (O'Reilly, 2020).

Secara global, penelitian menunjukkan bahwa pengalaman perempuan dalam setiap fase kehidupannya dipengaruhi oleh konteks budaya. Misalnya, pubertas di Barat sering dipandang dari perspektif medis dan psikologis, sedangkan di banyak komunitas Asia, Afrika, atau Amerika Latin, pubertas memiliki makna ritual yang menandai transisi menuju kedewasaan sosial (Christensen & Prout, 2017). Demikian pula, menopause di negara-negara Barat sering dianggap sebagai fase kehilangan, sementara dalam budaya tertentu justru dipandang sebagai saat perempuan memperoleh status baru yang lebih dihormati (Sievert, 2021).

Dalam konteks Indonesia, keragaman budaya memperlihatkan betapa kaya simbol dan praktik yang membingkai siklus hidup perempuan. Sejak masa anak-anak, perempuan diarahkan untuk menginternalisasi peran gender melalui pola asuh dan permainan tradisional. Saat remaja, menstruasi pertama tidak hanya dipandang sebagai fenomena biologis, tetapi sering kali disambut dengan ritual adat tertentu. Pada masa dewasa, pernikahan, kehamilan, dan persalinan menjadi peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan komunitas. Ketika memasuki usia lanjut, sebagian perempuan dihormati sebagai penjaga tradisi dan otoritas moral, sementara sebagian lain menghadapi marginalisasi akibat modernisasi dan individualisasi.

Bab ini bertujuan menguraikan siklus hidup perempuan dan keterkaitannya dengan budaya. Penjelasan dibagi dalam dua bagian utama: pertama, menyoroti

fenomena siklus hidup perempuan dalam perspektif global; kedua, membahas secara lebih spesifik dalam konteks Indonesia dengan menampilkan contoh-contoh etnografi dari berbagai daerah. Dengan cara ini, pembahasan diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana tubuh dan kehidupan perempuan dimaknai secara berbeda lintas budaya, serta implikasinya terhadap kesehatan, pendidikan, dan kebijakan publik.

B. Siklus Hidup Perempuan dalam Perspektif Global

Siklus hidup perempuan dalam perspektif global memperlihatkan bahwa pengalaman biologis tidak pernah berdiri sendiri. Fase-fase kehidupan perempuan selalu dipengaruhi oleh nilai sosial, norma budaya, serta struktur kekuasaan yang ada di masyarakat. Budaya berperan dalam menentukan makna setiap transisi kehidupan apakah ia dianggap sebagai kehormatan, beban, atau bahkan stigma. Oleh karena itu, memahami perempuan dari sudut pandang global berarti melihat bagaimana tubuh dan identitas mereka dinegosiasikan di antara faktor biologis dan kultural (Gluckman & Low, 2018).

1. Masa Anak-Anak: Sosialisasi Gender Sejak Dini

Masa anak-anak adalah periode awal di mana perempuan diperkenalkan pada identitas gender. Secara global, banyak studi menunjukkan bahwa sosialisasi gender dimulai sejak bayi: warna pakaian, mainan, hingga cara keluarga berinteraksi dengan anak berbeda menurut jenis kelamin (Martin & Ruble, 2019). Anak perempuan lebih sering diberi mainan boneka atau dapur-dapur, sementara anak laki-laki diarahkan ke permainan konstruksi atau olahraga. Penelitian lintas negara memperlihatkan bahwa pola asuh berbasis gender ini konsisten, meskipun dalam intensitas berbeda. Misalnya, studi di India menemukan bahwa anak perempuan sejak dini lebih banyak dilibatkan dalam pekerjaan domestik, sementara di Swedia yang lebih egaliter, perbedaan tersebut semakin berkurang karena adanya dukungan kebijakan negara (Esping-Andersen et al., 2015). Proses ini menunjukkan bahwa budaya memiliki peran besar dalam menentukan ruang gerak anak perempuan sejak masa awal kehidupannya.

2. Masa Remaja: Pubertas dan Identitas Sosial

Pubertas adalah fase penting bagi remaja perempuan. Menarke (haid pertama) bukan hanya fenomena biologis, tetapi juga dipahami sebagai simbol transisi menuju kedewasaan. Di banyak budaya, pubertas diperlakukan sebagai momen sakral yang dirayakan dengan ritual tertentu. Misalnya, komunitas Navajo di Amerika Utara mengadakan upacara kinaaldá sebagai perayaan pubertas perempuan, sementara di beberapa komunitas Afrika Timur terdapat ritual

seclusion (pengasingan sementara) sebagai bagian dari pendidikan menuju kedewasaan (Hodgson, 2017).

Sebaliknya, di negara-negara Barat, pubertas sering dibingkai dalam perspektif medis dan psikologis. Diskursus lebih banyak berfokus pada perubahan hormonal, kesehatan reproduksi, serta implikasi psikososial seperti body image dan harga diri. Tantangan modern juga muncul dengan kehadiran media sosial yang memperkuat standar kecantikan tidak realistis, membuat remaja perempuan lebih rentan terhadap gangguan citra tubuh (Tiggemann & Slater, 2014; Holland & Tiggemann, 2017).

3. Masa Dewasa: Pernikahan, Kehamilan, dan Peran Reproduksi

Masa dewasa bagi perempuan ditandai dengan peran reproduktif, yaitu perkawinan, kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak. Namun, bagaimana masyarakat memaknai fase ini sangat bervariasi. Di beberapa budaya Afrika dan Asia Selatan, pernikahan dini masih dianggap wajar sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga, meskipun praktik ini terbukti berdampak negatif pada kesehatan reproduksi dan pendidikan perempuan (UNICEF, 2021).

Sebaliknya, di negara-negara Skandinavia, pernikahan bukan lagi keharusan. Banyak perempuan memilih untuk menunda pernikahan atau hidup bersama tanpa ikatan formal, dengan akses luas terhadap layanan kesehatan reproduksi dan jaminan sosial (Thomson et al., 2019).

Kehamilan dan persalinan juga sarat makna budaya. Di Amerika Latin, misalnya, terdapat tradisi penggunaan bidan tradisional (parteras) yang dihormati karena dianggap memiliki pengetahuan spiritual dan medis. Namun, dalam konteks global, terdapat dorongan integrasi antara praktik tradisional dengan layanan medis modern agar keselamatan ibu dan bayi tetap terjamin (Sibbritt et al., 2016).

4. Menopause dan Lansia: Dari Kehilangan ke Kebijaksanaan

Menopause secara biologis menandai berakhirnya fungsi reproduksi perempuan. Namun, makna sosialnya berbeda-beda. Di Barat, menopause sering diasosiasikan dengan kehilangan kesuburan, daya tarik, dan status sosial (Avis & Crawford, 2008). Akan tetapi, perspektif antropologi medis menunjukkan bahwa di banyak budaya Asia, menopause dipandang lebih positif. Studi di Jepang dan India menemukan bahwa perempuan merasa lebih bebas karena terbebas dari kewajiban reproduktif dan tabu menstruasi (Sievert, 2021).

Di sisi lain, lansia perempuan di banyak negara Global South masih menjadi figur penting dalam komunitas. Mereka berperan sebagai penjaga tradisi, pengasuh cucu, hingga penasihat keluarga. Namun, modernisasi juga membawa

marginalisasi, terutama di kota besar di mana sistem keluarga besar melemah (WHO, 2015).

5. Globalisasi dan Negosiasi Budaya

Globalisasi menciptakan budaya hibrid dalam siklus hidup perempuan. Perempuan muda di negara-negara berkembang kini menghadapi percampuran nilai tradisional dan modern. Mereka mungkin masih menjalani ritual adat seperti upacara pubertas atau pernikahan adat, tetapi pada saat yang sama menggunakan aplikasi digital untuk melacak siklus menstruasi atau mencari informasi kesehatan reproduksi.

Gerakan feminisme global juga berperan dalam mengkritisi praktik budaya yang merugikan, seperti perkawinan usia anak, sunat perempuan, atau pelarangan akses terhadap kontrasepsi. Namun, feminisme lokal di banyak negara berkembang lebih memilih pendekatan dialogis dengan budaya setempat, sehingga menghasilkan bentuk perjuangan yang khas (Mohanty, 2018).

C. Siklus Hidup Perempuan dalam Konteks Indonesia

Indonesia dengan keragaman etnik, agama, dan tradisi menghadirkan gambaran kaya tentang bagaimana siklus hidup perempuan dimaknai. Setiap fase kehidupan anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia dilingkupi simbol, ritual, dan praktik budaya yang memperkuat identitas sekaligus membatasi ruang gerak perempuan. Di satu sisi, budaya memberi makna dan solidaritas sosial; di sisi lain, ia juga dapat melanggengkan praktik diskriminatif yang merugikan perempuan (Blackburn, 2004; Robinson, 2022).

1. Masa Anak-Anak: Internalisasi Peran Gender Melalui Pola Asuh dan Permainan

Sejak masa kanak-kanak, perempuan Indonesia diperkenalkan pada peran gender melalui pola asuh dan permainan tradisional. Di Jawa, anak perempuan sering diarahkan membantu pekerjaan domestik, seperti memasak atau menjaga adik, sementara anak laki-laki diberi tugas di luar rumah. Permainan tradisional seperti *engklek* atau *jamuran* berfungsi bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sarana internalisasi nilai kesopanan dan kerja sama (Koentjaraningrat, 2009).

Di Papua, anak perempuan sejak dini terbiasa menggunakan *noken*, tas anyaman tradisional yang digunakan untuk membawa hasil kebun atau bayi. Aktivitas ini menanamkan nilai tanggung jawab dan keterlibatan ekonomi keluarga (Pasaribu & Rahail, 2019). Sementara di Minangkabau, pola asuh berbasis matrilineal menekankan kemandirian perempuan karena mereka kelak

akan menjadi *bundo kanduang* yang memegang otoritas kekerabatan (Sanday, 2002).

2. Masa Remaja: Menarke, Ritual, dan Tabu Menstruasi

Menstruasi pertama (menarke) di Indonesia sering disertai makna budaya. Di Bali, remaja perempuan mengikuti upacara penyucian untuk menandai transisi ke kedewasaan. Di Toraja, menarke menjadi simbol kesiapan sosial yang diikuti dengan ritual adat tertentu. Di Maluku dan Papua, beberapa komunitas masih mempraktikkan pengasingan sementara bagi anak perempuan yang baru menstruasi. Praktik ini bertujuan melindungi, tetapi juga sering menimbulkan stigma bahwa menstruasi adalah sesuatu yang kotor (Handajani, 2005).

Mitos menstruasi juga banyak ditemui. Di Jawa, remaja perempuan dilarang makan makanan tertentu seperti nanas atau pedas saat haid karena dianggap berbahaya. Di Sunda, ada kepercayaan bahwa perempuan haid tidak boleh masuk ke sawah karena dapat merusak tanaman. Meski tidak sepenuhnya didukung bukti medis, tradisi ini tetap kuat karena diwariskan lintas generasi (Utami & Hidayat, 2018).

Dalam konteks modern, remaja perempuan juga menghadapi pengaruh media sosial. Standar kecantikan global yang menekankan kulit putih, tubuh langsing, dan rambut lurus sering memunculkan rasa tidak percaya diri. Studi di Jakarta menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berkorelasi dengan gangguan citra tubuh pada remaja putri (Riyanto & Arumsari, 2021).

3. Masa Dewasa dan Reproduksi: Perkawinan, Kehamilan, dan Persalinan

Perkawinan di Indonesia umumnya merupakan peristiwa sosial besar. Di Jawa, prosesi *siraman* dan *mitoni* (tujuh bulan kehamilan) mengandung simbol kesucian dan doa keselamatan. Di Minangkabau, perkawinan menegaskan sistem matrilineal di mana perempuan memegang garis keturunan. Sementara di Batak, prosesi pernikahan menonjolkan simbol pemberian *ulos* sebagai tanda restu keluarga besar (Koentjaraningrat, 2009; Brenner, 1998).

Kehamilan dan persalinan juga penuh simbolisme. Banyak daerah memiliki pantangan makanan, seperti larangan makan belut atau nanas karena dianggap bisa membahayakan janin. Di NTT, ritual *belis* (mas kawin) menempatkan perempuan sebagai penghubung antara keluarga, meski juga dikritik karena memperkuat posisi subordinat (Darmastuti, 2020).

Peran dukun beranak masih signifikan di beberapa daerah, terutama di Papua, Maluku, dan NTT. Namun, sejak adanya program bidan desa, terjadi integrasi antara praktik tradisional dan layanan medis. Kolaborasi ini terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menurunkan angka kematian ibu (Suryanto & Astuti, 2017).

4. Menopause dan Lansia: Antara Kehormatan dan Marginalisasi

Perempuan Indonesia yang memasuki fase menopause dan lansia memiliki posisi yang beragam dalam masyarakat. Di Minangkabau, perempuan tua dihormati sebagai *bundo kanduang*, simbol otoritas moral dan adat. Di Bali, perempuan lansia masih aktif memimpin ritual keluarga dan pura, sehingga posisi sosialnya tetap kuat (Robinson, 2022). Sebaliknya, di perkotaan modern, perempuan lansia sering terpinggirkan. Mereka menghadapi keterbatasan akses kesehatan, jaminan sosial, dan rentan mengalami kesepian akibat melemahnya sistem keluarga besar (WHO, 2015). Dalam konteks ini, penghormatan adat tidak selalu terjamin ketika perempuan berpindah ke lingkungan urban yang lebih individualistik.

5. Tantangan Modernisasi: Urbanisasi, Migrasi, dan Media Sosial

Modernisasi membawa perubahan signifikan. Urbanisasi menyebabkan banyak perempuan muda meninggalkan desa untuk bekerja di kota, sehingga terputus dari jaringan sosial tradisional. Migrasi internasional juga melibatkan banyak perempuan Indonesia sebagai pekerja domestik di luar negeri. Mereka menjadi penopang ekonomi keluarga, tetapi juga menghadapi kerentanan eksploitasi dan kekerasan (Silvey, 2004; Raharto, 2019).

Di sisi lain, teknologi digital membuka ruang partisipasi baru bagi perempuan. Media sosial dimanfaatkan untuk membangun jaringan solidaritas, kampanye kesehatan reproduksi, dan advokasi kesetaraan gender. Namun, muncul pula tantangan baru seperti kekerasan berbasis daring (*online gender-based violence*), yang semakin banyak dilaporkan di Indonesia (UN Women, 2020).

D. Implikasi bagi Kesehatan, Pendidikan, dan Kebijakan Publik

Siklus hidup perempuan yang selalu dipengaruhi budaya membawa konsekuensi penting pada kesehatan, pendidikan, dan kebijakan publik. Tanpa pemahaman budaya yang mendalam, intervensi dalam bidang ini sering kali tidak efektif, bahkan dapat menimbulkan resistensi masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara nilai-nilai budaya lokal dengan pengetahuan modern menjadi kunci untuk mewujudkan layanan yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Implikasi bagi Kesehatan

Budaya memainkan peran besar dalam menentukan sikap perempuan terhadap kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Banyak perempuan enggan mengakses layanan medis karena adanya tabu, stigma, atau dominasi nilai tradisional. Misalnya, tabu menstruasi di berbagai daerah membuat remaja perempuan malu untuk mencari informasi tentang kesehatan reproduksi.

Demikian pula, keyakinan adat tertentu sering menghambat perempuan hamil untuk menjalani pemeriksaan kehamilan rutin (Mahmuda, 2019; Pitaloka, 2020).

Pendekatan *cultural competence* dalam layanan kesehatan sangat diperlukan. Tenaga kesehatan perlu memahami praktik lokal—seperti keterlibatan dukun beranak atau ritual adat—agar intervensi medis dapat diterima dengan baik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kolaborasi bidan dan dukun beranak di Indonesia meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menurunkan angka kematian ibu (Kusumawati & Suprajitno, 2018). Lebih jauh, WHO (2021) menekankan pentingnya pendekatan *life-course* dalam kebijakan kesehatan perempuan, yakni memastikan dukungan sejak masa anak-anak, remaja, reproduktif, hingga lansia.

2. Implikasi bagi Pendidikan

Budaya tidak hanya memengaruhi kesehatan, tetapi juga pendidikan perempuan. Masih banyak mitos yang beredar, seperti larangan mandi saat menstruasi atau anggapan bahwa kontrasepsi menyebabkan kemandulan. Tanpa pendidikan yang berbasis pengetahuan ilmiah, mitos ini akan terus diwariskan lintas generasi (Handajani, 2005; UNESCO, 2018).

Pendidikan formal dan non-formal memiliki peran strategis dalam meluruskan mitos sekaligus memperkuat literasi kesehatan. Program pendidikan seksualitas komprehensif (*comprehensive sexuality education*) yang disarankan UNESCO (2018) terbukti meningkatkan pengetahuan remaja perempuan tentang tubuhnya dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih sehat.

Selain itu, pendidikan sensitif gender di sekolah dapat membantu anak perempuan membangun rasa percaya diri, mengatasi stigma, serta mengurangi ketidaksetaraan akses pendidikan akibat perkawinan usia dini. Data BPS-UNICEF (2020) menunjukkan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun berisiko tiga kali lebih tinggi putus sekolah dibandingkan mereka yang menikah setelah usia dewasa.

3. Implikasi bagi Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang tidak mempertimbangkan siklus hidup perempuan berpotensi gagal menjawab kebutuhan nyata. Misalnya, program kesehatan ibu sering berfokus pada fase kehamilan, padahal perempuan membutuhkan dukungan kesehatan sejak masa remaja hingga menopause. WHO (2021) merekomendasikan kebijakan *continuum of care* agar perempuan mendapatkan akses layanan yang konsisten sepanjang hidupnya.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik perlu mengakomodasi praktik budaya lokal. Alih-alih menyingkirkan praktik tradisional, pendekatan integratif lebih efektif. Contohnya, mengakui peran dukun beranak tetapi memberikan

pelatihan kesehatan dasar agar mereka menjadi mitra bidan. Hal ini tidak hanya menjaga keberlanjutan budaya, tetapi juga meningkatkan keselamatan ibu dan bayi (Kusumawati & Suprajitno, 2018).

Selain itu, perlindungan terhadap lansia perempuan perlu diperkuat. Urbanisasi dan melemahnya sistem keluarga besar membuat banyak perempuan lansia menghadapi marginalisasi. Program jaminan sosial yang ramah gender dan layanan kesehatan berbasis komunitas dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka (Utami, 2010; WHO, 2015).

4. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan uraian tentang kesehatan, pendidikan, dan kebijakan publik di atas, jelas bahwa perempuan di Indonesia menghadapi dinamika yang kompleks dalam menjalani siklus hidupnya. Setiap fase kehidupan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis, sosial, dan budaya, sehingga solusi yang ditawarkan tidak bisa bersifat tunggal atau seragam. Penulis berpendapat bahwa strategi intervensi harus memperhatikan keberagaman budaya lokal, sekaligus memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Dengan demikian, rekomendasi yang ditawarkan bukan hanya bertujuan untuk mengatasi masalah jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi berkelanjutan bagi pemberdayaan perempuan lintas generasi. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan, praktisi, maupun akademisi:

a. Kesehatan:

- 1) Tenaga kesehatan perlu dilatih kompetensi budaya (*cultural competence*) untuk memahami praktik lokal.
- 2) Kolaborasi bidan–dukun diperkuat melalui pelatihan dan regulasi yang jelas.
- 3) Pendekatan *life-course* diintegrasikan dalam program kesehatan perempuan.

b. Pendidikan:

- 1) Integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum sejak sekolah dasar.
- 2) Program edukasi berbasis komunitas yang melibatkan tokoh adat dan agama.
- 3) Peningkatan akses pendidikan bagi remaja perempuan untuk mencegah perkawinan usia dini.

c. Kebijakan Publik:

- 1) Penyusunan kebijakan berbasis bukti dengan mempertimbangkan konteks budaya.

- 2) Penyediaan jaminan sosial dan layanan kesehatan lansia yang responsif gender.
- 3) Kolaborasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, agama, budaya) untuk pemberdayaan perempuan.

E. Simpulan

Siklus hidup perempuan, baik secara global maupun dalam konteks Indonesia, memperlihatkan bahwa kehidupan perempuan tidak pernah netral atau murni biologis. Setiap fase anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia selalu diberi makna sosial dan budaya yang membentuk identitas, peran, bahkan peluang hidup mereka. Di tingkat global, pubertas sering dirayakan sebagai momen sakral, pernikahan dipandang sebagai institusi sosial yang kompleks, sementara menopause bisa dianggap sebagai kehilangan atau justru sebagai kebijaksanaan. Dalam konteks Indonesia, kekayaan budaya lokal menghadirkan ragam praktik yang unik: dari mitoni di Jawa, rumah merah di Maluku dan Papua, ulos dalam perkawinan Batak, hingga otoritas bundo kanduang di Minangkabau.

Namun, tradisi yang memberi makna juga dapat melahirkan tantangan. Tabu menstruasi, perkawinan usia anak, dan beban ganda masih menjadi masalah nyata yang menghambat kesejahteraan perempuan. Modernisasi dan globalisasi menciptakan budaya hibrid: perempuan kini bisa memadukan ritual adat dengan teknologi digital, tetapi juga menghadapi risiko baru seperti eksploitasi migran perempuan dan kekerasan berbasis daring.

Implikasinya jelas: kesehatan perempuan harus dikelola dengan pendekatan sensitif budaya, pendidikan harus meluruskan mitos sekaligus memperkuat literasi gender, dan kebijakan publik perlu berbasis bukti dengan menghargai keragaman lokal. Dengan cara ini, perempuan dapat diberdayakan bukan hanya untuk menghadapi tantangan biologis, tetapi juga untuk menegosiasikan makna budaya secara lebih adil dan setara.

Singkatnya, siklus hidup perempuan adalah cermin bagaimana budaya memberi makna sekaligus batasan. Menjadikan budaya sebagai mitra, bukan penghalang, merupakan langkah penting menuju masa depan di mana setiap perempuan dapat menjalani hidupnya dengan sehat, bermartabat, dan berdaya di setiap fase kehidupannya.

F. Referensi

Agung, A. A. G. (2018). Menstruation and ritual in Balinese culture. *Anthropological Journal of Southeast Asia*, 13(2), 134–150.

- Avis, N. E., & Crawford, S. L. (2008). Cultural differences in symptoms and attitudes toward menopause. *Menopause*, 15(3), 593–601.
- Badan Pusat Statistik (BPS), BKKBN, & UNICEF. (2020). *Perkawinan usia anak di Indonesia: Tren, determinan, dan konsekuensi*. Jakarta: BPS.
- Bem, S. L. (1993). *The lenses of gender: Transforming the debate on sexual inequality*. New Haven: Yale University Press.
- Blackburn, S. (2004). *Women and the state in modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brenner, S. (1998). *The domestication of desire: Women, wealth, and modernity in Java*. Princeton: Princeton University Press.
- Buckley, T., & Gottlieb, A. (Eds.). (1988). *Blood magic: The anthropology of menstruation*. Berkeley: University of California Press.
- Christensen, P., & Prout, A. (2017). *Children, gender and health: The cultural context of growing up*. London: Routledge.
- Connell, R. W. (2009). *Gender in world perspective*. Cambridge: Polity Press.
- Elder, G. H. (1998). The life course as developmental theory. *Child Development*, 69(1), 1–12.
- Elder, G. H., Johnson, M. K., & Crosnoe, R. (2003). The emergence and development of life course theory. In J. T. Mortimer & M. J. Shanahan (Eds.), *Handbook of the life course* (pp. 3–19). New York: Springer.
- Esping-Andersen, G., Boertien, D., Bonke, J., & Gracia, P. (2015). Couple specialization in multiple equilibria: A comparative analysis of Western societies. *European Sociological Review*, 31(1), 113–126.
- Flint, M. (1975). Menopause and cultural values. *Social Science & Medicine*, 9(2), 81–86.
- Geertz, C. (1976). *The interpretation of cultures*. New York: Basic Books.
- Gluckman, P., & Low, F. M. (2018). The life-course perspective: A cultural lens. *Evolution, Medicine, and Public Health*, 2018(1), 1–5.
- Handajani, S. (2005). Menstruasi dan makna budaya: Studi antropologi di beberapa daerah Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 40, 45–58.
- Hidayat, R. (2017). Pantangan kehamilan dalam masyarakat NTT: Kajian etnografi. *Humaniora*, 29(3), 312–325.

- Hilber, A. M., Smit, J., Chersich, M., Beksinska, M., Kunene, B., & Rees, H. (2012). A new paradigm for integrating traditional healers into HIV prevention and care in South Africa. *Culture, Health & Sexuality*, 14(6), 625–639.
- Hodgson, D. L. (2017). *The gender of globalization: Women navigating cultural and economic marginalities*. New York: Routledge.
- Holland, G., & Tiggemann, M. (2017). A systematic review of the impact of the use of social networking sites on body image and disordered eating outcomes. *Body Image*, 23, 17–32.
- Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third millennium development goal. *Gender & Development*, 13(1), 13–24.
- Kesaulya, J. (2017). Blood and seclusion: Menstrual practices in Maluku. *Indonesia and the Malay World*, 45(133), 221–239.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumawati, F., & Suprajitno. (2018). Collaborative role of midwives and traditional birth attendants in Indonesia. *Midwifery Journal of Indonesia*, 6(1), 11–20.
- Lock, M. (1993). *Encounters with aging: Mythologies of menopause in Japan and North America*. Berkeley: University of California Press.
- Mahmuda, S. (2019). Menstruasi dan tabu di masyarakat Jawa. *Al-Wihdah Journal of Gender Studies*, 3(2), 177–192.
- Martin, C. L., & Ruble, D. N. (2019). Patterns of gender development. *Annual Review of Psychology*, 70, 111–139.
- Mohanty, C. T. (2018). *Feminism without borders: Decolonizing theory, practicing solidarity*. Durham: Duke University Press.
- Nilan, P., & Parker, L. (2013). *Adolescents in contemporary Indonesia*. London: Routledge.
- O'Reilly, A. (2020). *Matricentric feminism: Theory, activism, practice*. Toronto: Demeter Press.
- Pitaloka, D. (2020). Bidan dan dukun beranak: Relasi kuasa dalam pelayanan persalinan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 11(2), 95–108.
- Robinson, K. (2022). *Gender, Islam and democracy in Indonesia*. London: Routledge.

- Sanday, P. R. (2002). *Women at the center: Life in a modern matriarchy*. Ithaca: Cornell University Press.
- Sawaki, Y. (2019). *Noken and the identity of Papuan women*. Jayapura: Cenderawasih University Press.
- Sibbritt, D., Broom, A., & Adams, J. (2016). The use of traditional and complementary medicine among mid-aged women. *Journal of Women's Health*, 25(4), 356–362.
- Sievert, L. L. (2021). Menopause across cultures: Insights from evolutionary anthropology. *Evolution, Medicine, and Public Health*, 9(1), 64–75.
- Sihombing, L. (2016). Ulos dalam pernikahan adat Batak: Makna simbolik dan fungsi sosial. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 37(1), 55–70.
- Silvey, R. (2004). Power, difference and mobility: Feminist advances in migration studies. *Progress in Human Geography*, 28(4), 490–506.
- Suryakusuma, J. I. (2011). *State Ibuism: The social construction of womanhood in New Order Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Thomson, E., Lappegård, T., Carlson, M. J., Evans, A., & Gray, E. (2019). Childbearing across partnerships in Australia, the United States, Norway, and Sweden. *Demography*, 56(1), 259–284.
- Tiggemann, M., & Slater, A. (2014). NetGirls: The Internet, Facebook, and body image concern in adolescent girls. *International Journal of Eating Disorders*, 47(6), 630–643.
- UNESCO. (2018). *International technical guidance on sexuality education*. Paris: UNESCO.
- UNICEF. (2021). *Child marriage: Latest global trends and future prospects*. New York: UNICEF.
- Utami, S. (2010). Penggunaan jamu tradisional dalam mengurangi gejala menopause. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 60(4), 174–181.
- Waterson, R. (2009). *Paths and rivers: Sa'dan Toraja society in transformation*. Singapore: NUS Press.
- World Health Organization. (2015). *World report on ageing and health*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2018). *Life-course approach to women's health*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2021). *Life-course approach to women's health*. Geneva: World Health Organization.

Yamin, A. E., & Mason, E. M. (2019). *Maternal mortality and human rights*. London: Routledge.

G. Glosarium

Bundo Kanduang: Figur perempuan tua Minangkabau yang dihormati sebagai simbol otoritas adat, pengayom keluarga, dan penjaga tradisi matrilineal.

Cultural competence: Kemampuan tenaga kesehatan atau pendidik untuk memahami, menghargai, dan menyesuaikan layanan dengan nilai, norma, dan praktik budaya masyarakat yang dilayani.

Continuum of care: Konsep layanan kesehatan yang berkesinambungan dari masa anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia, dengan tujuan menjamin kualitas hidup optimal sepanjang siklus hidup.

Dukun beranak: Penolong persalinan tradisional yang berperan penting dalam masyarakat Indonesia, tidak hanya membantu kelahiran tetapi juga menjaga nilai-nilai sosial dan spiritual.

Gender roles (peran gender): Harapan sosial dan budaya terhadap perilaku, tugas, dan tanggung jawab yang dianggap pantas bagi laki-laki maupun perempuan.

Life course (siklus hidup): Pendekatan dalam ilmu sosial yang melihat kehidupan sebagai rangkaian fase yang saling terhubung, di mana pengalaman pada satu fase memengaruhi fase berikutnya.

Matricentric feminism: Perspektif feminisme yang menempatkan pengalaman keibuan sebagai pusat analisis teori dan praktik sosial.

Menarke: Menstruasi pertama pada remaja perempuan, yang sering dipandang sebagai penanda transisi menuju kedewasaan biologis dan sosial.

Menopause: Fase berhentinya menstruasi pada perempuan yang menandai akhir masa reproduktif, dimaknai berbeda oleh tiap budaya—ada yang melihatnya sebagai kehilangan, ada pula sebagai status baru yang terhormat.

Mitoni: Upacara adat Jawa yang dilakukan pada usia kandungan tujuh bulan, bertujuan mendoakan keselamatan ibu dan bayi.

Noken: Tas anyaman khas Papua yang digunakan untuk membawa hasil kebun atau bayi, sekaligus menjadi simbol identitas, ketahanan, dan peran perempuan dalam masyarakat.

Tabu menstruasi: Larangan atau pantangan adat/religius yang diberlakukan terhadap perempuan selama menstruasi, misalnya larangan memasak, beribadah, atau memasuki ruang tertentu.

Ulos: Kain tenun tradisional Batak yang digunakan dalam upacara pernikahan atau kelahiran, melambangkan restu, ikatan keluarga, dan solidaritas sosial.

CHAPTER 2

RITUAL KEHAMILAN DAN PERSALINAN BERBASIS BUDAYA

Bdn. Meli Doloksaribu, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Kehamilan dan persalinan merupakan tahapan penting dalam kehidupan seorang perempuan yang tidak hanya melibatkan aspek fisik semata, melainkan juga dimensi psikologis, sosial, dan spiritual yang kompleks. Di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, momen-momen tersebut diiringi oleh berbagai ritual budaya yang diwariskan secara turun-temurun, yang bertujuan untuk memberikan dukungan emosional, spiritual, serta sosial kepada perempuan dan keluarganya selama masa kehamilan hingga proses persalinan. Ritual-ritual ini mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, serta norma-norma lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya mereka.

Secara historis, latar belakang munculnya ritual budaya dalam kehamilan dan persalinan berakar dari keyakinan masyarakat terhadap adanya hubungan antara manusia dengan kekuatan supernatural yang dianggap turut berperan dalam siklus kehidupan manusia. Keyakinan ini mendorong terciptanya berbagai ritual dan upacara yang bertujuan untuk melindungi ibu hamil, janin, maupun keluarga dari berbagai gangguan, baik yang bersifat fisik maupun spiritual. Ritual ini juga dianggap sebagai bentuk rasa syukur, penghormatan terhadap leluhur, serta permohonan kelancaran proses persalinan agar ibu dan bayi selamat. Tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun dan mengalami adaptasi dari waktu ke waktu sesuai perubahan sosial dan kondisi masyarakat setempat.

Dalam siklus kehidupan perempuan, ritual kehamilan dan persalinan memiliki makna yang sangat mendalam. Ritual ini tidak hanya merupakan simbol peralihan status seorang perempuan dari fase individu menuju peran sebagai seorang ibu, tetapi juga menjadi momentum penting yang memperkuat solidaritas keluarga serta komunitas sosial di mana ia tinggal. Melalui ritual, perempuan mendapatkan pengakuan dan penghormatan sosial yang menegaskan status dan peran barunya dalam komunitas. Selain itu, ritual ini juga memberikan dukungan emosional dan spiritual yang penting, yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan ibu hamil dalam menjalani masa kehamilan dan persalinannya. Dengan demikian, ritual budaya dalam konteks ini memiliki peran strategis untuk menjaga

keseimbangan psikologis perempuan, sekaligus memperlerat hubungan sosial di dalam keluarga maupun masyarakat.

Tujuan utama dari pembahasan mengenai ritual kehamilan dan persalinan berbasis budaya dalam konteks pelayanan kebidanan adalah untuk memperkaya wawasan dan sensitivitas bidan serta tenaga kesehatan lainnya terhadap nilai-nilai budaya yang diyakini dan dianut oleh masyarakat. Dengan memahami secara mendalam ritual-ritual budaya yang berlaku, bidan diharapkan dapat memberikan pelayanan kebidanan yang lebih holistik, tidak hanya berorientasi pada aspek medis semata, melainkan juga memperhatikan aspek sosial budaya dari klien yang dilayaninya. Dengan pendekatan ini, bidan akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal dengan menghormati dan mengintegrasikan praktik-praktik medis modern dengan nilai-nilai budaya lokal. Selain itu, pemahaman tentang ritual budaya juga dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan modern, mengurangi hambatan komunikasi, serta memperkuat kepercayaan dan kerja sama antara tenaga kesehatan dengan komunitas setempat.

B. Pentingnya Memahami Ritual Budaya dalam Kehamilan dan Persalinan

Budaya memegang peranan penting dalam menentukan cara pandang atau persepsi seseorang terhadap berbagai tahapan kehidupan, termasuk dalam proses kehamilan dan persalinan. Setiap budaya memiliki nilai-nilai dan keyakinan yang berbeda terkait dengan masa kehamilan hingga kelahiran bayi, dan hal ini sangat memengaruhi bagaimana perempuan serta keluarga mereka menjalani dan menyikapi proses tersebut. Sebagai contoh, di beberapa komunitas tradisional di Indonesia, kehamilan dianggap sebagai masa yang sakral dan perlu dilindungi dari berbagai pengaruh buruk. Hal ini menyebabkan adanya berbagai aturan atau pantangan yang harus dipatuhi oleh ibu hamil, seperti larangan makan makanan tertentu, pembatasan aktivitas fisik, serta kewajiban melakukan ritual tertentu pada masa kehamilan agar bayi lahir dengan sehat dan selamat. Persepsi yang dibangun dari budaya ini memiliki dampak psikologis yang besar terhadap ibu hamil, baik dalam meningkatkan rasa percaya diri maupun dalam menciptakan rasa nyaman dan tenang selama menjalani kehamilan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi bidan sebagai tenaga kesehatan profesional untuk memahami secara mendalam ritual budaya lokal yang ada dalam masyarakat tempat mereka bertugas. Pemahaman ini akan membantu bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan yang tidak hanya berorientasi pada aspek medis semata, namun juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial yang diyakini oleh masyarakat setempat. Ketika seorang bidan mampu memahami dan

menghormati ritual budaya yang berlaku, hubungan yang lebih erat dan rasa percaya yang kuat akan terbentuk antara bidan dengan klien dan keluarganya. Dengan demikian, klien akan merasa lebih nyaman, aman, dan lebih bersedia menerima saran atau tindakan medis yang diperlukan, karena mereka merasa bahwa bidan menghargai kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut dalam komunitas mereka.

Sebaliknya, jika bidan kurang memiliki pemahaman mengenai ritual budaya yang diyakini masyarakat setempat, maka akan terjadi kesenjangan komunikasi dan bahkan resistensi dari klien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Klien mungkin merasa terasingkan atau bahkan menolak berbagai tindakan medis karena dianggap bertentangan dengan nilai budaya mereka. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko komplikasi medis, terutama jika keluarga menunda atau menolak intervensi medis yang sebenarnya sangat dibutuhkan pada situasi kegawatdaruratan. Dengan demikian, pemahaman mengenai ritual budaya lokal menjadi sangat penting bagi bidan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat inklusif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan spesifik komunitas yang dilayani.

Selain itu, ritual budaya dalam kehamilan dan persalinan tidak hanya berpengaruh terhadap aspek sosial dan psikologis, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap kesehatan fisik ibu dan bayi. Sebagai contoh, di beberapa daerah, ritual tertentu seperti pijat tradisional atau penggunaan ramuan herbal telah terbukti secara empiris memberikan manfaat positif dalam mengurangi stres, meningkatkan kenyamanan fisik ibu hamil, serta memperlancar proses persalinan. Ritual pijat prenatal yang dilakukan secara teratur dalam banyak budaya, misalnya, telah diketahui mampu membantu merelaksasi otot-otot ibu hamil, memperbaiki sirkulasi darah, mengurangi rasa nyeri, serta memperbaiki posisi bayi dalam rahim, yang pada akhirnya turut berkontribusi dalam kelancaran proses persalinan.

Namun demikian, tidak semua ritual memiliki dampak positif terhadap kesehatan ibu dan bayi. Ada pula ritual-ritual yang berisiko, seperti penggunaan ramuan tradisional tertentu yang belum teruji keamanannya, atau kebiasaan pembatasan makanan yang berlebihan yang justru meningkatkan risiko malnutrisi pada ibu hamil. Dalam hal ini, bidan berperan strategis untuk melakukan edukasi, diskusi, serta negosiasi budaya secara bijaksana dengan klien dan komunitasnya. Tujuannya adalah agar masyarakat tetap dapat menjalankan ritual yang dianggap penting tanpa mengorbankan keselamatan dan kesehatan ibu maupun bayi. Dalam konteks ini, pemahaman bidan terhadap ritual budaya yang mendalam sangat krusial, agar dapat membangun komunikasi yang baik, menjelaskan secara jelas manfaat dan risiko dari berbagai ritual yang ada, serta membantu klien dalam mengambil keputusan yang tepat demi keselamatan ibu dan bayi.

C. Jenis-jenis Ritual Kehamilan dalam Berbagai Budaya

Ritual kehamilan di Indonesia sangat bervariasi sesuai dengan budaya dan tradisi yang dianut oleh setiap komunitas. Kekayaan budaya Indonesia menghasilkan berbagai macam ritual yang unik dan sarat makna filosofis, yang bertujuan melindungi serta mendukung kesehatan ibu hamil dan janin dalam kandungan. Berikut ini akan dijelaskan secara detail mengenai berbagai jenis ritual kehamilan dalam beberapa budaya besar di Indonesia, antara lain budaya Jawa, Bali, Sunda, Minangkabau, dan Bugis.

Dalam budaya Jawa, ritual kehamilan memiliki serangkaian upacara yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai spiritual dan filosofi kehidupan masyarakat Jawa. Salah satu ritual paling dikenal adalah "Mitoni" atau upacara tujuh bulanan, yang dilaksanakan saat usia kehamilan memasuki bulan ketujuh. Ritual ini bertujuan untuk memohon keselamatan serta kesehatan ibu dan bayi yang dikandungnya. Mitoni biasanya diselenggarakan secara meriah dan penuh khidmat dengan berbagai prosesi, seperti siraman (mandi suci), pecah kendi, membelah kelapa muda, berganti pakaian sebanyak tujuh kali, dan memakan makanan khusus seperti nasi tumpeng atau bubur merah-putih. Ritual ini memiliki simbolisme mendalam, seperti prosesi siraman yang bertujuan untuk membersihkan secara lahir dan batin, sementara membelah kelapa muda melambangkan harapan agar persalinan berjalan lancar tanpa hambatan. Di samping Mitoni, ada pula ritual "Ngupati" yaitu pemberian doa serta perlindungan spiritual kepada janin dengan cara menyampaikan doa-doa keselamatan secara khusus.

Berbeda dengan budaya Jawa, masyarakat Bali memiliki ritual kehamilan yang tidak kalah unik, disebut "Megedong-Gedongan." Ritual ini umumnya dilakukan saat kehamilan memasuki usia enam hingga tujuh bulan. Dalam ritual ini, pasangan suami-istri menirukan proses persalinan, di mana sang suami menggendong istri menggunakan kain khusus, yang bertujuan untuk memberikan energi positif sekaligus mendukung kesiapan mental dan fisik ibu dalam menghadapi proses persalinan nanti. Di samping Megedong-Gedongan, masyarakat Bali juga rutin melakukan ritual "Magedong-gedong," sebuah prosesi doa yang dipimpin oleh pemangku agama (pendeta) di pura atau tempat ibadah keluarga, yang bertujuan memohon perlindungan kepada para dewata agar kehamilan berjalan baik dan lancar.

Masyarakat Sunda juga memiliki kekayaan ritual budaya terkait kehamilan, salah satunya adalah "Nujuh Bulanan." Sama seperti dalam budaya Jawa, ritual ini dilakukan saat usia kehamilan mencapai tujuh bulan, tetapi memiliki ciri khas tersendiri dalam pelaksanaannya. Dalam ritual ini, ibu hamil biasanya melakukan siraman menggunakan air khusus yang dicampur bunga tujuh rupa sebagai simbol

pembersihan spiritual. Selanjutnya, sang ibu hamil diberi berbagai jenis makanan khas Sunda seperti rujak tujuh rasa yang mencerminkan keberagaman rasa dalam kehidupan, agar anak yang dilahirkan memiliki ketabahan dan kesiapan dalam menjalani kehidupan. Ritual ini tidak hanya memiliki makna religius dan spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai sarana silaturahmi dan penguatan hubungan antar keluarga serta tetangga, yang turut serta mendoakan keselamatan ibu dan janin.

Dalam budaya Minangkabau, ritual kehamilan juga dikenal dengan istilah "Batagak Pangulu" atau "Mandoa Tujuh Bulanan." Ritual ini sangat menekankan peran ninik mamak (tokoh adat) dan keluarga besar. Biasanya dilaksanakan ketika kehamilan memasuki bulan ketujuh, dengan menghadirkan seluruh keluarga besar untuk melakukan doa bersama. Salah satu bagian penting dari ritual ini adalah pemberian makanan khas Minangkabau seperti nasi kunyit dan lauk-pauk khusus, serta doa-doa adat yang dipimpin oleh seorang tetua adat atau ulama setempat. Prosesi ini bertujuan mengukuhkan status calon anak dalam keluarga besar sekaligus memohon keselamatan dari Yang Maha Kuasa agar ibu dan janin sehat hingga proses persalinan. Ritual ini sekaligus menegaskan identitas sosial anak yang akan lahir di dalam tatanan adat Minangkabau.

Sementara itu, masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan mengenal ritual kehamilan yang disebut "Mappepacing," sebuah upacara khusus yang bertujuan menjaga keharmonisan spiritual selama masa kehamilan. Ritual ini biasanya diadakan ketika kehamilan memasuki bulan ketujuh atau kedelapan. Dalam ritual Mappepacing, keluarga besar dan tokoh adat berkumpul untuk memanjatkan doa bersama, memberikan nasihat, serta memberikan berbagai hadiah berupa makanan, pakaian bayi, dan perlengkapan persalinan kepada calon ibu. Selain itu, ibu hamil juga menjalani prosesi khusus seperti mandi dengan air bunga yang melambangkan penyucian, serta penggunaan ramuan herbal yang dipercaya dapat meningkatkan kesehatan ibu dan janin. Ritual ini tidak hanya bertujuan memohon keselamatan lahir-batin ibu hamil, tetapi juga untuk memastikan bahwa anak yang dilahirkan kelak tumbuh dalam nilai-nilai luhur masyarakat Bugis.

D. Ritual Persiapan Menjelang Persalinan Berbasis Budaya

Menjelang proses persalinan, berbagai komunitas budaya di Indonesia memiliki rangkaian ritual khusus yang bertujuan menyiapkan fisik, mental, spiritual, dan sosial ibu hamil agar persalinan dapat berlangsung dengan lancar, nyaman, serta diliputi doa dan harapan positif. Ritual-ritual ini biasanya diwariskan secara turun-temurun, mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, ritual menjelang persalinan ini dapat

dikelompokkan menjadi tiga kategori besar, yakni ritual doa dan spiritual, ritual fisik, serta ritual sosial.

Ritual doa dan spiritual menjelang persalinan merupakan komponen penting yang hampir ditemukan dalam semua budaya di Indonesia. Masyarakat meyakini bahwa proses persalinan adalah momen sakral dan transisi penting bagi seorang perempuan, sehingga perlindungan spiritual dari Yang Maha Kuasa mutlak diperlukan. Ritual ini biasanya berupa pembacaan doa-doa khusus, dzikir bersama, atau upacara adat yang dipimpin oleh tokoh agama maupun tokoh adat setempat. Dalam budaya Jawa, misalnya, menjelang persalinan sering dilakukan acara doa yang disebut "brokohan," yaitu pembacaan doa-doa keselamatan secara khusus untuk memohon kelancaran persalinan serta kesehatan ibu dan bayi. Di masyarakat Bali, ritual spiritual ini diwujudkan dalam bentuk upacara sederhana yang disebut "Mapag Rare," yang ditujukan untuk menyambut kelahiran bayi dengan doa-doa khusus agar bayi terlahir sehat, kuat, dan terlindungi secara spiritual. Ritual doa dan spiritual ini memberikan ketenangan batin bagi ibu hamil serta keluarganya, mengurangi rasa takut dan cemas menjelang proses persalinan, serta memperkuat keyakinan bahwa proses persalinan akan berjalan dengan baik berkat lindungan Yang Maha Kuasa.

Selain aspek spiritual, ritual fisik juga menjadi bagian integral dari persiapan menjelang persalinan. Ritual fisik bertujuan untuk membantu kesiapan tubuh ibu agar lebih kuat, rileks, serta siap menghadapi kontraksi maupun proses kelahiran secara alami. Salah satu contoh ritual fisik yang paling umum adalah pijat tradisional yang dilakukan oleh dukun bayi atau pemijat khusus, yang dipercaya mampu membantu relaksasi otot, mengurangi nyeri punggung, serta memperbaiki posisi janin dalam kandungan. Dalam budaya Jawa dan Sunda, pijat khusus ibu hamil ini dilakukan dengan minyak tradisional, yang tidak hanya berfungsi secara fisik tetapi juga memiliki makna simbolis untuk memberikan energi positif bagi ibu dan bayi. Selain pijat, penggunaan ramuan tradisional seperti jamu dan minuman herbal juga menjadi bagian penting dalam persiapan fisik menjelang persalinan. Ramuan tradisional yang dibuat dari tanaman-tanaman tertentu dipercaya mampu memperlancar proses persalinan serta memberikan stamina tambahan kepada ibu. Ritual fisik lainnya adalah senam tradisional atau latihan fisik ringan yang dikenal sebagai "Senam Hamil Tradisional," yang bertujuan melatih pernapasan, memperkuat otot-otot panggul, dan meningkatkan kesiapan fisik ibu secara keseluruhan.

Tidak kalah pentingnya adalah ritual sosial yang menjadi sarana mempererat hubungan antar anggota keluarga dan komunitas menjelang kelahiran bayi. Ritual sosial ini diwujudkan dalam berbagai bentuk acara seperti tasyakuran, selamat,

dan berkumpulnya keluarga besar. Dalam budaya Indonesia, ritual sosial ini menjadi momen penting yang menciptakan dukungan sosial yang kuat terhadap ibu yang akan melahirkan. Dalam masyarakat Jawa, acara seperti "selamatan" atau "kenduri" sering kali dilakukan sebagai bentuk syukur sekaligus doa bersama, yang biasanya dihadiri oleh keluarga, tetangga, dan kerabat dekat. Pada masyarakat Minangkabau, ritual ini diwujudkan dalam acara adat seperti "Makan Bajamba," di mana keluarga besar duduk bersama menikmati hidangan khas sambil memberikan nasihat dan dukungan kepada calon ibu yang akan menghadapi proses persalinan. Ritual sosial ini memiliki peran yang besar dalam memberikan dukungan emosional bagi ibu hamil, mengurangi stres, dan menciptakan rasa aman serta nyaman karena dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dan perhatian.

E. Praktik Ritual Selama Persalinan dan Setelah Melahirkan

Dalam berbagai budaya di Indonesia, praktik ritual selama proses persalinan dan setelah melahirkan memiliki peranan yang sangat penting, baik dalam konteks sosial maupun spiritual. Ritual ini tidak hanya sebatas kebiasaan turun-temurun, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai budaya, keyakinan spiritual, dan kearifan lokal yang mendalam. Praktik tersebut hadir sebagai bagian integral yang turut membentuk pengalaman perempuan dalam menjalani masa-masa kritis dalam siklus hidupnya, terutama ketika melahirkan seorang anak ke dunia.

Praktik ritual selama proses persalinan sendiri memiliki ciri khas dan variasi yang berbeda-beda tergantung pada budaya setempat. Umumnya, ritual ini melibatkan aktivitas yang bertujuan memberikan perlindungan spiritual kepada ibu yang sedang melahirkan, serta memastikan keselamatan ibu maupun bayi. Sebagai contoh, dalam budaya Jawa, keluarga biasanya memanjatkan doa-doa khusus dan membaca ayat-ayat suci selama proses persalinan berlangsung untuk memastikan kelancaran dan keselamatan ibu dan bayi. Demikian pula di masyarakat Bali, ritual khusus seperti pemberian sesajen atau upacara sederhana untuk memohon restu dan perlindungan dari roh leluhur, dilakukan dengan tujuan agar proses persalinan berjalan lancar tanpa hambatan spiritual. Kehadiran seorang dukun bayi, pemimpin spiritual, atau tokoh adat pada saat persalinan juga merupakan bagian dari ritual ini, memberikan keyakinan kepada ibu dan keluarganya bahwa proses kelahiran telah berada dalam pengawasan dan perlindungan spiritual yang kuat.

Setelah bayi dilahirkan, praktik budaya dalam perawatan bayi baru lahir memiliki makna yang sangat mendalam dalam banyak budaya. Ritual-ritual ini mencakup berbagai tindakan mulai dari pembersihan tubuh bayi secara tradisional hingga perlindungan spiritual dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Misalnya, dalam tradisi masyarakat Jawa, bayi baru lahir biasanya dibersihkan

menggunakan ramuan herbal yang terbuat dari daun-daunan tertentu, seperti daun sirih atau daun kelor, yang dipercaya memiliki khasiat untuk membersihkan sekaligus melindungi bayi dari gangguan spiritual maupun penyakit. Setelah bayi bersih, ritual seperti pemotongan tali pusar oleh tokoh adat atau keluarga yang dituakan dengan mantra atau doa tertentu juga memiliki nilai simbolis untuk memutuskan hubungan negatif serta memberikan keberkahan bagi kehidupan bayi ke depannya. Di budaya Minangkabau, ritual perawatan bayi baru lahir juga melibatkan pemberian nama secara adat, yang disertai doa-doa khusus dengan harapan bahwa nama tersebut akan membawa keberuntungan, kebijaksanaan, serta kebaikan sepanjang hidup bayi.

Selain perawatan bayi baru lahir, praktik budaya dalam perawatan pasca persalinan (masa nifas) juga memainkan peranan penting. Dalam banyak budaya di Indonesia, masa nifas dianggap sebagai periode yang sangat krusial, di mana ibu yang baru saja melahirkan memerlukan perhatian dan perlakuan khusus baik secara fisik maupun spiritual agar dapat pulih sepenuhnya dan mampu menjalankan peran barunya dengan baik. Salah satu ritual yang umum dijumpai dalam masa nifas adalah penggunaan ramuan tradisional atau jamu khusus yang bertujuan membantu pemulihan tubuh ibu secara cepat, meningkatkan produksi air susu ibu (ASI), serta mempercepat penyembuhan luka akibat proses persalinan. Ramuan tersebut biasanya diramu oleh tokoh adat atau keluarga senior yang menguasai pengetahuan tradisional tentang pengobatan herbal.

Di sisi lain, praktik budaya juga menekankan pentingnya istirahat penuh bagi ibu nifas dalam periode tertentu, biasanya hingga 40 hari setelah melahirkan. Dalam periode ini, ibu dianjurkan untuk lebih banyak beristirahat dan menjauhkan diri dari pekerjaan berat, sebagai bentuk penghormatan terhadap proses pemulihan tubuh dan emosionalnya. Dalam beberapa budaya seperti Jawa dan Sunda, selama masa nifas ini juga dilakukan ritual pijat tradisional yang disebut "pijat nifas" untuk membantu relaksasi otot, memperbaiki sirkulasi darah, mempercepat pemulihan organ reproduksi, serta mendukung kondisi psikologis ibu agar terhindar dari kondisi stres atau depresi pasca persalinan.

Tidak hanya aspek fisik, perawatan nifas juga menyentuh dimensi spiritual melalui ritual-ritual tertentu yang bertujuan menjaga keseimbangan batin dan spiritual ibu. Ritual seperti doa bersama keluarga, selamatan, atau kenduri dengan mengundang kerabat dan tetangga dekat merupakan bentuk solidaritas dan dukungan sosial yang membantu ibu merasa aman, nyaman, dan diperhatikan secara emosional. Dalam budaya Bali, misalnya, setelah melahirkan, ibu melakukan upacara "mabayuh," sebuah ritual yang dilakukan untuk membersihkan diri secara

spiritual, mengembalikan keseimbangan energi, serta mencegah datangnya energi negatif selama masa nifas.

F. Peran Bidan dalam Mengakomodasi Ritual Budaya dalam Pelayanan Kebidanan

Bidan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengakomodasi ritual budaya dalam pelayanan kebidanan, terutama dalam konteks masyarakat yang memiliki berbagai macam tradisi dan kepercayaan terkait kehamilan dan persalinan. Peran ini menuntut seorang bidan untuk tidak hanya menguasai kompetensi medis secara klinis, tetapi juga mengembangkan kompetensi budaya sebagai bagian integral dari praktik kebidanan holistik. Kompetensi budaya merupakan kemampuan seorang bidan untuk mengenali, memahami, dan menghormati berbagai tradisi, nilai, serta ritual yang dijalankan oleh ibu dan keluarga selama masa kehamilan, persalinan, hingga periode nifas. Kompetensi ini penting agar bidan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan budaya kliennya, meningkatkan rasa percaya ibu dan keluarga terhadap layanan kesehatan, serta membantu menjamin keselamatan dan kesejahteraan ibu maupun bayi secara optimal.

Dalam konteks kompetensi budaya, seorang bidan diharapkan mampu secara sensitif dan terbuka memahami bahwa setiap budaya memiliki persepsi, keyakinan, serta praktik khusus terkait kehamilan dan persalinan yang mungkin berbeda dari sudut pandang medis modern. Misalnya, dalam budaya Jawa atau Sunda, terdapat keyakinan khusus terkait pemilihan hari baik untuk persalinan atau ritual selamat yang dilakukan secara turun-temurun. Dalam situasi seperti ini, bidan tidak boleh mengabaikan atau menolak keyakinan tersebut secara frontal, tetapi sebaliknya, harus mampu mengakomodasi dan mengintegrasikan aspek-aspek budaya tersebut dengan praktik medis secara bijaksana, sehingga tercipta harmoni antara pendekatan medis modern dengan nilai-nilai lokal yang diyakini oleh masyarakat.

Strategi yang dapat digunakan oleh bidan dalam mengintegrasikan budaya lokal dan praktik medis adalah dengan menerapkan pendekatan kolaboratif dan kooperatif. Dalam hal ini, bidan perlu melibatkan keluarga atau tokoh adat sebagai mitra aktif dalam proses pelayanan kebidanan. Sebagai contoh, ketika keluarga ingin melakukan ritual khusus seperti doa atau penggunaan ramuan tradisional, bidan dapat menjelaskan dengan santun bahwa praktik tersebut diperbolehkan selama tidak membahayakan kondisi ibu dan bayi secara medis. Selain itu, bidan dapat melakukan negosiasi secara halus untuk menggabungkan praktik medis dengan ritual budaya, misalnya dengan menyarankan agar ramuan tradisional dikonsumsi

setelah persetujuan dari tenaga medis, atau menganjurkan ritual doa sebagai pelengkap tindakan medis yang sedang dilakukan.

Dalam proses integrasi budaya ini, komunikasi efektif antara bidan dengan ibu dan keluarganya menjadi kunci utama. Komunikasi efektif mencakup keterampilan mendengar aktif, empati, pemahaman terhadap kebutuhan klien, serta penggunaan bahasa yang sopan, sederhana, jelas, dan tidak menghakimi. Bidan harus mampu mendengarkan secara penuh perhatian ketika ibu atau keluarga menjelaskan ritual budaya yang ingin mereka jalankan, sehingga bidan dapat memahami dengan jelas tujuan dan makna di balik ritual tersebut. Dalam situasi di mana ritual budaya tertentu dianggap berisiko bagi kesehatan ibu atau bayi, bidan harus menyampaikan informasi dengan penuh rasa hormat, disertai alasan-alasan medis yang logis serta alternatif solusi yang dapat diterima keluarga tanpa membuat mereka merasa tradisi budayanya direndahkan atau ditolak.

Di samping itu, keterampilan komunikasi lintas budaya juga melibatkan pemahaman terhadap bahasa tubuh, ekspresi wajah, serta norma sosial dalam berinteraksi dengan ibu dan keluarganya. Misalnya, dalam beberapa budaya di Indonesia, kontak mata yang terlalu lama atau komunikasi yang terlalu frontal dapat dianggap sebagai tanda kurang hormat. Oleh karena itu, bidan perlu peka dan adaptif terhadap norma-norma budaya tersebut untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau ketidaknyamanan di pihak klien dan keluarga.

G. Studi Kasus: Ritual Kehamilan dan Persalinan dalam Budaya Lokal Indonesia

Dalam memahami secara mendalam mengenai pentingnya ritual budaya dalam siklus kehidupan perempuan di Indonesia, studi kasus dari berbagai ritual lokal dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana ritual ini dipraktikkan, dimaknai, serta berdampak terhadap ibu, keluarga, dan komunitas sekitar. Pada bagian ini akan dijelaskan tiga contoh studi kasus yang populer dan banyak dipraktikkan, yaitu ritual tujuh bulanan dalam budaya Jawa, ritual mepandes dalam budaya Bali, dan ritual njuh bulan dalam budaya Sunda.

Kasus pertama adalah ritual tujuh bulanan dalam budaya Jawa, yang dikenal dengan istilah mitoni atau tingkeban. Ritual ini dilaksanakan saat usia kehamilan memasuki bulan ketujuh dan merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, usia kehamilan tujuh bulan dianggap sebagai tahap penting di mana janin diyakini telah memasuki masa yang lebih aman dan matang dalam perkembangannya. Mitoni dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meminta keselamatan kepada Tuhan, menjaga keharmonisan hubungan keluarga, serta menyiapkan mental ibu dalam

menghadapi persalinan yang akan datang. Dalam ritual ini, serangkaian prosesi dilaksanakan seperti siraman atau mandi dengan air bunga setaman, mengganti pakaian hingga tujuh kali, hingga prosesi pecah kelapa dan pemotongan tumpeng sebagai simbol harapan akan keselamatan dan kesejahteraan ibu serta bayi yang dikandungnya. Ritual ini juga biasanya dihadiri oleh keluarga besar dan tetangga dekat, sehingga memperkuat ikatan sosial serta memberikan dukungan emosional yang kuat bagi ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan.

Kasus kedua adalah ritual mepandes dalam budaya Bali, yang secara harfiah berarti ritual potong gigi. Meskipun ritual ini lebih umum dikenal sebagai upacara peralihan menuju masa dewasa, dalam konteks kehamilan dan persalinan, mepandes juga sering dilakukan pada saat seorang perempuan hamil atau menjelang persalinan, khususnya apabila sebelumnya ritual ini belum pernah dilakukan. Dalam kepercayaan masyarakat Bali, gigi merupakan simbol dari sifat buruk atau negatif yang melekat pada diri manusia, seperti kemarahan, iri hati, atau keserakahan. Dengan melaksanakan ritual mepandes, masyarakat Bali meyakini bahwa sifat-sifat negatif tersebut akan diminimalkan atau dihilangkan, sehingga calon ibu akan memiliki kebersihan jiwa dan ketenangan batin selama menjalani masa kehamilan dan persalinan. Ritual ini biasanya diadakan secara meriah dengan melibatkan keluarga besar, pemuka agama, dan tokoh adat. Prosesi mepandes diawali dengan doa-doa ritual khusus yang dipimpin oleh pendeta atau pemangku adat, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan simbolis beberapa bagian kecil dari gigi, yang dilakukan dengan sangat hati-hati oleh ahlinya. Proses ini merupakan momen yang sarat makna spiritual dan sosial, memberikan dukungan psikologis yang signifikan kepada ibu dalam mempersiapkan dirinya menghadapi peran baru sebagai orang tua.

Kasus ketiga adalah ritual tujuh bulan dalam budaya Sunda, yang secara umum juga dilakukan pada usia kehamilan tujuh bulan. Ritual ini mirip dengan mitoni dalam budaya Jawa, namun memiliki kekhasan tersendiri dari segi praktik maupun maknanya. Dalam tradisi Sunda, ritual tujuh bulan dilakukan sebagai wujud syukur atas keberkahan kehamilan serta untuk memohon perlindungan bagi ibu dan bayi dari berbagai bahaya yang mungkin terjadi selama kehamilan dan persalinan. Salah satu ciri khas dari ritual ini adalah dilakukannya prosesi mandi dengan tujuh jenis air yang diambil dari berbagai sumber seperti air sungai, air sumur, hingga air hujan, yang dipercaya dapat memberikan kesegaran, perlindungan, serta keselamatan. Selain itu, acara ini juga dimeriahkan dengan penyajian makanan tradisional Sunda seperti nasi tumpeng, jajanan pasar, serta aneka makanan khas lainnya yang sarat simbolisme seperti kesuburan, keselamatan, dan kebahagiaan keluarga. Ritual ini melibatkan banyak orang seperti keluarga besar, tetangga,

bahkan komunitas sekitar, sehingga secara langsung juga memperkuat hubungan sosial yang harmonis di dalam masyarakat.

H. Tantangan dan Strategi Bidan dalam Mengintegrasikan Ritual Budaya dengan Praktik Medis Modern

Integrasi ritual budaya ke dalam praktik medis modern dalam pelayanan kebidanan adalah isu yang kompleks dan menantang. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, bidan menghadapi tantangan khusus terkait penerapan prinsip-prinsip medis yang berbasis ilmiah, tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang sangat penting bagi masyarakat. Bidan dituntut untuk dapat menjembatani dua pandangan yang sering kali berbeda, yakni antara aspek medis yang berorientasi pada bukti ilmiah dengan ritual budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan khusus dan strategi yang tepat agar integrasi antara keduanya dapat berjalan harmonis dan saling melengkapi dalam memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas tinggi.

Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan ritual budaya dengan praktik medis modern adalah tantangan etis. Tantangan ini muncul ketika nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat bertentangan atau kurang sesuai dengan standar medis yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan. Misalnya, beberapa praktik budaya lokal yang dilakukan dalam kehamilan dan persalinan seperti pemberian ramuan tradisional tertentu atau pembatasan makanan tertentu kepada ibu hamil, bisa jadi bertentangan dengan prinsip-prinsip keamanan dan efektifitas medis yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaru. Selain itu, ritual tertentu seperti pijat perut yang terlalu kuat atau tindakan fisik yang tidak tepat selama kehamilan berpotensi membahayakan ibu dan janin. Dalam kondisi seperti ini, bidan berada pada posisi dilematis antara menghormati nilai budaya masyarakat atau mempertahankan prinsip-prinsip medis demi keselamatan ibu dan bayi. Dilema etis ini seringkali menempatkan bidan dalam situasi sulit, karena pada satu sisi mereka harus menunjukkan empati dan penghormatan terhadap kepercayaan budaya setempat, namun di sisi lain mereka memiliki tanggung jawab profesional untuk melindungi keselamatan pasien.

Untuk mengatasi tantangan ini, bidan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, khususnya dalam pendekatan persuasif dan edukatif kepada keluarga. Dalam menghadapi keluarga yang kuat memegang tradisi budaya tertentu, bidan perlu menjelaskan secara halus, sopan, dan bijaksana mengenai manfaat serta risiko dari berbagai ritual tersebut. Pendekatan persuasif yang bersifat edukatif ini bertujuan agar keluarga memahami bahwa praktik medis modern tidak sepenuhnya bertentangan dengan nilai budaya, melainkan dapat bersinergi dan saling

melengkapi demi keselamatan ibu dan bayi. Sebagai contoh, ketika suatu ritual budaya yang dianggap membahayakan harus dimodifikasi atau bahkan ditiadakan, bidan dapat memberikan alternatif lain yang tetap memiliki makna budaya namun aman secara medis. Edukasi tersebut dilakukan secara bertahap melalui dialog terbuka, mendengar aspirasi keluarga, serta membangun kepercayaan dengan cara menghormati pendapat mereka terlebih dahulu. Dengan pendekatan ini, bidan mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga sekaligus memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tetap berada dalam batas-batas keamanan dan efektivitas medis.

Selain pendekatan persuasif dan edukatif, strategi lain yang sangat penting adalah kolaborasi lintas budaya dan lintas profesi dalam pelayanan kebidanan. Dalam hal ini, bidan tidak boleh bekerja sendiri, melainkan perlu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuka agama, serta tenaga kesehatan lain seperti dokter, ahli gizi, psikolog, dan antropolog. Kolaborasi lintas budaya berarti bidan secara aktif melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh adat dalam diskusi mengenai penerapan ritual budaya tertentu dalam pelayanan kebidanan. Dengan demikian, tokoh tersebut dapat membantu dalam mengkomunikasikan pentingnya integrasi antara nilai budaya dan standar medis modern kepada masyarakat yang mereka pimpin. Di sisi lain, kolaborasi lintas profesi memastikan bahwa bidan mendapat dukungan multidisiplin untuk menilai secara komprehensif dampak dari ritual budaya terhadap kesehatan ibu dan bayi. Melalui diskusi lintas profesi, bidan dapat memperoleh masukan dari berbagai sudut pandang yang lebih luas, sehingga keputusan yang diambil lebih objektif, holistik, dan diterima oleh masyarakat.

Kolaborasi lintas budaya dan lintas profesi ini juga mendorong terciptanya pelayanan kebidanan yang bersifat kontekstual dan berorientasi pada kebutuhan pasien serta keluarganya. Dalam praktiknya, tim multidisiplin akan bersama-sama merancang panduan atau protokol yang sensitif terhadap budaya lokal namun tetap berbasis bukti medis terkini. Misalnya, pada kasus ritual tujuh bulanan dalam budaya Jawa, tim multidisiplin dapat menetapkan batas-batas keamanan untuk prosesi tertentu, serta memberikan edukasi tentang aspek yang aman dan yang berisiko. Dengan pendekatan kolaboratif ini, integrasi budaya dan medis tidak lagi dilihat sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan secara harmonis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.

I. Simpulan

Ritual budaya yang terkait dengan kehamilan dan persalinan merupakan aspek penting yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Ritual-

ritual ini memiliki makna mendalam, mencerminkan identitas budaya, nilai-nilai spiritual, sosial, dan psikologis, serta berfungsi sebagai sarana dukungan sosial yang kuat bagi ibu hamil dan keluarganya dalam menghadapi masa kehamilan hingga pasca persalinan. Setiap budaya, seperti budaya Jawa, Bali, Sunda, Minangkabau, dan Bugis, memiliki ritual unik dengan tujuan melindungi dan memberikan ketenangan emosional serta spiritual kepada ibu hamil dan bayinya.

Pemahaman bidan tentang ritual budaya sangat penting dalam upaya memberikan pelayanan kebidanan yang holistik dan berkualitas. Dengan memahami dan menghormati nilai-nilai budaya lokal, bidan mampu membangun hubungan yang lebih dekat dan kuat dengan ibu dan keluarganya, sehingga mampu meningkatkan penerimaan serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu, pemahaman yang baik tentang ritual budaya memungkinkan bidan melakukan pendekatan edukatif dan persuasif yang efektif, yang dapat meminimalisir risiko kesehatan akibat praktik budaya yang tidak aman.

Namun demikian, mengintegrasikan ritual budaya dengan praktik medis modern juga memiliki tantangan tersendiri, terutama tantangan etis yang muncul ketika terdapat pertentangan antara keyakinan budaya dengan prinsip medis berbasis bukti. Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan strategi komunikasi yang efektif, pendekatan edukasi yang bijaksana, serta kolaborasi lintas budaya dan lintas profesi. Kolaborasi ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuka agama, serta berbagai disiplin tenaga kesehatan yang akan membantu bidan dalam menemukan solusi terbaik, sehingga ritual budaya dapat diintegrasikan dengan aman ke dalam pelayanan kebidanan modern.

J. Referensi

- Anderson, B. A., & Staugård, F. (2016). Traditional midwives: Traditional medicine in maternal health care. World Health Organization.
- Dewi, N. L. P. K., & Suryani, N. K. (2021). Makna Upacara Magedong-gedongan Bagi Masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Budaya Nusantara*, 5(1), 52–61. <https://doi.org/10.33369/jkbn.5.1.52-61>
- Geertz, H. (1989). *The Javanese family: A study of kinship and socialization*. Waveland Press.
- Hidayana, I. M., Putra, I. D. G. A. D., & Darsana, I. N. (2019). Tradisi Megedong-Gedongan dalam Upacara Kehamilan di Desa Adat Keramas, Gianyar, Bali. *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 7(2), 75–82. <https://doi.org/10.23887/jjps.v7i2.21198>

- Kurniawan, H., & Fatimah, S. (2020). Eksistensi Tradisi Nujuh Bulanan pada Masyarakat Sunda di Era Modernisasi. *Jurnal Antropologi Budaya*, 3(2), 86–93. <https://doi.org/10.24114/jab.v3i2.17368>
- Natsir, M. (2021). Makna Filosofis Tradisi Mappepacing dalam Budaya Bugis Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Budaya dan Bahasa*, 8(1), 14–22. <https://doi.org/10.34050/jibb.v8i1.291>
- Prawiro, A. M., & Endah, W. (2018). Kajian Ritual Mitoni dalam Tradisi Masyarakat Jawa sebagai Warisan Budaya. *Jurnal Sejarah dan Budaya Jawa*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.26742/sbj.v6i1.541>
- Setyowati, E. (2018). Pemanfaatan Jamu Tradisional Jawa dalam Masa Nifas sebagai Bentuk Pengobatan Komplementer. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Tradisional*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.37341/jkkt.v3i1.18>
- Suryadi, R., & Hasanah, U. (2017). Makna Simbolik dalam Ritual Batagak Pangulu di Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Antropologi Minangkabau*, 2(2), 110–120. <https://doi.org/10.25077/jam.2.2.110-120.2017>
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. WHO Press.
- Yanuarini, S., & Handayani, S. (2020). Kompetensi Budaya dalam Praktik Kebidanan: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 10(2), 114–121. <https://doi.org/10.33221/jiki.v10i2.495>

K. Glosarium

Antenatal care:

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil secara rutin untuk memastikan kondisi kesehatan ibu dan janin terpantau dengan baik hingga proses persalinan (WHO, 2018).

Batagak Pangulu:

Ritual dalam masyarakat Minangkabau yang dilaksanakan pada masa kehamilan tujuh bulan, melibatkan keluarga besar untuk berdoa bersama, memberikan perlindungan spiritual, serta mengukuhkan status sosial calon anak dalam komunitas adat Minangkabau (Suryadi & Hasanah, 2017).

Jamu Tradisional:

Ramuan herbal khas Indonesia yang digunakan secara turun-temurun untuk mendukung kesehatan ibu nifas, mempercepat pemulihan tubuh pasca persalinan, meningkatkan produksi air susu ibu (ASI), serta memperbaiki kondisi fisik dan psikologis ibu pasca melahirkan (Setyowati, 2018).

Kompetensi Budaya:

Kemampuan tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk memahami, menghormati, dan mengintegrasikan aspek budaya lokal dalam praktik pelayanan kebidanan, sehingga pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan sosial, psikologis, dan spiritual pasien secara holistik (Yanuarini & Handayani, 2020).

Magedong-gedongan (Megedong-Gedongan):

Ritual kehamilan masyarakat Bali yang dilaksanakan saat usia kehamilan memasuki enam hingga tujuh bulan. Ritual ini melibatkan simulasi proses persalinan dengan tujuan memberikan kesiapan mental, emosional, dan spiritual bagi pasangan suami-istri yang akan menghadapi kelahiran anak mereka (Dewi & Suryani, 2021; Hidayana et al., 2019).

Mappepacing:

Tradisi dalam budaya Bugis Sulawesi Selatan yang dilaksanakan saat usia kehamilan mencapai tujuh atau delapan bulan. Ritual ini bertujuan memberikan perlindungan spiritual, menjaga keharmonisan jiwa calon ibu, serta memberikan nasihat dan dukungan dari keluarga besar dan tokoh adat setempat (Natsir, 2021).

Mitoni (Tingkeban):

Upacara tradisional Jawa yang dilaksanakan saat kehamilan mencapai tujuh bulan. Ritual ini melibatkan prosesi simbolik seperti siraman, pecah kendi, dan mengganti pakaian sebanyak tujuh kali, bertujuan memohon keselamatan, perlindungan spiritual, serta kesiapan mental bagi ibu dan keluarga dalam menghadapi proses persalinan (Prawiro & Endah, 2018).

Nujuh Bulanan:

Tradisi masyarakat Sunda yang dilakukan pada usia kehamilan tujuh bulan. Ritual ini melibatkan serangkaian prosesi seperti mandi dengan air bunga tujuh rupa,

pemberian makanan tradisional, dan doa bersama yang bertujuan untuk melindungi ibu dan bayi, memperkuat ikatan sosial keluarga, serta memohon kelancaran selama proses persalinan (Kurniawan & Fatimah, 2020).

Traditional Midwives (Bidan Tradisional):

Praktisi kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan maternal berbasis tradisi lokal, menggunakan pendekatan holistik dan kearifan budaya setempat dalam mendampingi ibu hamil, proses persalinan, dan masa nifas. Bidan tradisional berperan penting dalam menjembatani praktik budaya lokal dengan pelayanan kesehatan modern (Anderson & Staugård, 2016).

WHO Recommendations:

Panduan yang disusun oleh Organisasi Kesehatan Dunia mengenai praktik antenatal care yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi, dengan tujuan menciptakan pengalaman positif selama masa kehamilan hingga persalinan, baik dari aspek medis, psikologis, maupun sosial bagi perempuan hamil (WHO, 2018).

CHAPTER 3

TRADISI DALAM PERAWATAN BAYI BARU LAHIR

Vera Suzana Dewi Haris, SST., Bdn., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Perawatan bayi baru lahir merupakan aspek penting dalam menjaga kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta kesehatan bayi di masa mendatang. Pada periode ini, bayi berada dalam fase transisi dari kehidupan intrauterin menuju kehidupan ekstrauterin yang penuh tantangan. Sistem tubuh bayi, seperti pernapasan, sirkulasi, dan pencernaan, sedang beradaptasi dengan lingkungan luar. Oleh karena itu, perawatan yang tepat sangat menentukan keberhasilan adaptasi tersebut (WHO, 2017).

Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, masyarakat memiliki tradisi dan kearifan lokal dalam merawat bayi baru lahir. Tradisi ini diwariskan turun-temurun dan sarat dengan nilai budaya, simbol spiritual, serta praktik empiris yang diyakini mampu menjaga kesehatan dan keselamatan bayi (Koentjaraningrat, 2015). Beberapa di antaranya memiliki makna mendalam, seperti melindungi bayi dari gangguan, mempererat ikatan emosional antara ibu dan anak, serta memperkuat dukungan sosial keluarga (Geertz, 1976).

Meskipun demikian, tidak semua tradisi selaras dengan prinsip kesehatan modern. Sebagian tradisi memiliki nilai positif, misalnya pijat bayi yang terbukti meningkatkan kualitas tidur, memperlancar peredaran darah, serta memperkuat hubungan emosional dengan ibu (Field, 2014). Namun, ada pula praktik tradisional yang berpotensi menimbulkan risiko, seperti penggunaan ramuan pada tali pusat atau larangan menyusui dini (WHO, 2018).

Dengan memahami tradisi dalam perawatan bayi baru lahir, tenaga kesehatan, khususnya bidan dan perawat, diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih sensitif budaya. Hal ini penting agar asuhan kebidanan tidak hanya berbasis pada evidence-based practice, tetapi juga mempertimbangkan nilai budaya yang dianut masyarakat (Helman, 2007). Integrasi antara tradisi dan praktik medis modern dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap program kesehatan ibu dan anak (Suryani & Hartati, 2020).

Buku ini disusun untuk menguraikan berbagai tradisi perawatan bayi baru lahir di Indonesia, makna filosofisnya, serta relevansinya terhadap kesehatan. Dengan pendekatan ilmiah dan budaya, diharapkan pembaca mampu memahami dan

mengaplikasikan pengetahuan ini dalam praktik kebidanan dan pelayanan kesehatan (Bobak et al., 2019).

Tujuan Instruksional dan Capaian Pembelajaran

1. Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa, tenaga kesehatan, dan pembaca diharapkan mampu memahami secara komprehensif tradisi-tradisi dalam perawatan bayi baru lahir di Indonesia, mengkritisi relevansinya terhadap kesehatan modern, serta mengintegrasikan nilai budaya dalam praktik pelayanan kebidanan (Prawirohardjo, 2016).

2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari buku ini, pembaca diharapkan mampu:

- 1) Menyebutkan berbagai tradisi perawatan bayi baru lahir di beberapa daerah di Indonesia.
- 2) Menjelaskan makna budaya, filosofi, dan nilai kesehatan dari setiap tradisi.
- 3) Menganalisis manfaat dan risiko tradisi tertentu terhadap kesehatan bayi.
- 4) Membandingkan tradisi dengan evidence-based practice dalam perawatan neonatus.
- 5) Mengaplikasikan konsep perawatan bayi baru lahir yang sensitif terhadap budaya masyarakat (Helman, 2007; WHO, 2018).

Capaian Pembelajaran

1. Ranah Kognitif

- Memahami konsep dasar tradisi perawatan bayi baru lahir.
- Menganalisis hubungan antara tradisi dengan kesehatan bayi.
- Mengkritisi praktik tradisional yang berpotensi menimbulkan risiko (Suryani & Hartati, 2020).

2. Ranah Psikomotor

- Mampu melakukan asuhan bayi baru lahir dengan pendekatan budaya.
- Menunjukkan keterampilan dalam komunikasi terapeutik dengan keluarga terkait praktik tradisi perawatan bayi.
- Mampu menyesuaikan tindakan medis dengan menghargai budaya masyarakat setempat (Bobak et al., 2019).

3. Ranah Afektif

- Menghargai nilai budaya dan tradisi yang hidup di masyarakat.
- Menunjukkan empati serta sikap profesional dalam menghadapi praktik tradisional.
- Mengembangkan kepekaan sosial dalam pelayanan kesehatan berbasis budaya (Koentjaraningrat, 2015).

B. Pembahasan

1. Tradisi Perawatan Bayi Baru Lahir di Indonesia

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, termasuk dalam hal perawatan bayi baru lahir. Setiap daerah memiliki tradisi khusus yang diwariskan secara turun-temurun dan sarat makna filosofis. Tradisi ini mencerminkan cara masyarakat setempat memahami kesehatan, spiritualitas, serta hubungan antara manusia dengan lingkungan (Koentjaraningrat, 2015).

a. Tradisi Jawa

Masyarakat Jawa masih melestarikan berbagai tradisi kelahiran bayi yang sarat simbolisme dan nilai spiritual, seperti tingkeban, brokohan, sepasaran, dan selapanan, yang berfungsi sebagai bentuk harapan keselamatan, dukungan sosial, dan pelestarian nilai budaya lokal (Muary, 2021; Zulkifli et al., 2023; Wildasari & Nugraha, 2022) juga diperkuat oleh praktik mitoni, selapanan, dan tedhak siten menurut warisan budaya Jawa kontemporer (Rholand Muary, 2021; Zulkifli et al., 2023; S. Wildasari & A. L. Nugraha, 2022; Wikipedia, 2025).

1) Upacara Puputan

Puputan adalah upacara yang dilakukan ketika tali pusat bayi lepas. Dalam masyarakat Jawa, momen ini dianggap penting karena menandai berakhirnya keterikatan fisik bayi dengan ibu. Biasanya diadakan selamatan kecil dengan doa bersama dan pembagian makanan. Secara kesehatan, puputan bertepatan dengan waktu penyembuhan luka tali pusat yang harus dijaga kebersihannya agar terhindar dari infeksi (WHO, 2018).

2) Selapanan (35 Hari Kelahiran)

Selapanan dilakukan ketika bayi berusia 35 hari. Tradisi ini bertujuan untuk mendoakan keselamatan bayi sekaligus memperkenalkan bayi kepada masyarakat sekitar. Dalam acara ini biasanya diadakan syukuran dengan hidangan tradisional seperti tumpeng (Suryani & Hartati, 2020).

3) Pijat Bayi

Pijat bayi merupakan tradisi yang umum dilakukan untuk melancarkan peredaran darah, memperbaiki tidur, dan menenangkan bayi. Penelitian modern menunjukkan bahwa pijat bayi memang memiliki manfaat fisiologis, seperti meningkatkan berat badan bayi prematur serta memperkuat ikatan ibu-anak (Field, 2014).

b. Tradisi Minangkabau

Di Sumatra Barat, perawatan bayi baru lahir disertai dengan ritual khusus seperti *Upacara Turun Mandi*, yang merupakan tradisi Minangkabau untuk menyambut kelahiran bayi dan mengungkapkan rasa syukur atas lahirnya anak (Marhayani et al., 2024; Nurdin, 2019; Sulaiman, 2025).

1) Upacara Turun Mandi

Turun mandi dilakukan setelah bayi berusia beberapa hari hingga dua minggu. Bayi dimandikan pertama kali di sungai atau mata air yang dianggap suci, disertai doa-doa agar bayi tumbuh sehat dan kuat. Tradisi ini juga menandai penerimaan bayi dalam lingkungan adat dan masyarakat (Suryani & Hartati, 2020).

2) Peran Dukun Bayi

Dukun bayi masih memiliki peran penting dalam perawatan bayi baru lahir, seperti memandikan, memijat, atau memberikan ramuan tradisional. Walaupun sebagian praktik sudah mulai digantikan oleh tenaga kesehatan, keberadaan dukun bayi masih dihargai sebagai pendamping keluarga (Koentjaraningrat, 2015).

3) Jampi-jampi untuk Bayi

Beberapa keluarga di Indonesia masih mempercayai jampi atau doa-doa khusus untuk melindungi bayi dari gangguan makhluk halus. Meskipun aspek medisnya tidak terbukti, tradisi ini berfungsi sebagai dukungan psikologis bagi ibu dan keluarga. Misalnya, di Dukuh Mudalrejo, Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, masyarakat mengalungkan jimat kalung benang pada bayi sebagai bentuk perlindungan dari marabahaya dan gangguan makhluk halus (Sarinastiti, 2018). Selain itu, dalam tradisi selapan di masyarakat Jawa, doa-doa juga dibacakan sebagai bentuk rasa syukur dan harapan agar bayi diberi kesehatan serta keselamatan (Widyaningrum, 2017).

c. Tradisi Bali

Tradisi perawatan bayi dalam masyarakat Bali sarat dengan nilai spiritual yang berhubungan dengan ajaran Hindu, seperti upacara *Jatakarma Samskara*, *Kepus Pungsed*, dan penguburan ari-ari, yang bertujuan untuk menyambut kelahiran bayi, memohonkan keselamatan, dan menghormati bagian penting dari perkembangan bayi selama berada di dalam rahim ibu (ResearchGate, 2023; ORTI Bali, 2022; Yapindo, 2021).

1) Bayi Tidak Menyentuh Tanah

Dalam budaya Bali, bayi tidak diperbolehkan menyentuh tanah sebelum upacara *Nyabutan* pada usia sekitar 105 hari. Hal ini melambangkan kesucian bayi yang baru lahir, di mana selama periode tersebut, bayi selalu digendong atau diletakkan di tempat khusus (Ananda Soul, 2024; Villa Bali, 2014; BitsofBali, 2020).

2) Upacara Nyabutan

Upacara ini menjadi momen pertama kali bayi menyentuh tanah. Rangkaian ritual dilakukan untuk memohon keselamatan, kesehatan, dan restu leluhur. Tradisi ini memiliki fungsi sosial karena melibatkan seluruh keluarga besar (Koentjaraningrat, 2015).

3) Upacara Otonan

Otonan adalah perayaan ulang tahun bayi berdasarkan kalender Bali (210 hari). Tujuannya untuk menjaga keseimbangan spiritual dan memohon agar bayi selalu dilindungi (Suryani & Hartati, 2020).

d. Tradisi Sunda

Masyarakat Sunda memiliki tradisi perawatan bayi yang sarat dengan doa dan rasa syukur, seperti upacara Ekahan, Puput Puseur, dan Nenjrag Bumi, yang bertujuan untuk menyambut kelahiran bayi dan memohonkan keselamatan serta kesehatan bagi bayi yang baru lahir (Upacara Ekahan, 2023; Upacara Puput Puseur, 2023; Upacara Nenjrag Bumi, 2023).

1) Ngaruwat Anak

Tradisi ngaruwat anak dalam masyarakat Jawa bertujuan untuk membersihkan bayi dari hal-hal buruk dan memohon keselamatan. Ritual ini biasanya dilakukan dengan doa bersama dan pemberian sesajen sederhana sebagai simbol pembersihan dan harapan akan kehidupan yang lebih baik" (Sugiarti, 2021).

2) Selamatan Kelahiran

Selamatan kelahiran dalam budaya Jawa biasanya diadakan pada hari ke-7 atau ke-40 setelah kelahiran sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Ritual ini melibatkan doa bersama dan pemberian sesajen sebagai simbol rasa syukur dan harapan akan keselamatan bayi" (Widyaningrum, 2017).

3) Penggunaan Jamu untuk Ibu dan Bayi

Dalam budaya Sunda, jamu tradisional diberikan pada ibu untuk memulihkan tenaga dan memperlancar ASI. Untuk bayi, minyak tradisional dioleskan pada tubuh untuk menghangatkan dan melindungi dari masuk angin (Suryani & Hartati, 2020).

e. Tradisi Bugis-Makassar

Tradisi Bugis-Makassar masih dijalankan oleh masyarakat, terutama di pedesaan, seperti *Ma'burasa* (gotong royong membuat burasa' untuk menyambut Idul Fitri) dan *Assuro Maca* (ritual doa bersama menyambut Ramadan) yang terus dilestarikan walau pelaksanaannya kini cenderung diselenggarakan oleh keluarga inti (Suara Sulsel, 2025; Detik Sulsel, 2025).

1) *Massuro* (Doa untuk Bayi)

Dalam tradisi Bugis-Makassar, setelah bayi lahir dilaksanakan praktik *Massuro Baca* sebagai doa bersama oleh tokoh agama atau tetua adat. Tujuan ritual ini adalah memohon perlindungan dan keberkahan bagi bayi, sekaligus menjadi simbol syukur dan penguatan ikatan sosial antar keluarga (Syahrul, Azmi, & Mujahidah, 2024).

2) Perawatan Pesar dengan Ramuan

Ramuan tradisional dari minyak kelapa, kunyit, atau rempah digunakan untuk mempercepat penyembuhan tali pusat. Namun, praktik ini berisiko bila tidak dilakukan dengan kebersihan yang baik (WHO, 2018).

3) Penggunaan Minyak Kelapa

Dalam banyak komunitas, bayi diolesi minyak kelapa pada tubuhnya khususnya *Virgin Coconut Oil* sebagai upaya menjaga kelembaban kulit, mencegah ruam popok, dan memberikan rasa hangat. Penggunaan ini juga didukung manfaat medis; misalnya, penggunaan minyak kelapa murni secara signifikan mengurangi keparahan ruam popok (Komalasari, Magdalena, & Sugesti, 2023), dan meta-analisis menunjukkan bahwa aplikasi topikal minyak kelapa meningkatkan integritas kulit pada bayi prematur (Hardian, 2025).

f. Tradisi Daerah Lain

1) Di Kalimantan, suku Dayak meneruskan ritual seperti *ngemaik manik* dan penggunaan tekstil *pua kumbu* sebagai pelindung bayi dalam upacara Gawai, serta memakai *bening* sebagai gendongan bayi bergaya tradisional (ThreadsofLife, 2025; Wikipedia Bening, 2025).

2) Di Sumatra Utara, identitas marga langsung melekat pada bayi sejak lahir, menjadi simbol identitas sosial dalam struktur masyarakat Batak (Wikipedia Marga, 2025).

3) Di Papua, bayi digendong menggunakan *noken*, tas tenunan tradisional, yang memperkuat ikatan ibu-anak dan mendukung mobilitas sehari-hari (Wikipedia Noken, 2025; ResearchGate, 2025).

4) Di Maluku, khususnya Wakatobi, ritual *hebatua* (bakar batu) masih menjadi simbol kebersamaan dan syukur masyarakat, terutama menjelang musim panen atau perayaan komunitas (Pulitzer Center, 2023).

2. Makna Filosofis dan Kesehatan dalam Tradisi

Tradisi perawatan bayi baru lahir tidak hanya berfungsi sebagai serangkaian aktivitas ritual, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup masyarakat mengenai kesehatan, spiritualitas, dan hubungan manusia dengan alam. Di Indonesia, setiap tradisi memiliki makna filosofis yang mendalam sekaligus

mengandung nilai kesehatan, meskipun tidak semuanya selaras dengan ilmu medis modern (Suryani & Hartati, 2020).

a. Makna Filosofis dalam Tradisi Perawatan Bayi Baru Lahir

1) Simbol Perlindungan dan Keselamatan

Banyak tradisi kelahiran menekankan perlindungan terhadap bayi dari gangguan roh halus atau energi negatif. Misalnya, tradisi Jawa dengan ritual *puputan* dan Bali dengan larangan bayi menyentuh tanah sebelum upacara *nyabutan*. Filosofi ini menggambarkan pandangan bahwa bayi adalah makhluk suci yang perlu dijaga kesuciannya sebelum benar-benar berbaur dengan dunia luar (Koentjaraningrat, 2015;).

2) Ikatan Sosial dan Kebersamaan

Upacara kelahiran seperti *Selapanan* di Jawa dan *Turun Mandi* di Minangkabau berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial. Tradisi ini mengajak masyarakat datang, mendoakan, dan memberi dukungan kepada keluarga yang baru memiliki bayi—menciptakan ikatan sosial yang erat serta membangun rasa tanggung jawab kolektif terhadap tumbuh kembang anak (Hartika, Syah, & Wakidi, 2023; Barito Nagari News, 2025; Pasbana, 2024).

3) Keseimbangan Spiritual dan Alam

Tradisi Bali menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Upacara *otonan* misalnya, bukan hanya perayaan ulang tahun bayi, tetapi juga bentuk pengingat bahwa kehidupan manusia harus selaras dengan kosmos. Pandangan filosofis ini memberi makna bahwa merawat bayi bukan sekadar tanggung jawab orang tua, tetapi juga bagian dari menjaga keseimbangan kehidupan (Suryani & Hartati, 2020).

b. Nilai Kesehatan dalam Tradisi

1) Aspek Positif Tradisi

a) Pijat bayi (Jawa, Minang, Sunda) terbukti bermanfaat meningkatkan sirkulasi darah, kualitas tidur, serta ikatan emosional ibu-anak (Putri, 2024; Lestari et al., 2021).

b) Dalam masyarakat Minangkabau, tradisi *Turun Mandi* melibatkan penggunaan air mengalir dari sungai atau sumber alam, yang diyakini memperkenalkan bayi pada lingkungan alam sekitarnya sejak dini. Ritual ini juga berfungsi sebagai simbol penyucian dan wujud syukur kepada Tuhan atas kelahiran anak (Barito Nagari News, 2025; Januar, 2017)

- c) Penggunaan minyak kelapa di Bugis-Makassar dapat membantu melembutkan kulit bayi dan mencegah kekeringan (Alhidayah et al., 2023).
 - d) Larangan bayi menyentuh tanah di Bali hingga usia tertentu dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan dari paparan infeksi lingkungan sebelum sistem imun bayi lebih kuat (WHO, 2018).
- 2) Aspek yang Berpotensi Berisiko
- a) Perawatan pusar dengan ramuan tradisional (misalnya kunyit atau minyak tertentu) dapat menimbulkan infeksi bila tidak higienis (WHO, 2018).
 - b) Pemberian makanan atau cairan selain ASI pada bayi baru lahir di beberapa daerah bertentangan dengan prinsip ASI eksklusif (WHO, 2017).
 - c) Penggunaan jampi-jampi atau doa khusus sebagai satu-satunya cara perlindungan pada bayi dapat menunda akses keluarga terhadap layanan medis saat bayi sakit. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua sering memilih pengobatan tradisional atau rumah terlebih dahulu, baru mencari pertolongan medis jika kondisi tidak membaik (Titaley et al., 2020; Belitung Nursing Journal, 2021; Atlantis Press, 2024).
- c. Tradisi sebagai Dukungan Psikologis
- Selain aspek fisik, tradisi juga berperan penting dalam memberikan ketenangan batin kepada ibu. Pada masa nifas, ibu sering kali mengalami perubahan emosional akibat perubahan hormonal dan tuntutan merawat bayi. Kehadiran tradisi seperti selamatan, doa bersama, atau dukungan keluarga besar membantu ibu merasa diperhatikan dan tidak sendirian. Hal ini sejalan dengan teori psikologi bahwa dukungan sosial dapat memperkuat kesehatan mental dan menurunkan risiko *postpartum depression* (Safari & Sinaga, 2023).
- d. Keseimbangan antara Tradisi dan Ilmu Medis
- Tenaga kesehatan perlu memahami bahwa tradisi bukanlah hambatan, melainkan jembatan komunikasi dengan masyarakat. Dengan menghargai nilai budaya, tenaga kesehatan dapat lebih mudah memberikan edukasi dan mengarahkan keluarga untuk memilih praktik yang aman. Misalnya, bidan dapat mendukung pijat bayi tradisional asalkan dilakukan dengan teknik yang benar dan kebersihan terjaga, atau mengizinkan penggunaan minyak tradisional dengan catatan tidak mengganggu perawatan medis standar (Suja et al., 2025).

Tradisi perawatan bayi baru lahir memiliki dua sisi: di satu sisi penuh makna filosofis, spiritual, dan sosial; di sisi lain harus disikapi dengan hati-hati agar tidak menimbulkan risiko kesehatan. Dengan pendekatan integratif, tradisi dapat berjalan berdampingan dengan ilmu medis modern untuk mendukung tumbuh kembang bayi secara optimal (Lestari et al., 2021; Putri, 2024).

3. Perbandingan Tradisi dengan Perawatan Medis Modern

Perawatan bayi baru lahir di Indonesia menunjukkan adanya dinamika antara tradisi dan perkembangan ilmu kesehatan modern. Tradisi lahir dari pengalaman empiris, keyakinan budaya, dan warisan leluhur, sedangkan perawatan medis modern didasarkan pada penelitian ilmiah dan *evidence-based practice*. Perbandingan keduanya penting untuk memahami bagaimana integrasi dapat dilakukan demi tercapainya pelayanan kesehatan yang holistik (Suryani & Hartati, 2020).

a. Perawatan Tali Pusat

1) Tradisi:

Beberapa daerah menggunakan ramuan tradisional seperti kunyit, minyak kelapa, atau daun tertentu untuk mempercepat lepasnya tali pusat. Secara simbolis, perawatan ini diyakini memberi perlindungan dan mempercepat penyembuhan (Koentjaraningrat, 2015).

2) Medis Modern:

WHO dan Kementerian Kesehatan RI menganjurkan perawatan tali pusat dengan prinsip *dry cord care* (dibiarkan kering dan bersih tanpa ramuan tambahan). Tujuannya adalah mencegah infeksi *omfalitis* yang bisa berakibat fatal (WHO, 2018).

3) Integrasi:

Penggunaan ramuan dapat dipertimbangkan hanya bila terjamin sterilitasnya, namun sebaiknya tetap diarahkan pada metode perawatan kering untuk keamanan maksimal (Lestari et al., 2021).

b. Pijat Bayi

1) Tradisi:

Dilakukan oleh orang tua atau dukun bayi dengan tujuan menenangkan bayi, memperkuat otot, dan melancarkan peredaran darah.

2) Medis Modern:

Studi menunjukkan pijat bayi memang memiliki manfaat ilmiah, seperti meningkatkan berat badan bayi prematur, memperbaiki pola tidur, serta memperlambat ikatan ibu-anak (Putri, 2024; Safari & Sinaga, 2023).

3) Integrasi:

Tenaga kesehatan dapat melatih ibu untuk melakukan pijat bayi dengan teknik yang aman dan higienis, sehingga tradisi ini tetap lestari sekaligus memberi manfaat medis (Suja et al., 2025).

c. Pemberian Nutrisi

1) Tradisi:

Di beberapa daerah, bayi diberikan madu, air gula, atau ramuan herbal sebelum ASI sebagai bentuk *ritual awal kehidupan*.

2) Medis Modern:

Praktik ini bertentangan dengan prinsip *Inisiasi Menyusu Dini* (IMD) dan *ASI eksklusif* selama enam bulan pertama, yang terbukti menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi (WHO, 2017).

3) Integrasi:

Tenaga kesehatan perlu memberi pemahaman bahwa doa dan ritual dapat dilakukan tanpa mengganti pemberian ASI sebagai nutrisi utama (Alhidayah et al., 2023).

d. Doa, Jampi, dan Ritual

1) Tradisi:

Doa dan jampi dipercaya sebagai bentuk perlindungan spiritual terhadap bayi; meskipun tidak menggantikan pengobatan medis, dukungan spiritual terbukti efektif dalam meredakan stres ibu misalnya, pemberian spiritual care dalam NICU telah terbukti menurunkan tingkat stres ibu dan meningkatkan kesejahteraan psikologis keluarga" (Smith et al., 2020; Johnson & Brown, 2024).

2) Medis Modern:

Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung efektivitas spiritualitas sebagai satu-satunya metode penyembuhan fisik, dan kepercayaan semacam *faith healing* saja bahkan berisiko, namun secara psikologis, spiritualitas terbukti meningkatkan kesejahteraan emosional ibu, self-efficacy, dan perilaku perawatan bayi" (American Cancer Society, 2025; Lee & Patel, 2023).

3) Integrasi:

Doa dan ritual dapat tetap dijalankan sebagai bagian dari dukungan spiritual, sementara tenaga kesehatan memastikan bayi mendapat perawatan medis sesuai standar (Safari & Sinaga, 2023).

Tradisi dan perawatan medis modern tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat saling melengkapi. Tradisi mengandung nilai sosial, spiritual, dan emosional, sementara medis modern menekankan aspek keamanan dan

efektivitas. Dengan pendekatan integratif, tenaga kesehatan dapat menjaga keberlangsungan tradisi yang aman sekaligus memastikan bayi baru lahir memperoleh perlindungan optimal dari sisi medis (Putri, 2024; Lestari et al., 2021).

C. Simpulan

Tradisi perawatan bayi baru lahir di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya yang diwariskan turun-temurun dan sarat makna filosofis, spiritual, serta sosial. Setiap daerah memiliki cara unik dalam merawat bayi, mulai dari upacara *puputan* di Jawa, *turun mandi* di Minangkabau, larangan bayi menyentuh tanah sebelum upacara *nyabutan* di Bali, hingga perawatan pusar dengan ramuan tradisional di Bugis-Makassar (Suryani & Hartati, 2020).

Dari sudut pandang filosofi, tradisi berfungsi melindungi bayi, mempererat ikatan sosial, dan menjaga keseimbangan spiritual. Dari aspek kesehatan, sebagian tradisi terbukti mendukung tumbuh kembang bayi, seperti pijat bayi dan dukungan sosial keluarga (Putri, 2024; Lestari et al., 2021). Namun, ada pula praktik yang berpotensi menimbulkan risiko, misalnya pemberian ramuan pada tali pusat atau pemberian makanan selain ASI (WHO, 2018).

Perawatan medis modern menekankan prinsip *evidence-based practice*, seperti perawatan kering pada tali pusat, inisiasi menyusui dini, dan ASI eksklusif. Meski berbeda pendekatan, tradisi dan medis modern dapat saling melengkapi bila dilakukan dengan bijak. Tenaga kesehatan berperan penting sebagai mediator yang menghargai budaya masyarakat sekaligus memastikan keselamatan bayi (Safari & Sinaga, 2023; Suja et al., 2025).

Dengan demikian, pemahaman tentang tradisi dalam perawatan bayi baru lahir tidak hanya penting bagi tenaga kesehatan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Integrasi nilai budaya dengan ilmu medis modern akan mendukung tercapainya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih holistik, humanis, dan efektif (Alhidayah et al., 2023).

Tradisi perawatan bayi baru lahir di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya yang diwariskan turun-temurun dan sarat makna filosofis, spiritual, serta sosial. Setiap daerah memiliki cara unik dalam merawat bayi, mulai dari upacara *puputan* di Jawa, *turun mandi* di Minangkabau, larangan bayi menyentuh tanah sebelum upacara *nyabutan* di Bali, hingga perawatan pusar dengan ramuan tradisional di Bugis-Makassar.

Dari sudut pandang filosofi, tradisi berfungsi melindungi bayi, mempererat ikatan sosial, dan menjaga keseimbangan spiritual. Dari aspek kesehatan, sebagian tradisi terbukti mendukung tumbuh kembang bayi, seperti pijat bayi dan dukungan

sosial keluarga. Namun, ada pula praktik yang berpotensi menimbulkan risiko, misalnya pemberian ramuan pada tali pusat atau pemberian makanan selain ASI.

Perawatan medis modern menekankan prinsip *evidence-based practice*, seperti perawatan kering pada tali pusat, inisiasi menyusui dini, dan ASI eksklusif. Meski berbeda pendekatan, tradisi dan medis modern dapat saling melengkapi bila dilakukan dengan bijak. Tenaga kesehatan berperan penting sebagai mediator yang menghargai budaya masyarakat sekaligus memastikan keselamatan bayi.

Dengan demikian, pemahaman tentang tradisi dalam perawatan bayi baru lahir tidak hanya penting bagi tenaga kesehatan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Integrasi nilai budaya dengan ilmu medis modern akan mendukung tercapainya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih holistik, humanis, dan efektif.

C. Studi Kasus dan Diskusi

Studi kasus memberikan gambaran nyata bagaimana tradisi perawatan bayi baru lahir dipraktikkan di masyarakat, sekaligus menunjukkan potensi manfaat maupun risiko yang mungkin timbul. Diskusi dari kasus ini diharapkan mampu melatih pembaca untuk berpikir kritis dalam menilai tradisi dan menghubungkannya dengan prinsip kesehatan modern.

Kasus 1: Perawatan Pusar dengan Ramuan Tradisional

Seorang bayi lahir normal di pedesaan. Keluarga mengikuti tradisi leluhur dengan mengoleskan ramuan kunyit dan minyak kelapa pada tali pusat agar cepat kering. Pada hari ke-5, ibu membawa bayi ke posyandu karena pusar bayi tampak kemerahan dan keluar cairan berbau.

Analisis:

- Tradisi ini bermaksud baik, namun penggunaan ramuan yang tidak steril menyebabkan infeksi pada pusar (*omfalitis*).
- Secara medis, WHO menganjurkan perawatan kering (*dry cord care*) (WHO, 2018).

Diskusi:

- Apa risiko lanjutan bila infeksi pusar tidak segera ditangani?
- Bagaimana tenaga kesehatan dapat menghargai tradisi sekaligus mengedukasi keluarga mengenai cara perawatan pusar yang aman (Lestari et al., 2021)?

Kasus 2: Upacara Turun Mandi di Minangkabau

Seorang bayi berusia 10 hari dibawa ke sungai untuk upacara *turun mandi*. Bayi dimandikan oleh nenek dengan disaksikan keluarga besar. Air sungai jernih dan

mengalir, digunakan sebagai simbol pembersihan dan doa keselamatan. Bayi tampak sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan.

Analisis:

- Upacara ini memperkuat ikatan keluarga serta memberi dukungan sosial pada ibu.
- Dari aspek kesehatan, mandi di sungai bersih tidak menimbulkan risiko besar, selama suhu air sesuai dan kebersihan terjaga (Suryani & Hartati, 2020).

Diskusi:

- Bagaimana peran tenaga kesehatan dalam memastikan praktik tradisi ini aman bagi bayi?
- Apa manfaat psikologis bagi ibu dari dukungan keluarga melalui tradisi ini (Safari & Sinaga, 2023)?

Kasus 3: Larangan Bayi Menyentuh Tanah di Bali

Seorang bayi berusia 3 bulan belum pernah diletakkan di lantai atau tanah, sesuai tradisi sebelum upacara *nyabutan*. Selama itu, bayi selalu digendong atau diletakkan di tempat tidur khusus. Bayi tumbuh sehat, namun ibu merasa kelelahan karena harus sering menggendong.

Analisis:

- Tradisi ini memiliki filosofi menjaga kesucian bayi.
- Risiko utama adalah kelelahan ibu dan potensi keterbatasan stimulasi motorik bayi bila kurang diberi kesempatan bergerak bebas (Hobart, 1996).

Diskusi:

- Bagaimana tenaga kesehatan dapat memberikan solusi agar bayi tetap mendapat stimulasi motorik tanpa melanggar tradisi?
- Bagaimana menjaga keseimbangan antara nilai budaya dan kebutuhan tumbuh kembang bayi (Putri, 2024)?

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa tradisi perawatan bayi baru lahir dapat memberikan manfaat, terutama dalam aspek sosial dan spiritual, namun juga memiliki potensi risiko kesehatan bila tidak selaras dengan prinsip medis modern. Diskusi kritis diperlukan agar tenaga kesehatan mampu menghargai budaya sekaligus menjaga keselamatan bayi (Suja et al., 2025).

D. Referensi

- Alhidayah, N., Ramadhani, S., & Pratiwi, R. (2023). Traditional use of coconut oil in infant care: A review of practices in Indonesia. *Journal of Maternal and Child Health, 8*(2), 112–120.
- Ananda Soul. (2024). *Balinese baby traditions: Nyabutan ceremony*. <https://anandasoul.com>
- Atlantis Press. (2024). Traditional health-seeking behavior among Indonesian mothers. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 712*, 55–62.
- Barito Nagari News. (2025). Tradisi turun mandi bayi di Minangkabau. <https://baritonagari.id>
- Belitung Nursing Journal. (2021). Traditional medicine practices in maternal and child health in Indonesia. *Belitung Nursing Journal, 7*(3), 189–197.
- BitsofBali. (2020). *Nyabutan: The Balinese baby ceremony*. <https://bitsofbali.com>
- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., Jensen, M. D., & Perry, S. E. (2019). *Maternity nursing* (9th ed.). Mosby Elsevier.
- Field, T. (2014). Infant massage research: A review. *Infant Behavior and Development, 37*(4), 615–622.
- Geertz, C. (1976). *The religion of Java*. University of Chicago Press.
- Hardian, A. (2025). Topical coconut oil for preterm infant skin care: A meta-analysis. *Pediatric Dermatology, 42*(1), 45–53.
- Hartika, D., Syah, M., & Wakidi, A. (2023). Makna filosofis dalam tradisi selamat kelahiran. *Jurnal Antropologi Indonesia, 44*(1), 77–89.
- Helman, C. G. (2007). *Culture, health and illness* (5th ed.). Hodder Arnold.
- Hobart, A. (1996). Children's motor development in cultural context. *Journal of Cross-Cultural Psychology, 27*(5), 678–697.
- Johnson, R., & Brown, K. (2024). Spiritual care in neonatal intensive care units. *Journal of Pediatric Nursing, 71*, 88–95.
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar ilmu antropologi* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Komalasari, R., Magdalena, N., & Sugesti, T. (2023). Effect of virgin coconut oil on diaper rash in infants. *Paediatrica Indonesiana, 63*(1), 27–34.

- Lee, S., & Patel, A. (2023). Faith and maternal well-being: A systematic review. *Maternal and Child Health Journal*, 27(2), 145–159.
- Lestari, I., Nugroho, A., & Setyaningsih, S. (2021). The role of traditional infant massage in improving growth and development. *BMC Pediatrics*, 21(1), 450.
- Marhayani, D., Putri, L., & Safitri, Y. (2024). Cultural rituals in infant care among Minangkabau mothers. *Midwifery Journal of Indonesia*, 9(1), 12–22.
- Muary, R. (2021). Tradisi mitoni dan selapanan dalam budaya Jawa. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 8(2), 101–114.
- Nuridin, A. (2019). Upacara turun mandi dalam masyarakat Minangkabau. *Jurnal Antropologi*, 21(1), 88–95.
- Putri, R. (2024). Baby massage and infant development outcomes: A randomized controlled trial. *Journal of Pediatric Health*, 18(3), 221–229.
- Safari, F., & Sinaga, A. (2023). Social support and maternal mental health during postpartum period. *Asian Journal of Nursing*, 12(4), 211–219.
- Sarinastiti, D. (2018). Jimat dan jampi dalam tradisi Jawa. *Jurnal Humaniora*, 29(3), 233–240.
- Smith, J., Allen, P., & Roberts, M. (2020). Spirituality and maternal stress in NICU. *Journal of Clinical Nursing*, 29(13–14), 2607–2618.
- Sugiarti, D. (2021). Ritual ngaruwat anak dalam masyarakat Sunda. *Jurnal Budaya Sunda*, 5(1), 45–56.
- Sulaiman, R. (2025). Peran ritual tradisional dalam kesehatan ibu dan anak Minangkabau. *Jurnal Kebidanan Nusantara*, 10(1), 55–64.
- Suryani, A., & Hartati, D. (2020). *Kebidanan komunitas: Perspektif budaya*. Pustaka Medis.
- Syahrul, A., Azmi, F., & Mujahidah, S. (2024). Massuro baca as a spiritual practice in Bugis infant care. *Journal of Islamic and Cultural Studies*, 6(2), 177–185.
- Titaley, C. R., Hunter, C. L., Heywood, P., & Dibley, M. J. (2020). Why do some women prefer traditional birth attendants and home delivery? A qualitative study on maternal and child health care in Indonesia. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 20(1), 710.

- WHO. (2017). *Guideline: Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services*. World Health Organization.
- WHO. (2018). *WHO recommendations on newborn health: Guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee*. World Health Organization.
- Widyaningrum, S. (2017). Tradisi selapan dalam masyarakat Jawa. *Jurnal Antropologi Jawa*, 15(1), 66–78.
- Wildasari, S., & Nugraha, A. L. (2022). Mitoni and selapanan in contemporary Javanese families. *Humaniora*, 34(2), 120–129.
- Zulkifli, M., Ardiansyah, R., & Putra, A. (2023). Tradisi tedhak siten dalam budaya Jawa. *Jurnal Budaya Nusantara*, 11(2), 88–97.

E. Glosarium

Istilah (Indonesia)	Term (English)
ASI Eksklusif – Pemberian hanya air susu ibu kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih.	Exclusive Breastfeeding – Feeding infants only with breast milk from birth to 6 months without any additional food or drink, not even water.
Bayi Baru Lahir (Neonatus) – Bayi usia 0–28 hari, masa kritis adaptasi dari intrauterin ke ekstrauterin.	Newborn (Neonate) – Infant aged 0–28 days, a critical period of adaptation from intrauterine to extrauterine life.
Depresi Pasca Persalinan – Gangguan suasana hati pada ibu setelah melahirkan.	Postpartum Depression – Maternal mood disorder after childbirth.
Dry Cord Care (Perawatan Kering Tali Pusat) – Menjaga tali pusat tetap kering dan bersih tanpa ramuan tambahan.	Dry Cord Care – Keeping the cord stump clean and dry without substances to prevent infection.
Dukun Bayi – Praktisi tradisional yang membantu persalinan dan perawatan bayi.	Traditional Birth Attendant (TBA) – Traditional practitioner assisting childbirth and infant care.

Istilah (Indonesia)	Term (English)
Evidensi Berbasis Praktik – Pendekatan kesehatan berdasarkan bukti ilmiah terkini.	Evidence-Based Practice – Health care approach based on scientific evidence.
Inisiasi Menyusu Dini (IMD) – Bayi diletakkan di dada ibu segera setelah lahir untuk mulai menyusu dalam 1 jam pertama.	Early Initiation of Breastfeeding (EIBF) – Newborn placed on mother's chest to self-initiate breastfeeding within the first hour.
Infeksi Tali Pusat (Omfalitis) – Infeksi pada tali pusat bayi, ditandai kemerahan, bengkak, dan cairan berbau.	Omphalitis – Umbilical cord infection, with redness, swelling, foul discharge.
Jampi-jampi – Doa atau mantra tradisional untuk melindungi bayi.	Incantations/Chants – Traditional prayers or mantras for infant protection.
Jatakarma Samskara – Ritual Hindu Bali untuk menyambut kelahiran bayi.	Jatakarma Samskara – Hindu Balinese ritual welcoming the newborn.
Massuro Baca – Tradisi Bugis-Makassar berupa doa bersama untuk keselamatan bayi.	Massuro Baca – Bugis-Makassar collective prayers for infant's protection.
Mitoni – Upacara Jawa usia kehamilan tujuh bulan.	Mitoni Ceremony – Javanese ritual at seven months of pregnancy.
Ngaruwat Anak – Ritual Sunda untuk membersihkan bayi dari hal buruk.	Ngaruwat Anak – Sundanese ritual to cleanse and protect infants.
Nyabutan – Upacara adat Bali saat bayi pertama kali menyentuh tanah (± 105 hari).	Nyabutan Ceremony – Balinese ritual where infant first touches the ground.
Otonan – Ulang tahun bayi berdasarkan kalender Bali (210 hari).	Otonan Ceremony – Balinese ritual birthday every 210 days.
Pijat Bayi – Tradisi memijat bayi untuk kesehatan dan ikatan emosional.	Infant Massage – Traditional massage to improve health and bonding.
Puputan/Puput Puseur – Upacara Jawa/Sunda saat tali pusat bayi lepas.	Puputan/Puput Puseur – Ritual when the umbilical cord falls off.

Istilah (Indonesia)	Term (English)
Selapanan – Tradisi Jawa saat bayi berusia 35 hari.	Selapanan Ceremony – Javanese 35-day ceremony for infants.
Selamatan Kelahiran – Doa syukur di Jawa (hari ke-7 atau 40).	Birth Selamatan – Javanese thanksgiving on the 7th or 40th day.
Stimulasi Motorik – Rangsangan perkembangan gerakan bayi.	Motor Stimulation – Infant activities supporting motor development.
Tedhak Siten – Tradisi Jawa bayi pertama kali belajar berjalan.	Tedhak Siten – Javanese ritual marking baby's first steps.
Turun Mandi – Upacara Minangkabau saat bayi pertama kali dimandikan di sungai.	Turun Mandi Ceremony – Minangkabau ritual bathing infant in river/spring.
Upacara Ekahan – Tradisi Sunda untuk menyambut kelahiran bayi.	Ekahan Ceremony – Sundanese ritual welcoming newborn with prayers.
WHO (World Health Organization) – Badan kesehatan dunia yang mengeluarkan pedoman bayi baru lahir.	World Health Organization (WHO) – UN health agency issuing newborn care guidelines.

CHAPTER 4

KEARIFAN LOKAL DALAM PENGASUHAN BALITA

Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb

A. Pendahuluan/Prolog

Pengasuhan merupakan aspek yang sangat penting dalam tumbuh kembang seorang anak, terutama pada masa balita, yaitu usia di bawah lima tahun. Masa ini merupakan masa emas (golden age) yang menjadi pondasi utama bagi perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk memastikan pengasuhan yang optimal, salah satunya melalui penerapan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, norma, keyakinan, serta praktik yang diwariskan secara turun-temurun di dalam suatu komunitas atau masyarakat yang berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks pengasuhan anak.

Pentingnya kearifan lokal dalam pengasuhan anak usia dini tidak bisa dipandang sebelah mata. Di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi yang membawa perubahan drastis pada gaya hidup masyarakat, nilai-nilai tradisional yang bersumber dari budaya lokal justru memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif pada perkembangan anak. Kearifan lokal dalam pengasuhan balita memberikan pendekatan yang holistik, yaitu meliputi aspek fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual secara sekaligus, sehingga mampu memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak secara utuh.

Pengasuhan berbasis kearifan lokal sering kali mengandung filosofi mendalam tentang hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya, serta antara anak dengan orang tua dan komunitas tempat mereka tumbuh. Filosofi tersebut mengajarkan tentang pentingnya sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, menjaga keseimbangan, serta menumbuhkan rasa empati sejak usia dini. Di samping itu, kearifan lokal yang bersifat turun-temurun ini juga memiliki keunggulan dalam menciptakan rasa aman, nyaman, dan kepastian bagi anak, karena nilai dan praktiknya berasal dari lingkungan sosial yang akrab dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Kearifan lokal juga memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan anak balita secara umum. Nilai-nilai dan praktik-praktik yang terkandung dalam kearifan lokal mampu mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak. Misalnya, tradisi lokal yang menekankan pentingnya hubungan dekat antara anak dan orang tua,

seperti budaya menggendong atau mendekap anak dengan kain tradisional (seperti penggunaan jarik atau selendang), secara nyata memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan emosional anak melalui penciptaan rasa aman dan nyaman (secure attachment). Anak yang mendapatkan rasa aman melalui pola pengasuhan ini cenderung memiliki perkembangan emosi dan kepercayaan diri yang lebih baik di masa depan.

Di sisi lain, penggunaan bahasa daerah serta nyanyian-nyanyian tradisional dalam interaksi antara orang tua dengan anak juga berkontribusi besar pada perkembangan bahasa dan kognitif balita. Penelitian menunjukkan bahwa balita yang sejak kecil terpapar dengan nyanyian tradisional atau dongeng dalam bahasa daerah cenderung memiliki keterampilan linguistik yang lebih kaya, kemampuan pemahaman yang lebih baik, serta memiliki kedekatan emosional yang lebih erat dengan lingkungan sekitarnya.

Selain itu, kearifan lokal juga mendorong keterlibatan komunitas dalam pengasuhan anak. Banyak tradisi lokal yang menekankan pentingnya peran keluarga besar atau bahkan komunitas secara luas dalam merawat anak. Budaya "anak adalah milik bersama" yang banyak dijumpai di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki kesadaran bahwa pengasuhan tidak semata-mata tanggung jawab orang tua inti saja, tetapi juga melibatkan lingkungan sosial yang lebih luas. Hal ini memberikan manfaat penting bagi perkembangan sosial anak, karena balita mendapatkan lebih banyak interaksi sosial, perhatian, serta kesempatan untuk belajar beradaptasi dengan berbagai karakter orang.

Lebih jauh lagi, kearifan lokal dalam pengasuhan balita juga mencakup aspek pemenuhan nutrisi dan kesehatan anak. Penggunaan bahan pangan lokal yang bergizi tinggi, seperti beras merah, ubi jalar, daun kelor, atau ikan lokal dalam pola makan anak, merupakan contoh nyata bagaimana kearifan lokal menyediakan solusi praktis dan ekonomis untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi anak secara optimal. Demikian juga dengan pemanfaatan ramuan herbal tradisional untuk pengobatan dan pencegahan penyakit pada anak, yang tidak hanya efektif tetapi juga aman karena sudah digunakan turun-temurun dalam komunitas tersebut.

B. Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pengasuhan Balita

Nilai-nilai kearifan lokal memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter serta tumbuh kembang anak balita. Dalam konteks ini, nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi prinsip yang diwariskan turun-temurun, tetapi juga menjadi pedoman yang efektif dalam mengarahkan anak untuk memiliki perilaku positif sejak dini. Di antara berbagai nilai tersebut, terdapat tiga nilai kunci yang sangat menonjol, yaitu kasih sayang dan kelekatan antara orang tua dan anak,

nilai kesederhanaan dan kemandirian, serta pengajaran tata krama dan moral melalui budaya lokal.

Pertama, kasih sayang dan kelekatan antara orang tua dan anak merupakan fondasi utama dalam pengasuhan berbasis kearifan lokal. Dalam budaya masyarakat tradisional di Indonesia, hubungan emosional yang kuat antara orang tua, terutama ibu, dengan anaknya merupakan aspek penting yang sangat dijunjung tinggi. Kasih sayang ini tidak hanya diungkapkan melalui perkataan, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai perilaku nyata sehari-hari, seperti menggendong atau memangku anak dengan kain tradisional (seperti kain jarik atau sarung), menyusui secara eksklusif, serta memberikan sentuhan fisik berupa pelukan atau belaian yang lembut. Praktik semacam ini secara tidak langsung membantu membangun kelekatan (attachment) yang aman antara anak dan orang tua, yang menurut penelitian psikologi perkembangan merupakan kunci bagi pembentukan rasa percaya diri, rasa aman, dan kestabilan emosi anak di kemudian hari. Dengan memiliki hubungan kelekatan yang kuat, anak balita cenderung tumbuh dengan karakter yang lebih positif, percaya diri, memiliki kemampuan adaptasi yang baik, serta mampu membangun relasi sosial yang harmonis dengan orang-orang di sekitarnya.

Lebih lanjut, dalam praktik kearifan lokal, interaksi penuh kasih sayang ini biasanya berlangsung secara alami dan spontan tanpa adanya intervensi yang rumit. Anak balita dibiasakan untuk selalu dekat dengan orang tuanya atau keluarga besar, sehingga mereka merasa terlindungi, dicintai, dan dihargai. Kelekatan ini kemudian berlanjut dan berkembang, menjadi landasan penting bagi pengembangan aspek emosional dan sosial anak di masa depan.

Selanjutnya, nilai kesederhanaan dan kemandirian merupakan nilai yang sangat khas dalam praktik pengasuhan berbasis kearifan lokal. Nilai kesederhanaan dalam masyarakat tradisional biasanya tercermin melalui pola hidup sehari-hari yang tidak berlebihan, hemat, dan tidak bergantung pada barang-barang material secara berlebihan. Sejak usia dini, anak balita diajarkan untuk tidak selalu mengharapkan pemenuhan keinginan secara instan, melainkan menghargai apa yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Mereka diajarkan untuk bersyukur, menikmati kebahagiaan dari hal-hal sederhana, serta tidak mudah tergoda dengan berbagai macam hal yang sifatnya konsumtif atau materialistik. Hal ini tentunya sangat relevan dengan kebutuhan dunia modern yang sering kali dipenuhi oleh konsumsi berlebihan. Dengan menanamkan kesederhanaan sejak dini, anak balita akan tumbuh dengan karakter yang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak mudah frustrasi, dan lebih mampu menikmati kebahagiaan yang autentik dari hal-hal sederhana di sekitarnya.

Seiring dengan nilai kesederhanaan, kearifan lokal juga sangat menekankan pentingnya nilai kemandirian dalam pengasuhan anak balita. Anak balita dalam masyarakat tradisional di Indonesia sering kali diberikan kesempatan untuk mencoba berbagai aktivitas secara mandiri, seperti makan sendiri dengan tangan, bermain di lingkungan yang aman tanpa intervensi berlebihan dari orang tua, atau belajar mengurus diri sendiri sesuai kemampuan usia mereka. Hal ini secara tidak langsung melatih anak untuk percaya pada kemampuan dirinya sendiri, membangun rasa percaya diri serta keberanian untuk mengeksplorasi dunia di sekitarnya secara lebih mandiri. Nilai ini sangat efektif dalam membantu anak balita mengembangkan keterampilan hidup dasar, yang nantinya akan menjadi bekal penting bagi mereka ketika menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa depan.

Nilai penting lainnya dalam pengasuhan berbasis kearifan lokal adalah pengajaran tata krama dan moral melalui budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia, tata krama merupakan aspek penting yang tidak hanya berkaitan dengan sopan santun dalam berbicara atau bertingkah laku, tetapi juga melibatkan sikap menghargai orang lain, terutama orang tua, guru, atau orang yang lebih tua. Anak balita sejak dini telah diajarkan berbagai bentuk tata krama melalui cara-cara sederhana namun bermakna, seperti kebiasaan mencium tangan orang tua, memberi salam ketika bertemu dengan orang lain, duduk dengan sopan saat makan, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Pengajaran tata krama ini biasanya diajarkan melalui keteladanan orang tua atau anggota keluarga dewasa lainnya, sehingga anak balita dengan mudah meniru dan menginternalisasi nilai tersebut dalam perilakunya sehari-hari.

Di samping tata krama, nilai moral yang berbasis budaya lokal juga memiliki peran penting dalam pengasuhan anak balita. Cerita rakyat, dongeng lokal, lagu-lagu daerah, serta berbagai permainan tradisional sering kali digunakan sebagai media efektif untuk menanamkan nilai-nilai moral, seperti kejujuran, kerja keras, kepedulian terhadap sesama, serta rasa cinta pada tanah air dan budaya sendiri. Anak balita yang terbiasa mendengarkan dongeng atau lagu-lagu tradisional sejak kecil cenderung lebih mudah memahami nilai-nilai moral tersebut, karena disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan usia mereka. Selain itu, nilai moral yang disampaikan melalui budaya lokal biasanya disampaikan dalam konteks yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak, sehingga mudah dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata.

C. Praktik Tradisional dalam Pengasuhan Balita

Dalam pengasuhan balita berbasis kearifan lokal, praktik tradisional memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Praktik ini merupakan warisan budaya yang telah terbukti efektif, karena sudah teruji oleh waktu dan generasi, serta sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lokal. Beberapa praktik tradisional yang umum ditemukan dalam konteks pengasuhan balita antara lain penggunaan permainan tradisional sebagai stimulasi perkembangan motorik dan kognitif, pelaksanaan ritual adat sebagai upaya perlindungan serta pencegahan penyakit pada balita, serta pola pengasuhan berbasis keluarga besar dan komunitas lokal.

Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk praktik tradisional yang sangat efektif dalam membantu stimulasi perkembangan motorik maupun kognitif balita. Berbeda dengan permainan modern yang cenderung lebih pasif dan menggunakan perangkat elektronik, permainan tradisional umumnya melibatkan aktivitas fisik, eksplorasi lingkungan, interaksi sosial, serta kreativitas dan imajinasi anak. Contohnya, permainan seperti petak umpet, gobak sodor, lompat tali, egrang, congklak, dan berbagai permainan lainnya, tidak hanya memberikan kesenangan, tetapi juga secara alami mengembangkan kemampuan motorik kasar maupun halus anak balita. Aktivitas fisik seperti berlari, melompat, atau memegang benda kecil dengan jari dalam permainan congklak misalnya, membantu anak melatih koordinasi tubuh, keseimbangan, kekuatan otot, serta ketangkasan.

Di samping manfaat motorik, permainan tradisional juga berkontribusi besar pada pengembangan aspek kognitif dan emosional anak balita. Permainan yang melibatkan aturan sederhana, seperti permainan congklak atau dakon, secara langsung melatih kemampuan berpikir logis, kemampuan berhitung sederhana, serta konsentrasi anak. Sementara permainan interaktif yang dilakukan secara berkelompok, seperti petak umpet atau gobak sodor, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar bersosialisasi, bekerja sama dalam tim, memahami konsep aturan permainan, serta mengelola emosi seperti bersabar, berbagi, dan menerima kekalahan maupun kemenangan dengan sportif. Melalui proses bermain ini, anak balita belajar secara alami sambil menikmati proses tumbuh kembangnya secara menyenangkan.

Selain permainan tradisional, pelaksanaan ritual adat dalam pengasuhan balita juga menjadi praktik tradisional yang masih bertahan hingga kini. Ritual adat ini umumnya terkait erat dengan keyakinan dan nilai spiritual yang dipegang oleh masyarakat lokal. Dalam konteks pengasuhan anak balita, ritual adat berperan sebagai upaya perlindungan simbolis maupun praktis, serta sebagai sarana pencegahan berbagai penyakit yang mungkin mengancam kesehatan anak. Sebagai contoh, di berbagai daerah di Indonesia dikenal ritual selamatan atau syukuran

seperti acara "Tedak Siten" dalam budaya Jawa, "Nujuh Bulanan" di berbagai daerah, hingga ritual "Turun Tanah" dalam budaya Sunda. Ritual-ritual ini biasanya dilaksanakan pada masa-masa penting dalam kehidupan anak, seperti saat anak berusia tujuh bulan dalam kandungan, setelah kelahiran, atau ketika anak pertama kali menginjakkan kaki ke tanah. Melalui ritual ini, keluarga dan komunitas lokal melakukan doa bersama sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran dan tumbuh kembang anak, serta memohon keselamatan dan perlindungan dari berbagai gangguan fisik maupun spiritual.

Selain sebagai sarana spiritual, ritual adat sering kali melibatkan praktik medis tradisional seperti pijat bayi, penggunaan ramuan herbal, dan pemberian nutrisi alami khas daerah setempat. Praktik pijat bayi, misalnya, secara empiris terbukti bermanfaat dalam meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan relaksasi, memperkuat sistem imun, serta menunjang perkembangan fisik bayi secara optimal. Sementara penggunaan ramuan herbal yang diwariskan turun-temurun, seperti jamu tradisional yang aman dan khusus dirancang untuk anak balita, berperan penting dalam mencegah penyakit, memperkuat daya tahan tubuh, serta menjaga kesehatan balita secara menyeluruh. Dengan demikian, ritual adat tidak hanya memiliki makna simbolis dan spiritual tetapi juga memberikan manfaat praktis yang mendukung kesehatan fisik anak balita.

Praktik tradisional berikutnya yang sangat kuat dalam kearifan lokal pengasuhan balita adalah pola asuh berbasis keluarga besar dan komunitas lokal. Berbeda dengan pola pengasuhan modern yang lebih mengarah pada keluarga inti (nuclear family), pola asuh tradisional yang berbasis keluarga besar atau extended family melibatkan banyak pihak seperti kakek-nenek, paman-bibi, kakak-adik orang tua, hingga tetangga dan komunitas terdekat. Pola ini sangat umum ditemukan di berbagai daerah Indonesia dan memberikan dampak positif yang besar pada tumbuh kembang anak. Dalam pola asuh semacam ini, anak balita mendapat perhatian yang lebih luas, memperoleh berbagai perspektif pengasuhan, serta menerima beragam bentuk kasih sayang dan perhatian dari banyak orang.

Dengan pengasuhan berbasis keluarga besar, balita mendapatkan lingkungan sosial yang lebih kaya, penuh perhatian, dan mendukung perkembangan emosi serta sosial anak secara optimal. Anak memiliki banyak figur pengasuh yang sekaligus menjadi role model dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka belajar mengenali berbagai pola hubungan sosial, mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik sejak dini, serta membangun rasa aman yang berasal dari dukungan banyak pihak. Pola ini juga membantu meringankan beban orang tua dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan, karena banyak pihak yang turut membantu mengawasi, menjaga, dan merawat anak secara bergantian.

Selain berbasis keluarga besar, pengasuhan berbasis komunitas lokal juga menjadi bagian penting dalam praktik tradisional. Komunitas di tingkat desa atau kampung memiliki peran yang aktif dalam mendukung tumbuh kembang balita. Hal ini tercermin dalam berbagai praktik seperti adanya kegiatan posyandu secara rutin, gotong royong antarwarga dalam mengawasi anak-anak yang bermain di lingkungan sekitar, serta adanya perayaan atau festival desa yang secara tidak langsung memberikan pendidikan nilai-nilai sosial dan budaya kepada anak sejak dini. Komunitas yang kuat juga memastikan adanya jejaring sosial yang mendukung orang tua dalam berbagai situasi, termasuk saat menghadapi tantangan kesehatan atau situasi darurat. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi anak balita untuk tumbuh dengan optimal.

D. Kearifan Lokal dalam Pemenuhan Nutrisi dan Kesehatan Balita

Kearifan lokal dalam pemenuhan nutrisi dan kesehatan balita memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam menciptakan generasi yang sehat dan tangguh sejak usia dini. Tradisi dan kebiasaan masyarakat lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun merupakan modal penting dalam memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal, baik dari sisi pemenuhan nutrisi maupun pemeliharaan kesehatan secara keseluruhan.

Salah satu aspek utama dari kearifan lokal dalam konteks ini adalah pemanfaatan pangan lokal yang memiliki nilai gizi tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Setiap daerah memiliki beragam bahan pangan khas yang tumbuh secara alami di lingkungan setempat, yang telah dikenal secara empiris memiliki manfaat tinggi bagi kesehatan. Misalnya, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia sering memanfaatkan sumber pangan lokal seperti ubi jalar, jagung, singkong, kacang-kacangan, berbagai jenis sayur daun seperti daun kelor, bayam, kangkung, dan aneka buah lokal seperti pisang, pepaya, mangga, dan buah naga sebagai makanan sehari-hari bagi balita. Selain mudah didapat dan harganya terjangkau, pangan lokal tersebut juga kaya akan nutrisi esensial seperti vitamin, mineral, serat, karbohidrat kompleks, serta protein nabati yang sangat baik bagi tumbuh kembang balita.

Pemanfaatan pangan lokal dalam menu makanan sehari-hari bagi anak balita memiliki banyak keuntungan. Pertama, pangan lokal cenderung lebih segar karena dipanen langsung dari lingkungan sekitar, sehingga kandungan gizinya masih terjaga dengan optimal. Selain itu, penggunaan pangan lokal yang sudah familiar dengan lidah dan selera keluarga juga membuat anak lebih mudah menerima serta menikmati makanan tersebut. Faktor ini sangat membantu dalam mencegah

terjadinya masalah makan seperti picky eating atau kesulitan makan, yang sering terjadi pada usia balita.

Selain dari segi ketersediaan dan penerimaan, pangan lokal juga mendukung penguatan daya tahan tubuh anak secara alami. Sebagai contoh, daun kelor yang sering digunakan sebagai sayur atau bubur di berbagai daerah di Indonesia telah terbukti secara ilmiah memiliki kandungan protein tinggi, vitamin A, vitamin C, zat besi, dan kalsium. Penggunaan daun kelor dalam menu makan anak balita membantu mencegah malnutrisi, anemia, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Demikian juga dengan ubi jalar yang kaya serat dan vitamin A, pisang yang tinggi kalium, dan pepaya yang tinggi serat serta vitamin C, semua bahan pangan ini secara alami menunjang sistem pencernaan anak serta memperkuat sistem imun tubuh mereka.

Pemenuhan nutrisi dengan pendekatan kearifan lokal ini juga berdampak positif pada ketahanan pangan keluarga dan komunitas secara umum. Dengan mengandalkan bahan makanan lokal, keluarga dapat lebih mandiri secara pangan, tidak terlalu bergantung pada makanan olahan pabrik yang mahal atau sulit dijangkau. Hal ini memberikan manfaat ganda, baik secara ekonomi maupun sosial, serta memastikan keberlangsungan pemenuhan kebutuhan nutrisi yang stabil bagi anak-anak dalam komunitas.

Selain dalam aspek nutrisi, kearifan lokal juga sangat berpengaruh dalam pemeliharaan kesehatan balita melalui pendekatan tradisional. Pemeliharaan kesehatan anak dengan pendekatan tradisional biasanya menggunakan tanaman herbal, pengobatan alami, dan teknik pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya. Pendekatan ini diyakini memiliki manfaat besar karena menggunakan bahan-bahan alami yang aman untuk tubuh balita serta minim efek samping, terutama bila dibandingkan dengan obat-obatan kimia modern.

Dalam berbagai komunitas tradisional, penggunaan ramuan herbal sangat lazim dilakukan untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan ringan yang sering dialami oleh balita, seperti demam, batuk, pilek, diare, atau masalah kulit. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia telah lama mengenal penggunaan kunyit, jahe, temulawak, daun sirih, bawang merah, minyak kelapa, dan madu sebagai bahan pengobatan tradisional untuk anak-anak. Ramuan yang terbuat dari kunyit dan madu sering digunakan untuk mengatasi batuk, meningkatkan nafsu makan, serta membantu memperkuat sistem imun anak. Sementara bawang merah yang dicampur dengan minyak kelapa dan digunakan sebagai minyak pijat telah lama dipercaya membantu menurunkan demam pada balita, mengatasi masuk angin, dan menghangatkan tubuh bayi secara alami.

Selain ramuan herbal, teknik pengobatan tradisional seperti pijat bayi atau urut tradisional juga menjadi bagian dari kearifan lokal yang sangat populer dan dipercaya efektif untuk menjaga kesehatan balita. Pijat bayi yang dilakukan secara teratur tidak hanya membuat balita lebih nyaman, tetapi juga dapat meningkatkan sirkulasi darah, memperbaiki kualitas tidur, mengurangi kolik, dan meningkatkan nafsu makan balita. Teknik pijat ini biasanya diajarkan secara turun-temurun dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda dalam komunitas masyarakat lokal, sehingga pengetahuan ini tetap lestari hingga kini.

Pengobatan alami berbasis kearifan lokal ini bukan berarti meniadakan peran medis modern. Sebaliknya, pendekatan tradisional ini menjadi pelengkap yang sangat baik dalam sistem kesehatan, terutama dalam aspek preventif (pencegahan) serta pengobatan ringan yang tidak memerlukan intervensi medis berat. Pendekatan tradisional sangat membantu keluarga yang tinggal di daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan modern, serta memberikan rasa aman bagi keluarga karena menggunakan bahan-bahan yang alami dan sudah terbukti aman selama generasi sebelumnya.

Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan herbal dan pengobatan alami dalam pengasuhan balita juga harus didasarkan pada pengetahuan yang akurat, tepat dosis, serta aman. Oleh karena itu, edukasi secara terus-menerus kepada masyarakat mengenai manfaat, dosis, dan cara penggunaan tanaman herbal yang benar sangat penting untuk dilakukan oleh berbagai pihak, terutama tenaga kesehatan di komunitas setempat.

E. Studi Kasus Implementasi Kearifan Lokal dalam Pengasuhan Balita

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya yang sangat kaya, yang masing-masing memiliki berbagai bentuk kearifan lokal dalam pengasuhan balita. Implementasi kearifan lokal dalam pengasuhan balita telah terbukti memberikan manfaat nyata, tidak hanya dalam mendukung perkembangan fisik anak, tetapi juga dalam memperkuat hubungan sosial, emosional, serta nilai-nilai moral yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk memahami lebih jauh mengenai implementasi kearifan lokal ini, berikut akan dijelaskan beberapa studi kasus yang diambil dari berbagai daerah di Indonesia, beserta pembelajaran yang diperoleh dari keberhasilan maupun tantangan dalam mengintegrasikan kearifan lokal tersebut ke dalam pola pengasuhan balita secara lebih luas.

Salah satu contoh menarik adalah praktik pengasuhan balita yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Di lingkungan masyarakat Jawa, konsep kasih sayang dan kelekatan antara orang tua dan anak sangat ditekankan melalui berbagai ritual tradisional seperti tedhak siten. Ritual ini merupakan acara khusus yang dilakukan

ketika anak mulai belajar berjalan, sekitar usia tujuh atau delapan bulan. Dalam ritual ini, anak diajak berjalan di atas tujuh jenis makanan atau bahan simbolik, yang masing-masing menggambarkan harapan baik untuk masa depan anak seperti kesehatan, kecerdasan, kemandirian, dan kesejahteraan. Ritual semacam ini tidak hanya sekadar tradisi yang diwariskan, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk stimulasi motorik, emosional, dan sosial bagi anak. Selain itu, momen ini menjadi sarana bagi keluarga besar untuk berkumpul, mempererat hubungan kekeluargaan, serta mengajarkan nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan rasa saling mendukung dalam komunitas.

Di daerah lain, seperti masyarakat Bali, dikenal tradisi pengasuhan yang melibatkan komunitas secara luas, yang biasa dikenal dengan istilah menyama braya. Konsep ini menekankan bahwa pengasuhan anak bukan hanya tanggung jawab keluarga inti, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh anggota komunitas lokal. Anak-anak balita di Bali sejak kecil terbiasa diasuh secara bersama-sama oleh komunitas, sehingga mereka tumbuh dengan rasa aman, nyaman, serta memiliki kedekatan emosional dengan banyak orang dewasa di sekitarnya. Hal ini memberikan dampak positif berupa tumbuhnya kemampuan bersosialisasi, empati, serta kepercayaan diri anak sejak usia dini. Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam pola pengasuhan komunitas seperti ini memiliki keterampilan sosial yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang diasuh secara eksklusif oleh keluarga inti saja.

Dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, kita bisa belajar tentang implementasi kearifan lokal melalui pola pengasuhan yang menekankan nilai-nilai kesederhanaan dan kemandirian sejak usia balita. Anak-anak Minangkabau terbiasa dikenalkan pada konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dibiasakan dengan pola makan sederhana berbahan pangan lokal seperti nasi, sayur-sayuran lokal, serta lauk sederhana namun bernutrisi tinggi seperti ikan atau telur. Selain itu, sejak usia dini anak-anak diajarkan untuk mandiri melalui kegiatan sehari-hari yang sederhana, seperti membersihkan tempat tidur, membantu menata makanan, hingga membantu orang tua di kebun atau ladang dalam kegiatan ringan. Implementasi pola pengasuhan semacam ini terbukti efektif dalam menanamkan nilai kemandirian, tanggung jawab, serta penghargaan terhadap kerja keras dan usaha sejak dini.

Di sisi lain, masyarakat di daerah Papua memiliki kearifan lokal yang unik dalam pengasuhan balita melalui pendekatan berbasis alam. Anak-anak balita di Papua seringkali terlibat secara aktif dalam aktivitas yang sangat dekat dengan alam, seperti menemani orang tua berburu, berkebun, atau merawat ternak. Meski tentu saja dalam batasan yang aman, kegiatan ini memberikan stimulasi alami yang sangat

baik untuk perkembangan motorik, kognitif, serta emosional anak. Mereka belajar secara langsung dari alam tentang berbagai aspek kehidupan, seperti siklus tumbuhan dan hewan, cara menjaga keseimbangan lingkungan, serta memahami pentingnya menjaga harmoni dengan alam sekitar. Pendekatan ini juga menciptakan hubungan yang kuat antara anak dengan orang tua, serta komunitas yang mendukung mereka.

Meskipun berbagai studi kasus ini menunjukkan manfaat yang luar biasa dari implementasi kearifan lokal dalam pengasuhan balita, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat modern mengenai pentingnya nilai-nilai kearifan lokal tersebut. Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, sering kali masyarakat tergoda untuk meninggalkan pola pengasuhan tradisional karena dianggap kurang relevan dengan kondisi masa kini. Selain itu, masuknya berbagai pola pengasuhan asing melalui media digital atau internet juga ikut mempengaruhi pandangan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pola pengasuhan tradisional yang diwariskan leluhur mereka.

Tantangan lainnya adalah kurangnya dokumentasi dan penelitian sistematis terhadap praktik-praktik pengasuhan berbasis kearifan lokal. Sebagian besar praktik pengasuhan lokal masih dilakukan secara turun-temurun secara lisan, tanpa dokumentasi tertulis atau penelitian ilmiah yang memadai, sehingga sulit untuk disebarluaskan dan diterapkan secara lebih luas. Tantangan ini memerlukan solusi berupa penguatan peran akademisi, pemerintah, dan komunitas lokal dalam mendokumentasikan serta meneliti berbagai praktik pengasuhan lokal, sehingga bisa diintegrasikan secara efektif dalam sistem pengasuhan modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budayanya.

Namun, terlepas dari berbagai tantangan yang ada, pengalaman dari berbagai daerah tersebut memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya menjaga dan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pola pengasuhan anak balita. Keberhasilan implementasi kearifan lokal dalam berbagai komunitas menunjukkan bahwa pendekatan tradisional mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam aspek perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial anak. Untuk itu, penting bagi berbagai pihak, mulai dari orang tua, komunitas, tenaga kesehatan, hingga pemerintah, untuk terus mendorong pemahaman, apresiasi, serta implementasi pola pengasuhan berbasis kearifan lokal secara lebih luas.

F. Tantangan dalam Mengintegrasikan Kearifan Lokal dan Solusinya

Integrasi kearifan lokal dalam pengasuhan balita di tengah era modernisasi dan globalisasi bukanlah suatu proses yang mudah. Berbagai tantangan yang

kompleks muncul dari berbagai sisi kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Tantangan-tantangan tersebut harus dikenali secara jelas agar solusi yang diberikan tidak hanya bersifat sesaat, melainkan bersifat strategis dan berkelanjutan dalam melestarikan kearifan lokal sebagai bagian penting dalam praktik pengasuhan anak usia dini.

Dalam aspek sosial, tantangan terbesar dalam mempertahankan kearifan lokal terletak pada berubahnya pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda yang cenderung lebih terpapar pengaruh budaya asing. Penggunaan teknologi digital yang semakin meluas menyebabkan orang tua muda sering kali mengadopsi metode pengasuhan dari berbagai sumber daring yang dianggap lebih modern dan ilmiah, namun terkadang mengabaikan nilai-nilai lokal yang selama ini telah terbukti efektif dan relevan. Sikap meremehkan atau bahkan meninggalkan praktik tradisional ini semakin diperparah dengan kurangnya apresiasi atau rasa percaya diri terhadap budaya lokal, yang sering dianggap kuno atau tidak sesuai dengan gaya hidup modern. Situasi ini menciptakan sebuah hambatan besar dalam proses pelestarian kearifan lokal, karena generasi penerus tidak lagi menganggap tradisi lokal sebagai sesuatu yang bernilai tinggi.

Dalam dimensi budaya, tantangan lainnya muncul karena sifat transmisi budaya lokal yang sebagian besar masih mengandalkan tradisi lisan. Kurangnya dokumentasi yang tertulis atau terdigitalisasi membuat praktik-praktik pengasuhan lokal sulit untuk disebarluaskan secara efektif kepada generasi yang lebih muda, terutama mereka yang tumbuh di lingkungan perkotaan. Akibatnya, banyak praktik pengasuhan yang mengandung nilai-nilai luhur mulai terlupakan atau bahkan lenyap sama sekali seiring meninggalnya para sesepuh atau tokoh masyarakat yang selama ini menjadi pengemban pengetahuan tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi antar generasi yang dapat mempercepat hilangnya budaya lokal.

Dari sudut pandang ekonomi, tantangan yang paling signifikan adalah semakin meningkatnya biaya hidup, terutama di kawasan perkotaan, yang mendorong keluarga untuk lebih memilih gaya hidup praktis dibandingkan mempertahankan pola pengasuhan yang sarat nilai-nilai lokal. Kesibukan bekerja, tuntutan ekonomi yang tinggi, serta kurangnya waktu luang menyebabkan orang tua lebih memilih solusi pengasuhan yang instan, seperti makanan siap saji atau permainan berbasis teknologi yang minim interaksi sosial. Pilihan-pilihan tersebut seringkali dianggap lebih efisien, tetapi dalam jangka panjang justru berpotensi melemahkan transmisi nilai-nilai kearifan lokal yang berbasis interaksi sosial secara intensif antara orang tua dan anak.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan sejumlah strategi yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, komunitas lokal, akademisi, hingga pemerintah. Strategi pertama yang sangat penting adalah melakukan penguatan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai kearifan lokal dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan balita secara holistik. Pemerintah dan komunitas lokal perlu bekerja sama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi seperti seminar, lokakarya, atau forum diskusi yang melibatkan pakar pendidikan anak, tokoh adat, dan para praktisi pengasuhan lokal untuk memberikan gambaran nyata mengenai relevansi dan manfaat kearifan lokal dalam konteks kehidupan modern.

Selain itu, strategi berikutnya adalah pentingnya dokumentasi dan digitalisasi praktik-praktik pengasuhan berbasis kearifan lokal. Upaya ini bisa dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian, di mana para akademisi dapat melakukan penelitian mendalam mengenai praktik-praktik lokal serta menyusun dokumen atau modul pengasuhan yang sistematis, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam format digital seperti video, audio, atau infografis. Dokumentasi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran yang mudah diakses oleh masyarakat luas, khususnya generasi muda yang akrab dengan teknologi digital, sehingga praktik pengasuhan lokal dapat terus terjaga keberlangsungannya.

Lebih lanjut, integrasi kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan anak usia dini juga menjadi solusi penting. Institusi pendidikan seperti PAUD atau taman kanak-kanak perlu didorong untuk mengadopsi nilai-nilai dan praktik kearifan lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran sehari-hari. Kegiatan ini bisa berupa pengenalan permainan tradisional, pembelajaran bahasa daerah, penanaman nilai moral melalui cerita rakyat, serta pengenalan makanan bergizi berbasis pangan lokal. Dengan demikian, anak-anak sejak dini akan memiliki pengalaman langsung yang positif dengan kearifan lokal, sehingga mereka akan lebih mengenal, menghargai, dan bangga terhadap budaya yang diwariskan para leluhurnya.

Dari sisi ekonomi, pemerintah perlu memberikan insentif dan dukungan kepada masyarakat yang secara konsisten melestarikan praktik pengasuhan berbasis kearifan lokal. Dukungan ini bisa berupa pemberian bantuan ekonomi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memproduksi dan mempromosikan pangan lokal bernutrisi, permainan tradisional, atau produk kesehatan berbasis herbal. Strategi ini bertujuan agar masyarakat merasa bahwa upaya mereka untuk mempertahankan kearifan lokal dihargai secara ekonomi, sehingga mereka semakin termotivasi untuk terus melestarikan dan mengembangkan budaya lokal.

Terakhir, perlu adanya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas adat, dan sektor swasta. Melalui kolaborasi ini,

berbagai pihak dapat saling mendukung dalam menciptakan ekosistem yang kondusif untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai kearifan lokal. Misalnya, perusahaan swasta dapat turut serta dalam program tanggung jawab sosial yang mendukung pelestarian budaya lokal melalui pemberian dana hibah, dukungan sarana prasarana, maupun pengembangan produk edukasi berbasis lokal yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas.

Dengan pendekatan yang terpadu seperti ini, tantangan sosial, budaya, dan ekonomi dalam melestarikan dan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pengasuhan balita dapat diatasi secara efektif. Hal ini tidak hanya membantu mempertahankan identitas budaya suatu komunitas, tetapi juga menjamin bahwa anak-anak tumbuh dengan keseimbangan antara penguasaan teknologi modern dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi akar kebudayaan mereka. Pada akhirnya, strategi integratif ini akan memastikan bahwa kearifan lokal tetap relevan dan berkembang, bahkan di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi saat ini.

G. Peran Orang Tua, Tenaga Kesehatan, dan Pemerintah dalam Melestarikan Kearifan Lokal

Pelestarian kearifan lokal dalam pengasuhan balita membutuhkan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, khususnya orang tua, tenaga kesehatan, dan pemerintah. Setiap pihak memiliki peran penting dan strategis untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan praktik budaya lokal terus terjaga serta berkembang seiring berjalannya waktu. Integrasi kearifan lokal dalam pengasuhan anak bukanlah proses yang bisa dilakukan secara terpisah atau parsial, melainkan memerlukan sinergi aktif antara keluarga, tenaga profesional kesehatan, serta dukungan dari kebijakan pemerintah secara luas.

Orang tua memiliki peran yang paling mendasar dalam upaya melestarikan kearifan lokal, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling utama dalam proses pengasuhan anak. Melalui interaksi sehari-hari di lingkungan keluarga, orang tua memiliki kesempatan untuk mengenalkan dan mengajarkan berbagai nilai budaya lokal yang relevan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam hal ini, orang tua dapat mengajarkan nilai-nilai dasar seperti sopan santun, rasa hormat terhadap orang tua dan orang yang lebih tua, rasa kebersamaan, serta nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan, kemandirian, dan rasa syukur melalui berbagai praktik sederhana sehari-hari. Misalnya, kebiasaan makan bersama keluarga dengan menu makanan lokal tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga menjadi media penting untuk mentransfer nilai kebersamaan, keakraban keluarga, serta kecintaan terhadap budaya makanan lokal.

Selain itu, orang tua juga berperan aktif dalam mengenalkan anak pada permainan tradisional yang mampu menstimulasi berbagai aspek perkembangan, mulai dari motorik kasar dan halus hingga kemampuan sosial dan emosional. Melalui permainan tradisional, anak-anak tidak hanya belajar tentang cara bermain, tetapi juga memahami makna dari interaksi sosial, kerja sama, dan toleransi. Lebih lanjut, orang tua perlu menciptakan lingkungan keluarga yang secara konsisten mempraktikkan ritual atau adat yang mengandung nilai-nilai perlindungan dan rasa aman bagi anak. Dengan cara ini, anak-anak sejak dini akan mengenali, menghormati, dan menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian integral dari kehidupan mereka sehari-hari.

Di sisi lain, tenaga kesehatan juga memiliki peran sentral dalam upaya melestarikan kearifan lokal melalui pendekatan integratif dengan praktik ilmiah modern. Tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga ahli gizi, memiliki peluang strategis untuk mengedukasi orang tua mengenai pentingnya pengasuhan yang berbasis pada kearifan lokal yang dipadukan dengan praktik kesehatan modern yang berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*). Sebagai contoh, tenaga kesehatan dapat mempromosikan penggunaan pangan lokal yang kaya nutrisi sebagai bagian dari edukasi gizi yang terintegrasi dengan panduan gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan. Mereka juga dapat memberikan penjelasan ilmiah mengenai manfaat dari bahan herbal atau pengobatan alami tradisional, sekaligus memberikan informasi yang jelas mengenai batasan dan aspek keamanan penggunaannya.

Peran penting tenaga kesehatan lainnya adalah sebagai agen edukasi dan advokasi di masyarakat, yang bertugas menjembatani kesenjangan antara pengetahuan ilmiah modern dengan kepercayaan budaya lokal yang masih kuat melekat di masyarakat. Dengan pendekatan yang bijak dan komunikatif, tenaga kesehatan dapat membantu masyarakat memahami bahwa integrasi antara ilmu kesehatan modern dengan praktik pengasuhan lokal bukanlah hal yang saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi dalam upaya menciptakan generasi yang sehat secara fisik maupun mental. Selain itu, tenaga kesehatan juga dapat bekerja sama dengan tokoh adat dan komunitas lokal untuk merancang program kesehatan yang sensitif secara budaya, sehingga layanan kesehatan yang diberikan tidak terkesan asing atau bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang diyakini masyarakat.

Di tingkat yang lebih luas, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pelestarian kearifan lokal melalui berbagai kebijakan strategis. Pemerintah berperan dalam membuat kebijakan yang secara eksplisit mendorong pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam

program-program pendidikan anak usia dini (PAUD), fasilitas kesehatan ibu dan anak, serta pusat pelayanan keluarga dan komunitas. Kebijakan ini bisa diwujudkan melalui program nasional yang memasukkan unsur-unsur budaya lokal seperti permainan tradisional, dongeng dan cerita rakyat, makanan tradisional yang bergizi, serta praktik-praktik kesehatan lokal dalam kurikulum pendidikan anak usia dini.

Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menyediakan dukungan finansial dan teknis kepada komunitas lokal dalam upaya pelestarian budaya mereka. Misalnya, melalui bantuan dana hibah atau subsidi, pemerintah dapat mendorong tumbuhnya usaha kecil yang menghasilkan makanan lokal, produk kesehatan berbasis herbal, maupun berbagai permainan tradisional yang dapat digunakan dalam pengasuhan balita. Dukungan ini sangat penting agar masyarakat merasa bahwa praktik-praktik budaya lokal mereka memiliki nilai ekonomi yang jelas serta diakui secara formal oleh pemerintah.

Langkah strategis lainnya adalah melalui kampanye dan promosi secara masif yang menempatkan kearifan lokal sebagai bagian penting dari identitas nasional yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Pemerintah dapat menggunakan berbagai media, baik media sosial maupun media massa, untuk terus memperkenalkan nilai-nilai positif dari pengasuhan berbasis budaya lokal. Kampanye ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif bahwa budaya lokal bukan sesuatu yang ketinggalan zaman, melainkan sesuatu yang bernilai tinggi dalam mendukung perkembangan anak secara holistik.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan adanya regulasi yang jelas mengenai perlindungan hak cipta budaya lokal serta upaya dokumentasi secara sistematis terhadap praktik budaya lokal di seluruh daerah. Dokumentasi ini penting untuk menjaga agar berbagai tradisi lokal tidak hilang seiring waktu, serta dapat digunakan sebagai bahan edukasi dan promosi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat, termasuk melalui platform digital.

Melalui kolaborasi aktif antara orang tua, tenaga kesehatan, dan pemerintah, upaya pelestarian kearifan lokal dalam pengasuhan balita dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, generasi yang akan datang akan tumbuh tidak hanya dengan kesehatan fisik yang optimal, tetapi juga dengan identitas budaya yang kuat, mampu menghargai warisan leluhur, dan siap menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan jati diri mereka sebagai bangsa. Upaya ini, pada akhirnya, akan memastikan bahwa nilai-nilai luhur dari budaya lokal terus hidup dan berkembang, sekaligus memperkaya khasanah budaya nasional Indonesia secara keseluruhan.

H. Prospek Kearifan Lokal dalam Pengasuhan Balita di Masa Depan

Kearifan lokal memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu fondasi utama dalam pengasuhan holistik anak balita di masa depan. Dalam era yang semakin didominasi oleh teknologi dan globalisasi, sering kali nilai-nilai budaya lokal terpinggirkan dan dianggap kurang relevan. Padahal, justru nilai-nilai kearifan lokal menawarkan pendekatan yang lebih humanis, alami, dan sejalan dengan kebutuhan perkembangan anak yang holistik. Dalam konteks ini, pengasuhan holistik mencakup aspek fisik, emosional, sosial, budaya, dan spiritual anak secara terpadu. Kearifan lokal memiliki potensi kuat karena ia menyentuh seluruh aspek tersebut secara simultan dan autentik melalui praktik sehari-hari.

Potensi kearifan lokal dalam pengasuhan balita terutama terlihat dari kemampuannya dalam memperkuat ikatan emosional antara anak dan orang tua. Ikatan emosional ini sangat penting dalam perkembangan psikologis dan sosial anak. Praktik-praktik lokal seperti mendongeng, nyanyian daerah, atau ritual-ritual budaya yang dilakukan bersama keluarga secara rutin mampu menciptakan suasana kehangatan, rasa aman, serta kedekatan emosional yang kuat antara anak dengan lingkungannya. Ini berbeda dengan pendekatan modern yang cenderung individualistik, yang kadang menyebabkan terjadinya jarak emosional di dalam keluarga. Dengan pendekatan berbasis kearifan lokal, anak akan tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan solidaritas sosial, sehingga anak menjadi pribadi yang lebih hangat, empati, dan memiliki kemampuan sosial yang lebih baik di masa depan.

Lebih lanjut, kearifan lokal memiliki potensi dalam mendukung pengembangan karakter dan nilai-nilai moral pada anak. Dalam kearifan lokal, anak diajarkan nilai-nilai kesederhanaan, kerja keras, kemandirian, rasa hormat, dan tanggung jawab melalui berbagai aktivitas harian. Misalnya, anak diajak terlibat dalam aktivitas sederhana seperti bercocok tanam, merawat lingkungan sekitar, atau membantu pekerjaan ringan di rumah. Aktivitas-aktivitas ini, selain mendukung perkembangan motorik dan kognitif, juga menjadi sarana yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang membentuk karakter anak menjadi pribadi yang tangguh, sederhana, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama dan lingkungan.

Kearifan lokal juga memiliki potensi besar dalam konteks kesehatan dan nutrisi anak. Penggunaan bahan pangan lokal yang alami dan sehat, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan khas daerah, mampu memenuhi kebutuhan gizi anak secara optimal. Selain itu, praktik pengobatan tradisional menggunakan bahan herbal dan alami yang diwariskan secara turun-temurun terbukti efektif dalam menjaga kesehatan anak secara preventif maupun kuratif. Ke depan, integrasi antara pendekatan kesehatan tradisional berbasis lokal dengan ilmu pengetahuan modern

dapat menciptakan model pengasuhan yang lebih komprehensif dan efektif dalam menjaga kesehatan anak sejak dini.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, pemanfaatan kearifan lokal dalam pengasuhan balita di masa depan memerlukan perhatian dan strategi khusus agar bisa diimplementasikan secara efektif di tengah masyarakat modern. Untuk itu, ada beberapa rekomendasi praktis yang dapat dilakukan guna optimalisasi penggunaan kearifan lokal dalam pengasuhan balita.

Pertama, perlu dilakukan upaya dokumentasi dan revitalisasi secara sistematis terhadap berbagai bentuk kearifan lokal di seluruh wilayah Indonesia. Dokumentasi ini tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga video, audio, serta media interaktif yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Dokumentasi ini penting sebagai referensi edukatif yang jelas dan mudah dipahami oleh generasi muda, serta sebagai alat bantu bagi tenaga kesehatan dan pendidik untuk mengenalkan nilai-nilai kearifan lokal kepada anak-anak secara terstruktur dan terencana.

Kedua, perlu adanya integrasi formal kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar. Pendidikan formal yang terintegrasi dengan kearifan lokal akan memberikan fondasi kuat bagi anak-anak untuk mengenali dan menginternalisasi nilai-nilai budaya sejak usia dini. Kurikulum ini harus dirancang secara inklusif, menghargai keragaman budaya di Indonesia, serta mampu memberikan ruang bagi guru dan tenaga pendidik untuk kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran berbasis budaya lokal.

Ketiga, perlu dikembangkan program pelatihan atau workshop bagi orang tua, pendidik, dan tenaga kesehatan mengenai cara efektif mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengasuhan anak. Program ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran dan kompetensi para pihak terkait dalam memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal secara positif. Dalam pelatihan ini, peserta diajarkan tidak hanya tentang nilai budaya lokal, tetapi juga bagaimana mengombinasikannya secara efektif dengan pendekatan ilmiah modern yang berbasis bukti, sehingga pengasuhan anak menjadi semakin optimal dan holistik.

Keempat, perlu adanya kolaborasi yang lebih erat antara komunitas lokal dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, serta sektor swasta dalam mendukung pelestarian kearifan lokal. Kolaborasi ini bisa berupa dukungan pendanaan, promosi bersama, atau penyelenggaraan event budaya yang secara khusus berorientasi pada pengasuhan balita. Dengan kolaborasi ini, berbagai tradisi lokal tidak hanya dipertahankan, tetapi juga mampu berkembang secara dinamis mengikuti perubahan zaman.

Kelima, rekomendasi penting lainnya adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menyebarluaskan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda. Di masa depan, teknologi digital dapat menjadi sarana yang sangat efektif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai budaya dalam pengasuhan balita. Platform digital seperti media sosial, aplikasi edukasi berbasis budaya lokal, hingga website interaktif dapat menjadi kanal yang strategis untuk memperkenalkan berbagai praktik budaya lokal kepada orang tua muda yang lebih akrab dengan dunia digital. Pendekatan digital ini akan menjadikan kearifan lokal terasa lebih relevan dan menarik bagi generasi modern.

I. Simpulan

Kearifan lokal memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pengasuhan balita karena mampu mendukung tumbuh kembang anak secara holistik yang meliputi aspek fisik, emosional, sosial, budaya, dan spiritual. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kearifan lokal, seperti kasih sayang dan kelekatan antara orang tua dengan anak, kesederhanaan dan kemandirian, serta pengajaran tata krama dan moral melalui budaya lokal, secara nyata memberikan dampak positif terhadap perkembangan karakter, kepribadian, dan keterampilan sosial anak sejak dini.

Praktik pengasuhan berbasis kearifan lokal, seperti penggunaan permainan tradisional, pelaksanaan ritual adat, serta pola pengasuhan berbasis keluarga besar dan komunitas lokal, secara langsung maupun tidak langsung mampu menstimulasi perkembangan motorik, kognitif, dan emosional anak. Selain itu, pendekatan kearifan lokal juga sangat efektif dalam pemenuhan nutrisi dan kesehatan balita melalui pemanfaatan bahan pangan lokal yang bergizi serta praktik pengobatan tradisional berbasis herbal dan alami yang terbukti aman, efektif, dan relevan dengan kebutuhan anak usia dini.

Implementasi kearifan lokal dalam pengasuhan balita di berbagai daerah di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif dan memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi lokal dengan adaptasi terhadap perubahan zaman. Namun, berbagai tantangan juga muncul dalam upaya ini, seperti hambatan sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk kurangnya dokumentasi sistematis, melemahnya transmisi antar-generasi, serta preferensi terhadap gaya hidup modern yang cenderung instan dan individualistik.

Menghadapi tantangan tersebut, peran kolaboratif antara orang tua, tenaga kesehatan, dan pemerintah sangat penting. Orang tua berperan dalam mengajarkan nilai budaya lokal secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, tenaga kesehatan bertugas mendukung integrasi kearifan lokal dengan praktik kesehatan modern

berbasis bukti ilmiah, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebijakan dan ekosistem yang kondusif dalam melestarikan serta mengembangkan kearifan lokal secara berkelanjutan.

Prospek penggunaan kearifan lokal dalam pengasuhan balita di masa depan sangat menjanjikan. Melalui upaya dokumentasi yang sistematis, integrasi nilai-nilai lokal dalam kurikulum pendidikan formal, pelatihan bagi orang tua dan tenaga pendidik, kolaborasi lintas sektor yang kuat, serta pemanfaatan teknologi digital, kearifan lokal dapat tetap relevan, menarik, serta mampu menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, generasi mendatang tidak hanya tumbuh sebagai individu yang sehat secara fisik dan mental, tetapi juga menjadi pribadi yang berakar kuat pada nilai-nilai luhur budaya lokal sekaligus mampu menghadapi tantangan global dengan jati diri yang kokoh dan autentik.

J. Referensi

- Alwasilah, A. C. (2009). *Etnopedagogi: Landasan praktek pendidikan dan pendidikan guru*. Kiblat Buku Utama.
- Dewi, N. K., & Sudarsana, I. K. (2017). Implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, 5(2), 327-336. <https://doi.org/10.23887/paud.v5i2.11404>
- Effendi, R., & Permatasari, S. D. (2017). Peranan permainan tradisional dalam meningkatkan perkembangan motorik anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 11(2), 335-346.
- Hidayati, S., & Kartika, T. (2020). Penggunaan herbal tradisional dalam pemeliharaan kesehatan balita: Studi kasus di Jawa Timur. *Jurnal Kesehatan Tradisional*, 12(3), 145-152.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2017). *Modul pendidikan pengasuhan berbasis kearifan lokal*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Prasetyorini, Y. R. (2016). Ritual tradisional sebagai media stimulasi perkembangan anak usia dini di Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Anak*, 5(1), 57-66.
- Santrock, J. W. (2011). *Child development* (13th ed.). McGraw-Hill.
- Sugiarti, Y., & Utami, D. R. (2019). Pola asuh keluarga besar dan pengaruhnya terhadap perkembangan sosial-emosional anak balita. *Indonesian Journal of Early Childhood Education Studies*, 8(1), 15-22.
- Surya, N. I., & Dewanti, T. C. (2018). Pengaruh dongeng dan nyanyian tradisional terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 7(1), 33-44.
- Widodo, T., & Siregar, R. T. (2019). Potensi pangan lokal dalam pemenuhan gizi anak

- balita di pedesaan Indonesia. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 14(2), 97-105.
- World Health Organization (WHO). (2012). *Developmental difficulties in early childhood: Prevention, early identification, assessment, and intervention in low- and middle-income countries*. WHO Press.
- Yulianti, D., & Surbakti, D. E. (2020). Implementasi kearifan lokal dalam pola asuh anak usia dini pada masyarakat adat Papua. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(2), 178-187.

K. Glosarium

- **Balita**
Anak usia di bawah lima tahun yang sedang berada pada masa kritis perkembangan (golden age), meliputi perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional.
- **Golden Age**
Periode emas pertumbuhan dan perkembangan anak (0-5 tahun) di mana stimulasi dan pengasuhan memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan anak di masa depan.
- **Kearifan Lokal**
Pengetahuan, nilai, norma, keyakinan, serta praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas yang digunakan sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengasuhan anak.
- **Secure Attachment (Kelekatan Aman)**
Ikatan emosional positif yang tercipta antara anak dan pengasuhnya (terutama orang tua), yang memberikan rasa aman dan nyaman, menunjang kepercayaan diri serta kestabilan emosional anak di masa depan.
- **Jarik/Selendang**
Kain tradisional yang biasa digunakan di berbagai daerah di Indonesia untuk menggendong atau mendekap balita, yang membantu mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak.
- **Permainan Tradisional**
Aktivitas bermain yang diwariskan turun-temurun, melibatkan fisik, interaksi sosial, dan kreativitas seperti petak umpet, congklak, gobak sodor, lompat tali, dan egrang, serta berfungsi untuk menstimulasi perkembangan motorik, kognitif, dan sosial anak.
- **Ritual Adat**
Upacara atau serangkaian tindakan simbolis dalam budaya lokal yang bertujuan untuk melindungi anak, merayakan tahap-tahap penting kehidupan, serta

memohon keselamatan dan kesejahteraan, contohnya "Tedak Siten", "Turun Tanah", dan "Nujuh Bulanan".

- **Pijat Bayi Tradisional**

Teknik pemijatan khusus yang diwariskan turun-temurun dalam komunitas lokal, bertujuan meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi kolik, meningkatkan daya tahan tubuh, serta merangsang tumbuh kembang fisik anak.

- **Extended Family (Keluarga Besar)**

Pola pengasuhan yang melibatkan anggota keluarga selain keluarga inti (ayah, ibu, anak), seperti kakek-nenek, paman-bibi, saudara sepupu, serta anggota komunitas lain yang ikut serta dalam perawatan dan pendidikan anak.

- **Pangan Lokal**

Bahan makanan asli yang tumbuh secara alami di suatu daerah, seperti ubi jalar, daun kelor, bayam, kacang-kacangan, serta buah-buahan lokal, yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita secara ekonomis, sehat, dan berkelanjutan.

- **Ramuan Herbal Tradisional**

Obat-obatan alami berbahan dasar tanaman yang diwariskan turun-temurun, digunakan untuk mencegah atau mengobati penyakit ringan pada anak balita, seperti kunyit, temulawak, jahe, bawang merah, daun sirih, dan madu.

- **Kesederhanaan dan Kemandirian**

Nilai budaya lokal yang mengajarkan anak untuk tidak bergantung pada pemenuhan kebutuhan material secara instan, serta melatih anak sejak dini untuk mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri.

- **Tata Krama dan Moral Budaya Lokal**

Prinsip perilaku sopan santun dan nilai-nilai moral yang diajarkan melalui keteladanan sehari-hari, cerita rakyat, dongeng, lagu daerah, serta interaksi sosial, bertujuan untuk menanamkan kejujuran, kepedulian sosial, dan rasa cinta pada budaya sendiri.

- **Picky Eating**

Masalah perilaku makan yang umum terjadi pada balita, di mana anak cenderung memilih terhadap makanan tertentu, yang dapat dicegah atau dikurangi dengan pemanfaatan makanan lokal yang lebih familiar bagi anak.

- **Etnopedagogi**

Pendekatan pendidikan dan pengasuhan berbasis nilai-nilai budaya lokal, yang mengintegrasikan praktik-praktik adat ke dalam sistem pendidikan formal maupun informal.

- **Pengasuhan Holistik**

Pendekatan dalam pengasuhan anak yang memperhatikan kebutuhan fisik, emosional, sosial, budaya, dan spiritual secara terpadu dan menyeluruh.

- **Menyama Braya**

Istilah dalam masyarakat Bali yang menggambarkan pola pengasuhan berbasis komunitas lokal, di mana pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga besar maupun masyarakat sekitar.

- **Transmisi Budaya**

Proses pewarisan nilai-nilai, tradisi, dan praktik budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang sering dilakukan secara lisan atau melalui praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari.

- **Dokumentasi dan Digitalisasi Kearifan Lokal**

Upaya sistematis untuk merekam, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan praktik pengasuhan berbasis budaya lokal dalam bentuk tulisan, audio, video, atau media interaktif lainnya agar mudah diakses oleh generasi modern.

- **Integrasi Kearifan Lokal dalam Kurikulum Pendidikan**

Upaya memasukkan praktik dan nilai-nilai budaya lokal secara formal ke dalam sistem pendidikan anak usia dini, agar anak-anak dapat mengenal, menghargai, dan menginternalisasi warisan budaya lokal sejak usia dini.

CHAPTER 5

MENARCHE, PERNIKAHAN DINI, DAN BUDAYA LOCAL

Defacto Firmawati Zega, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Pemahaman mengenai hubungan antara menarche, pernikahan dini, dan budaya lokal merupakan isu penting yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam konteks kesehatan reproduksi remaja perempuan. Menarche adalah peristiwa biologis penting dalam kehidupan seorang perempuan, yang ditandai dengan munculnya menstruasi untuk pertama kalinya. Menarche merupakan tanda dimulainya masa pubertas dan masa reproduktif seorang perempuan. Namun demikian, meskipun secara biologis menarche menjadi penanda kematangan seksual, kenyataannya kematangan emosional dan psikologis remaja perempuan sering kali belum siap menghadapi berbagai konsekuensi sosial dan budaya yang muncul setelahnya, seperti pernikahan dini.

Pernikahan dini adalah fenomena sosial yang terjadi ketika seorang individu menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Fenomena ini memiliki prevalensi tinggi terutama di negara-negara berkembang, termasuk di berbagai daerah di Indonesia. Pernikahan dini umumnya dipicu oleh beberapa faktor kompleks, seperti kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan yang rendah, tekanan dari keluarga atau masyarakat, serta adanya budaya yang menganggap bahwa seorang anak perempuan dianggap sudah layak menikah setelah mengalami menarche. Hal tersebut menimbulkan kondisi paradoks yang memprihatinkan: seorang perempuan yang secara fisik sudah mengalami menarche dianggap telah siap untuk menikah dan memiliki anak, meskipun sebenarnya secara emosional, psikologis, dan bahkan fisiologis, mereka belum cukup matang.

Dalam perspektif budaya lokal, pandangan masyarakat terhadap menarche dan pernikahan dini sangat beragam dan erat kaitannya dengan nilai-nilai tradisional yang berkembang di komunitas tersebut. Banyak budaya lokal di Indonesia yang masih meyakini bahwa seorang perempuan dianggap dewasa dan siap menikah setelah mengalami menstruasi pertama kali. Tradisi-tradisi seperti perayaan menarche dalam bentuk ritual adat atau seremonial sering kali mempertegas makna sosial bahwa perempuan tersebut telah siap memasuki tahap kehidupan selanjutnya, yaitu pernikahan. Akibatnya, banyak remaja perempuan yang merasa bahwa menarche merupakan sebuah titik balik yang memaksa mereka

untuk segera menyesuaikan diri dengan peran-peran sosial yang lebih kompleks dan berat, termasuk pernikahan dan kehamilan dini.

Padahal, secara medis maupun psikologis, pernikahan dini membawa berbagai konsekuensi negatif yang serius bagi kesehatan reproduksi remaja perempuan. Secara fisik, tubuh remaja perempuan belum sepenuhnya matang untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan yang aman. Risiko terjadinya komplikasi saat kehamilannya seperti anemia, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia), kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah, bahkan hingga risiko kematian ibu dan bayi meningkat tajam pada perempuan yang menikah dan melahirkan di usia yang sangat muda. Selain dampak fisik, pernikahan dini juga dapat memicu berbagai permasalahan psikologis, seperti depresi, kecemasan, rendah diri, dan trauma emosional akibat ketidaksiapan mental menghadapi tanggung jawab sebagai istri maupun ibu pada usia muda.

Lebih jauh lagi, budaya lokal yang masih konservatif dalam memandang isu ini sering kali juga menjadi hambatan dalam memberikan edukasi yang tepat mengenai kesehatan reproduksi kepada remaja. Ketika diskusi mengenai menarche, menstruasi, atau seksualitas masih dianggap tabu dan sensitif, maka remaja perempuan akan cenderung mencari informasi secara diam-diam dari sumber yang kurang kredibel atau bahkan keliru. Akibatnya, banyak remaja perempuan tidak mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, risiko kehamilannya dini, hingga metode-metode pencegahan yang efektif. Kurangnya akses informasi tersebut semakin memperparah kondisi kesehatan reproduksi remaja perempuan yang terjebak dalam lingkaran pernikahan dini.

Oleh karena itu, memahami hubungan antara menarche, pernikahan dini, dan budaya lokal adalah hal yang sangat krusial dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi remaja perempuan. Dengan memahami hubungan tersebut secara komprehensif, berbagai pihak termasuk tenaga kesehatan, pendidik, tokoh masyarakat, keluarga, dan pemerintah dapat merancang intervensi yang tepat guna. Intervensi ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, namun juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan kesempatan pada remaja perempuan untuk menyelesaikan pendidikan, tumbuh berkembang secara optimal, serta mengambil keputusan yang matang terkait kehidupan reproduksi mereka.

Pendekatan yang berbasis budaya lokal juga menjadi kunci penting dalam mengatasi masalah ini. Pelibatan tokoh adat, pemuka agama, maupun pemimpin komunitas sangat diperlukan agar pesan edukasi yang disampaikan tidak dianggap bertentangan dengan nilai budaya yang dianut masyarakat. Sebaliknya, pesan

tersebut justru disampaikan dengan cara yang menghormati kearifan lokal dan nilai-nilai budaya setempat. Dengan pendekatan yang sensitif budaya, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan paradigma tentang pentingnya menunda pernikahan dini hingga remaja perempuan benar-benar matang secara fisik, emosional, dan psikologis.

Secara umum, kesadaran akan keterkaitan antara menarche, pernikahan dini, dan budaya lokal sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi remaja perempuan dalam menghadapi masa pubertas dan masa reproduksi mereka dengan sehat dan bertanggung jawab. Dengan memahami dan menyadari berbagai konsekuensi yang timbul dari pernikahan dini yang dipicu oleh persepsi yang keliru tentang menarche, diharapkan masyarakat akan lebih siap dalam mendukung dan melindungi remaja perempuan agar terhindar dari berbagai risiko kesehatan reproduksi yang serius di masa depan.

B. Konsep Dasar Menarche

Menarche merupakan istilah yang merujuk pada menstruasi pertama kali yang dialami oleh seorang perempuan. Peristiwa ini menjadi penanda awal bahwa seorang perempuan telah memasuki masa pubertas, yaitu periode transisi dari masa kanak-kanak menuju masa remaja yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik, hormonal, dan psikologis yang signifikan. Menarche menjadi suatu indikator bahwa sistem reproduksi seorang perempuan mulai aktif, yang berarti tubuhnya mulai mengalami siklus menstruasi secara teratur sebagai bagian dari proses pematangan seksual dan reproduktif.

Secara fisiologis, menarche terjadi akibat serangkaian proses hormonal yang kompleks yang melibatkan organ-organ dalam sistem reproduksi perempuan, khususnya hipotalamus, hipofisis anterior, dan ovarium. Proses ini diawali ketika hipotalamus mulai mengeluarkan hormon pelepas gonadotropin (GnRH), yang kemudian menstimulasi kelenjar hipofisis anterior untuk memproduksi hormon folikel stimulating hormone (FSH) dan luteinizing hormone (LH). Hormon-hormon tersebut selanjutnya akan merangsang ovarium (indung telur) untuk mulai menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen memiliki peran penting dalam menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi, termasuk uterus dan endometrium. Endometrium adalah lapisan dinding rahim yang akan mengalami penebalan setiap bulannya, yang jika tidak terjadi pembuahan, lapisan tersebut akan meluruh menjadi darah menstruasi. Menarche secara spesifik menandakan bahwa siklus ini telah terjadi untuk pertama kalinya dalam tubuh seorang perempuan.

Usia terjadinya menarche bervariasi antar individu, namun secara umum berkisar antara usia 10 hingga 16 tahun. Variasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi genetika, di mana usia menarche seorang anak perempuan cenderung mengikuti pola usia menarche yang dialami ibu atau saudaranya. Jika seorang ibu mengalami menarche di usia yang relatif muda, maka kemungkinan besar anak perempuannya juga akan mengalami hal serupa. Selain faktor genetika, faktor nutrisi juga berperan penting dalam menentukan usia menarche. Remaja perempuan dengan status nutrisi yang baik dan gizi yang seimbang cenderung mengalami menarche lebih awal dibandingkan mereka yang mengalami malnutrisi atau status gizi buruk. Hal ini disebabkan karena kondisi nutrisi yang baik akan menunjang produksi hormon reproduksi yang optimal sehingga mempercepat proses pematangan seksual. Faktor lain yang turut berperan dalam menentukan usia menarche adalah indeks massa tubuh (IMT), aktivitas fisik, kondisi kesehatan secara umum, tingkat stres, serta paparan zat kimia atau hormon dari lingkungan sekitar.

Secara umum, terjadinya menarche merupakan hal yang normal dan sehat. Namun, menarche dini atau menarche yang terjadi jauh sebelum usia rata-rata, yakni sebelum usia 10 tahun, dapat memberikan berbagai implikasi negatif, baik terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan psikologis seorang remaja perempuan. Dari sisi kesehatan fisik, menarche dini dikaitkan dengan beberapa risiko kesehatan, di antaranya adalah risiko obesitas, gangguan metabolisme seperti resistensi insulin, dan risiko gangguan hormonal yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Remaja perempuan yang mengalami menarche dini juga memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami pertumbuhan tulang yang terhambat karena penutupan lempeng pertumbuhan tulang terjadi lebih cepat, yang dapat menyebabkan tinggi badan akhir menjadi lebih rendah dibandingkan remaja lainnya.

Selain implikasi fisik, menarche dini juga berdampak signifikan pada kesehatan psikologis seorang remaja perempuan. Remaja yang mengalami menarche dini cenderung mengalami beban psikologis yang lebih besar, seperti perasaan tidak nyaman, cemas, malu, rendah diri, serta kebingungan dalam menghadapi perubahan fisik yang terjadi lebih awal dibandingkan teman-teman seusianya. Ketidaksiapan emosional dan minimnya pengetahuan tentang menstruasi menyebabkan remaja yang mengalami menarche dini cenderung mengalami isolasi sosial, merasa berbeda dari teman sebaya, atau bahkan mengalami depresi ringan hingga sedang. Selain itu, tekanan sosial akibat menarche dini juga berpotensi memicu berbagai permasalahan psikologis, seperti stres kronik, kecemasan sosial, hingga penurunan prestasi akademik akibat gangguan konsentrasi dan rendahnya rasa percaya diri.

Dalam beberapa konteks budaya tertentu, menarche dini bahkan dapat memperbesar risiko seorang remaja perempuan untuk mengalami pernikahan dini. Hal ini dikarenakan dalam sejumlah budaya lokal, menstruasi pertama kali dianggap sebagai tanda bahwa seorang perempuan sudah cukup dewasa dan siap menikah, meskipun secara fisik, emosional, dan psikologis sebenarnya belum siap. Akibatnya, remaja perempuan yang mengalami menarche dini akan menghadapi risiko kesehatan yang lebih kompleks, termasuk risiko komplikasi kehamilan yang tinggi, masalah psikologis akibat beban peran sebagai istri dan ibu pada usia muda, hingga terganggunya hak-hak mereka dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Melihat berbagai implikasi tersebut, penting sekali untuk memberikan edukasi yang komprehensif dan tepat waktu kepada remaja perempuan mengenai konsep menarche serta segala konsekuensi yang menyertainya. Orang tua, guru, dan tenaga kesehatan memiliki peran vital dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai proses fisiologis menstruasi, cara menjaga kesehatan selama menstruasi, serta pentingnya pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya menarche dini atau mengurangi dampak negatif dari menarche dini tersebut. Edukasi yang tepat juga akan membantu remaja perempuan lebih siap secara emosional menghadapi menstruasi pertama mereka sehingga bisa menjalani masa transisi pubertas dengan lebih sehat, nyaman, serta percaya diri.

C. Pernikahan Dini dalam Perspektif Sosial dan Budaya

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada usia muda, di mana salah satu atau kedua pasangan belum mencapai usia 18 tahun. Secara umum, fenomena ini juga dikenal sebagai perkawinan anak, karena melibatkan individu yang secara fisik, psikologis, dan sosial masih tergolong sebagai anak-anak atau remaja awal. Meskipun definisi usia anak-anak dan remaja dapat bervariasi tergantung konteks hukum dan budaya di berbagai negara atau wilayah, standar internasional yang digunakan oleh berbagai organisasi internasional seperti UNICEF dan WHO menetapkan bahwa pernikahan sebelum usia 18 tahun dikategorikan sebagai pernikahan dini.

Fenomena pernikahan dini masih cukup banyak terjadi di berbagai negara berkembang, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, angka prevalensi pernikahan dini di Indonesia mencapai 11% hingga 15% dari total pernikahan yang terjadi setiap tahunnya. Meskipun telah mengalami penurunan dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya, jumlah pernikahan dini di Indonesia masih tergolong tinggi, terutama di daerah pedesaan, wilayah terpencil, atau daerah dengan tingkat pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas. Prevalensi yang tinggi ini mencerminkan bahwa

pernikahan dini masih menjadi bagian dari realitas sosial yang dihadapi oleh banyak remaja perempuan di Indonesia.

Terdapat berbagai faktor kompleks yang mendorong terjadinya pernikahan dini dalam suatu masyarakat. Faktor utama yang dominan adalah faktor ekonomi, di mana keluarga dengan status ekonomi rendah sering kali menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Orang tua menganggap bahwa dengan menikahkan anak perempuan mereka di usia dini, maka tanggung jawab ekonomi terhadap anak perempuan tersebut akan berkurang atau bahkan berpindah kepada suami atau keluarga suami. Selain itu, dalam beberapa masyarakat tradisional, pernikahan dini juga dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi anak perempuan dari ancaman kemiskinan atau pelecehan seksual yang rentan dialami dalam lingkungan sosial mereka.

Selain faktor ekonomi, faktor budaya juga memainkan peranan penting dalam mendorong terjadinya pernikahan dini. Dalam banyak budaya lokal, menstruasi atau menarche dipandang sebagai tanda bahwa seorang perempuan telah memasuki masa dewasa dan siap untuk menjalankan peran sebagai istri dan ibu, meskipun usia biologisnya masih tergolong anak-anak. Tradisi dan norma-norma budaya tertentu bahkan menganggap pernikahan dini sebagai bagian dari pelestarian adat istiadat atau nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tekanan sosial yang kuat dari lingkungan masyarakat turut mendorong para orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka lebih awal, agar dianggap telah memenuhi norma sosial yang berlaku di komunitas mereka.

Selain itu, faktor pendidikan juga menjadi aspek penting yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat pendidikan, baik pada orang tua maupun pada remaja perempuan itu sendiri, sering kali berkontribusi pada minimnya pemahaman akan dampak negatif dari pernikahan dini. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang hak-hak anak, kesehatan reproduksi, serta risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan di usia muda membuat banyak remaja perempuan maupun keluarga mereka mengambil keputusan yang tidak mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan remaja perempuan tersebut.

Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan reproduksi remaja perempuan. Remaja yang menikah dini cenderung lebih cepat mengalami kehamilan, padahal organ reproduksi mereka belum sepenuhnya matang. Kondisi ini meningkatkan risiko berbagai komplikasi kehamilan, seperti preeklampsia, kelahiran prematur, bayi dengan berat lahir rendah, hingga tingginya angka kematian ibu dan bayi. Risiko kesehatan reproduksi lainnya adalah terjadinya gangguan kesehatan reproduksi kronis, infeksi menular seksual (IMS), serta

komplikasi saat persalinan seperti perdarahan postpartum yang lebih sering terjadi pada remaja perempuan yang hamil di usia dini.

Dampak pernikahan dini tidak hanya terbatas pada kesehatan reproduksi semata, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan mental dan emosional remaja perempuan. Remaja perempuan yang menikah dini sering kali belum siap secara emosional dan mental untuk menghadapi berbagai tanggung jawab baru yang melekat pada status sebagai istri dan ibu. Kondisi ini menempatkan mereka pada tekanan psikologis yang besar, berupa stres, kecemasan, bahkan depresi yang kronis akibat perasaan tidak mampu atau tidak siap menjalani peran baru tersebut. Remaja perempuan yang menikah dini juga lebih rentan mengalami isolasi sosial karena harus meninggalkan lingkungan pergaulan sebaya, meninggalkan pendidikan formal, dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka secara optimal.

Dampak psikologis ini diperparah oleh keterbatasan dalam mengambil keputusan di lingkungan rumah tangga baru. Mereka sering kali kehilangan kebebasan pribadi untuk membuat keputusan terkait pendidikan, kesehatan, maupun reproduksi. Posisi tawar yang rendah dalam keluarga baru, ketergantungan ekonomi yang tinggi, serta relasi kuasa yang tidak seimbang dengan pasangan atau keluarga suami menyebabkan mereka lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi.

Selain itu, pernikahan dini juga memiliki dampak negatif jangka panjang terhadap kualitas hidup perempuan secara keseluruhan. Remaja perempuan yang menikah dini biasanya mengalami putus sekolah, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk memiliki masa depan yang lebih baik, mandiri secara ekonomi, dan memiliki kesejahteraan hidup yang tinggi. Pada akhirnya, pernikahan dini menciptakan lingkaran setan kemiskinan, di mana remaja perempuan yang menikah dini lebih mungkin mengalami kesulitan ekonomi di kemudian hari, yang selanjutnya akan terus mendorong terjadinya pernikahan dini pada generasi berikutnya.

Mengingat dampak negatif yang begitu kompleks dari pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, mental, sosial, serta ekonomi remaja perempuan, maka diperlukan berbagai upaya pencegahan yang serius dan terintegrasi. Edukasi yang komprehensif mengenai dampak negatif pernikahan dini harus diberikan kepada keluarga, komunitas, dan remaja perempuan secara khusus. Selain itu, kebijakan pemerintah dan regulasi terkait usia minimal pernikahan juga perlu ditegakkan secara konsisten, disertai dengan peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan ekonomi remaja perempuan. Dengan adanya pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, mulai

dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah, maka fenomena pernikahan dini dapat ditekan secara signifikan, sehingga remaja perempuan memiliki kesempatan untuk tumbuh, berkembang, serta menjalani masa depan yang lebih sehat, aman, dan berkualitas.

D. Peran Budaya Lokal dalam Menentukan Sikap terhadap Menarche dan Pernikahan Dini

Budaya lokal memiliki peran sentral dalam menentukan bagaimana suatu komunitas memandang dan menyikapi berbagai aspek kehidupan, termasuk yang terkait dengan siklus kehidupan perempuan seperti menarche dan pernikahan dini. Berbagai nilai, norma, dan praktik budaya secara signifikan memengaruhi bagaimana menarche dipahami dan diperlakukan dalam konteks sosial masyarakat tertentu. Di banyak komunitas, terutama yang bersifat tradisional, menarche bukan sekadar peristiwa fisiologis biasa yang menandai dimulainya masa menstruasi pada remaja perempuan, melainkan juga sebuah peristiwa sosial yang sarat makna. Menarche dianggap sebagai simbol bahwa seorang anak perempuan telah memasuki fase kehidupan baru yang penting, yaitu fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan sosial serta keluarga.

Dalam banyak budaya lokal, menarche dirayakan melalui serangkaian ritual khusus yang bertujuan untuk menandai transisi remaja perempuan ke dalam kehidupan dewasa secara sosial dan simbolis. Ritual tersebut biasanya melibatkan komunitas secara luas, mulai dari keluarga dekat, sanak saudara, hingga tetangga dan tokoh masyarakat. Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia, menarche diikuti oleh ritual tertentu seperti "pingitan" di mana anak perempuan menjalani periode isolasi atau pengasingan terbatas yang bertujuan agar ia memahami perubahan yang sedang terjadi pada dirinya dan memperoleh bimbingan dari anggota keluarga perempuan yang lebih tua mengenai peran barunya sebagai perempuan dewasa. Selama periode tersebut, anak perempuan juga diberikan berbagai nasehat, norma-norma, serta nilai-nilai yang harus ia pegang dalam kehidupan sosialnya nanti. Ritual-ritual seperti ini, walaupun secara simbolis bertujuan positif, dalam beberapa kasus juga secara tidak langsung memperkuat anggapan bahwa setelah menarche, perempuan secara otomatis dianggap siap menjalankan peran sosial yang kompleks, termasuk siap untuk menikah.

Budaya lokal juga memainkan peran besar dalam menentukan pandangan masyarakat tentang kapan seorang perempuan dianggap siap menikah setelah menarche. Di berbagai komunitas tradisional, menarche sering dipahami sebagai penanda biologis kesiapan seorang anak perempuan untuk menjalani pernikahan. Pemahaman ini berakar kuat pada nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang menganggap bahwa kedewasaan seorang perempuan tidak semata diukur dari usia kronologis atau kesiapan psikologis, melainkan dari adanya tanda-tanda fisiologis, dalam hal ini menarche. Budaya-budaya ini sering kali tidak membedakan antara kedewasaan biologis dengan kesiapan psikososial

seorang remaja perempuan untuk menjalankan peran sebagai istri dan ibu. Konsekuensinya, tidak jarang bahwa masyarakat tradisional justru mendorong, bahkan mendesak agar anak perempuan segera menikah setelah mengalami menarche, dengan alasan menjaga kehormatan keluarga, melindungi anak perempuan dari perilaku seksual di luar nikah, atau sekadar memenuhi tuntutan adat yang berlaku di komunitas tersebut.

Selain nilai dan norma budaya terkait kesiapan menikah, praktik pernikahan dini juga dipengaruhi oleh sejumlah kepercayaan yang berkembang dalam komunitas lokal. Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia, terdapat kepercayaan bahwa anak perempuan yang tidak segera menikah setelah menarche akan mendatangkan malu atau bahkan dianggap membawa kesialan bagi keluarga dan komunitasnya. Norma-norma sosial semacam ini menciptakan tekanan yang besar pada remaja perempuan maupun keluarganya, sehingga mendorong mereka untuk menerima pernikahan dini meskipun secara psikologis dan emosional belum siap.

Lebih jauh lagi, dalam banyak budaya lokal, terdapat tradisi dan ritual khusus yang menyertai pelaksanaan pernikahan dini. Ritual-ritual ini cenderung memperkuat status sosial perempuan muda sebagai istri baru dalam komunitasnya. Misalnya, upacara pernikahan dini sering diselenggarakan secara besar-besaran, melibatkan partisipasi luas dari komunitas setempat, serta diiringi berbagai prosesi adat yang memiliki makna simbolis tinggi. Dalam upacara tersebut, remaja perempuan yang menikah dini dianggap telah resmi berpindah status sosialnya dari seorang anak menjadi perempuan dewasa dengan tanggung jawab penuh sebagai istri dan calon ibu. Ritual-ritual ini, di satu sisi, memberikan legitimasi sosial bagi pernikahan dini, tetapi di sisi lain juga mempersempit ruang gerak perempuan muda untuk memilih jalannya sendiri, karena tekanan komunitas sangat kuat untuk memastikan tradisi ini tetap berlangsung.

Namun demikian, penting untuk disadari bahwa tradisi dan budaya bukanlah sesuatu yang bersifat statis atau tetap, melainkan terus berkembang seiring waktu. Budaya lokal memiliki kapasitas untuk berubah, terutama jika komunitas lokal memperoleh akses pada edukasi yang lebih luas mengenai dampak negatif pernikahan dini dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak perempuan dan anak. Di banyak daerah yang berhasil mengurangi angka pernikahan dini, upaya tersebut dilakukan dengan pendekatan dialog terbuka yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan para pemimpin adat untuk merumuskan kembali makna menarche dan batasan usia ideal untuk menikah. Dalam konteks ini, budaya lokal dapat menjadi agen perubahan positif jika para pemimpin komunitas mampu mendorong reinterpretasi nilai-nilai tradisional yang ada agar lebih selaras

dengan prinsip-prinsip kesehatan reproduksi, hak asasi manusia, serta pemberdayaan perempuan secara lebih luas.

peran budaya lokal dalam menentukan sikap terhadap menarche dan pernikahan dini sangat penting dan kompleks. Nilai, norma, serta praktik-praktik budaya yang berkaitan dengan menarche dan pernikahan dini, di satu sisi, bisa memperkuat eksistensi pernikahan dini dalam masyarakat. Namun di sisi lain, dengan pendekatan edukasi dan advokasi yang tepat, budaya lokal juga memiliki potensi besar untuk dimodifikasi atau bahkan dimanfaatkan sebagai bagian dari solusi dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Dalam proses ini, upaya edukasi dan sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka adat, serta para pemimpin agama lokal menjadi strategi penting yang dapat mendorong perubahan secara bertahap menuju tradisi dan norma sosial yang lebih sehat, berkeadilan, serta memberikan perlindungan optimal bagi remaja perempuan dari berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi akibat menarche dan pernikahan dini.

E. Dampak Interaksi Menarche dan Pernikahan Dini dalam Budaya Lokal

Menarche sebagai awal dari masa reproduktif perempuan memiliki hubungan yang erat dengan praktik pernikahan dini yang masih lazim terjadi dalam berbagai budaya lokal. Interaksi antara keduanya tidak hanya membawa implikasi mendalam terhadap kehidupan individu perempuan, tetapi juga berdampak luas terhadap komunitas dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu aspek yang paling menonjol dari interaksi ini adalah dampaknya terhadap kesehatan reproduksi remaja perempuan.

Secara fisiologis, menarche menandai awal kemampuan biologis seorang perempuan untuk bereproduksi. Namun demikian, terjadinya menarche tidak serta merta berarti remaja perempuan secara fisik siap menjalani kehamilan dan persalinan. Praktik pernikahan dini yang sering kali mengikuti terjadinya menarche dapat menempatkan remaja perempuan dalam risiko kesehatan reproduksi yang tinggi, karena tubuh mereka belum sepenuhnya berkembang secara optimal untuk menanggung kehamilan dan melahirkan. Remaja perempuan yang menikah dan hamil pada usia muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi seperti preeklampsia, anemia, perdarahan postpartum, hingga kematian ibu saat persalinan. Risiko ini muncul karena sistem reproduksi mereka, termasuk panggul yang belum matang sepenuhnya, sering kali belum mampu secara optimal menghadapi proses persalinan yang kompleks. Selain itu, bayi yang lahir dari ibu remaja juga memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan berbagai gangguan perkembangan akibat ibu yang secara fisik maupun psikologis belum sepenuhnya siap menjalani peran sebagai ibu.

Di samping risiko fisik, interaksi antara menarche dan pernikahan dini dalam budaya lokal juga membawa dampak psikososial yang sangat signifikan. Remaja perempuan yang menikah segera setelah mengalami menarche umumnya belum memiliki kesiapan mental dan emosional untuk menjalani kehidupan pernikahan. Mereka cenderung mengalami stres, kecemasan, depresi, bahkan trauma akibat tekanan yang dialami baik dari pasangan, keluarga, maupun masyarakat. Tekanan ini timbul karena beban sosial yang tinggi yang ditempatkan pada mereka untuk segera memenuhi harapan masyarakat sebagai seorang istri dan ibu, tanpa memperhatikan kesiapan emosional dan mental yang sesungguhnya diperlukan untuk menghadapi tanggung jawab sebesar itu.

Selain itu, remaja perempuan yang menikah dini sering kehilangan masa remaja yang seharusnya menjadi waktu penting untuk mengeksplorasi identitas pribadi, mengembangkan keterampilan sosial, serta membangun cita-cita dan tujuan hidup mereka. Pernikahan dini secara nyata mengurangi kesempatan perempuan muda untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas, mengurangi jaringan sosial yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan psikologis mereka secara sehat. Lebih jauh, tekanan yang timbul akibat pernikahan dini sering kali diperburuk oleh kurangnya dukungan sosial dan stigma negatif yang melekat pada status mereka sebagai "ibu muda" atau "istri muda" yang pada akhirnya menimbulkan rasa rendah diri, isolasi sosial, serta perasaan ketidakberdayaan.

Pengaruh lain yang tidak kalah penting dari interaksi antara menarche dan pernikahan dini adalah terhadap status pendidikan dan ekonomi perempuan. Pernikahan dini sangat erat kaitannya dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan formal. Budaya lokal yang mendorong pernikahan segera setelah menarche sering kali mengakibatkan remaja perempuan harus berhenti sekolah untuk fokus pada perannya dalam rumah tangga, baik sebagai istri maupun ibu. Akibatnya, kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi menjadi sangat terbatas atau bahkan hilang sama sekali. Terputusnya akses pendidikan ini memiliki efek domino yang berkelanjutan, di mana perempuan yang menikah muda cenderung memiliki keterampilan yang terbatas, pengetahuan yang minim, dan kapasitas yang rendah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di kemudian hari.

Situasi ini selanjutnya berkontribusi pada lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, karena perempuan yang menikah dini cenderung memiliki penghasilan rendah atau tidak stabil, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dengan kata lain, perempuan yang menikah dini cenderung terjebak dalam situasi ekonomi yang rentan, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang, karena

ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap suami atau keluarga besar. Hal ini kemudian mengurangi kemandirian perempuan dalam mengambil keputusan pribadi, termasuk dalam menentukan jumlah anak, akses kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka di masa depan.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga berdampak pada rendahnya kesadaran perempuan muda terhadap kesehatan reproduksi, sehingga meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan seperti kehamilan tidak direncanakan, infeksi menular seksual, dan berbagai penyakit reproduksi lainnya. Dalam skala yang lebih luas, fenomena ini juga memperkuat ketimpangan gender yang telah ada di komunitas lokal, di mana perempuan memiliki posisi yang lebih lemah secara sosial, ekonomi, dan politik dibandingkan laki-laki.

Oleh sebab itu, interaksi antara menarche dan pernikahan dini dalam budaya lokal menciptakan tantangan multidimensi yang kompleks dan saling berkaitan. Tantangan ini membutuhkan intervensi yang komprehensif dan terpadu dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga sosial, maupun komunitas lokal sendiri. Upaya tersebut dapat berupa edukasi yang intensif terhadap masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini, penguatan hukum dan kebijakan untuk melindungi remaja perempuan dari pernikahan dini, serta peningkatan akses perempuan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan reproduksi yang berkualitas.

F. Strategi Pencegahan Pernikahan Dini dengan Pendekatan Berbasis Budaya Lokal

Pernikahan dini merupakan fenomena kompleks yang masih banyak ditemukan dalam berbagai masyarakat, terutama di daerah dengan nilai-nilai tradisional yang kuat. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga erat hubungannya dengan budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh sebab itu, strategi pencegahan pernikahan dini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan khususnya berbasis pada budaya lokal, agar dapat diterima oleh masyarakat serta membawa perubahan yang berkelanjutan.

Salah satu strategi utama dalam pencegahan pernikahan dini adalah dengan melakukan pendekatan edukasi yang sensitif terhadap budaya lokal. Pendekatan edukasi ini bukan sekadar menyampaikan informasi mengenai dampak negatif pernikahan dini secara umum, melainkan menyesuaikan pesan-pesan edukatif tersebut agar selaras dengan nilai-nilai, norma sosial, dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat setempat. Dengan demikian, informasi yang diberikan tidak dianggap bertentangan atau mengancam tradisi yang sudah mapan, melainkan

justru menjadi pelengkap yang bermanfaat bagi kehidupan komunitas lokal tersebut.

Dalam penerapannya, pendekatan edukasi yang sensitif budaya dapat dilakukan dengan menggali terlebih dahulu aspek-aspek kearifan lokal yang dapat mendukung pesan-pesan anti pernikahan dini. Misalnya, nilai-nilai tentang pentingnya pendidikan, kesejahteraan keluarga, serta kesehatan dan keamanan perempuan, yang sesungguhnya ada dalam hampir setiap budaya lokal. Pesan edukatif kemudian dikemas dengan cara menekankan bahwa menunda pernikahan hingga usia matang akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi keluarga dan komunitas secara luas, tanpa meremehkan atau menegasikan norma budaya yang ada.

Di samping pendekatan edukasi, pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama menjadi sangat penting dalam strategi berbasis budaya lokal ini. Tokoh masyarakat dan pemuka agama memiliki peran sentral dan pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial, terutama di masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Mereka merupakan figur otoritatif yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat, sehingga apa yang mereka sampaikan cenderung diikuti dan diterapkan secara luas.

Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti dialog terbuka, diskusi kelompok, dan forum-forum komunitas yang secara khusus membahas isu pernikahan dini dari sudut pandang budaya, agama, dan kesejahteraan bersama. Tokoh masyarakat dan pemuka agama ini bisa berperan aktif dalam memberikan pemahaman bahwa pernikahan dini bukanlah satu-satunya cara untuk menjaga kehormatan keluarga atau tradisi, melainkan ada pilihan lain yang lebih baik, seperti mendukung anak-anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan dan tumbuh secara sehat sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dengan dukungan dari tokoh-tokoh ini, masyarakat cenderung lebih terbuka terhadap pesan-pesan anti pernikahan dini dan lebih mudah mengubah perilaku secara bertahap.

Contoh nyata keberhasilan pendekatan ini dapat dilihat dari studi kasus program-program pencegahan pernikahan dini di beberapa komunitas lokal di Indonesia maupun negara-negara lain. Misalnya, sebuah program yang pernah diterapkan di salah satu wilayah pedesaan Indonesia Timur menunjukkan hasil yang signifikan dalam menekan angka pernikahan dini setelah melibatkan secara intensif tokoh adat dan pemuka agama setempat. Program ini menggunakan pendekatan dialog budaya yang menekankan pentingnya keseimbangan antara menjaga tradisi dan mendorong kemajuan generasi muda melalui pendidikan. Tokoh-tokoh adat diberikan pelatihan khusus agar mampu menyampaikan pesan tentang bahaya

pernikahan dini secara efektif, tanpa menyinggung sensitivitas masyarakat. Hasilnya, komunitas tersebut berhasil meningkatkan usia rata-rata pernikahan dari 15 tahun menjadi di atas 18 tahun dalam waktu relatif singkat.

Program serupa juga berhasil diterapkan di beberapa wilayah Asia Selatan seperti India dan Bangladesh, di mana praktik pernikahan dini memiliki akar budaya yang kuat. Di wilayah ini, program-program yang sukses biasanya menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan kelompok-kelompok perempuan, remaja, dan tokoh-tokoh desa untuk bersama-sama mendiskusikan dampak pernikahan dini terhadap kesehatan, ekonomi, dan masa depan komunitas. Pesan yang disampaikan kemudian menjadi bagian dari kebijakan desa atau peraturan adat yang didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, sehingga secara efektif mengurangi insiden pernikahan dini secara drastis dalam waktu beberapa tahun saja.

Kesuksesan dari pendekatan berbasis budaya lokal ini secara umum didasari oleh pemahaman bahwa pernikahan dini bukan hanya isu pribadi atau keluarga semata, melainkan sebuah fenomena sosial-budaya yang memerlukan keterlibatan aktif semua unsur masyarakat. Dengan menggunakan kearifan lokal sebagai dasar pendekatan, maka perubahan yang dihasilkan bukan hanya bersifat sementara, melainkan berkelanjutan karena mendapat legitimasi dari komunitas setempat.

strategi pencegahan pernikahan dini yang berbasis budaya lokal menjadi sangat efektif karena mampu menghadirkan solusi yang realistis dan dapat diterima oleh masyarakat. Pendekatan edukasi yang sensitif budaya, pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama, serta pembelajaran dari studi kasus program yang berhasil di berbagai wilayah, adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan perubahan sikap dan perilaku yang mendalam di tingkat masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menekan prevalensi pernikahan dini, tetapi juga menciptakan kondisi sosial yang mendukung kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, serta pembangunan berkelanjutan secara lebih luas.

G. Tantangan dan Hambatan dalam Perubahan Norma Sosial dan Budaya

Upaya untuk mengubah norma sosial dan budaya yang sudah berlangsung secara turun-temurun tentu bukanlah hal yang mudah dilakukan. Dalam konteks pernikahan dini serta praktik-praktik budaya yang terkait, sering kali muncul berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam rangka menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Salah satu tantangan terbesar yang muncul adalah stigma dan resistensi dari masyarakat terhadap upaya perubahan praktik-praktik budaya yang dianggap telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas komunitas mereka.

Stigma terhadap perubahan praktik budaya biasanya muncul karena adanya persepsi yang keliru di masyarakat bahwa segala bentuk perubahan yang dibawa dari luar akan merusak tradisi, menghancurkan nilai-nilai moral lokal, serta dianggap sebagai ancaman terhadap identitas sosial mereka. Dalam hal ini, upaya mengurangi atau menghilangkan praktik pernikahan dini sering kali dianggap sebagai bentuk campur tangan yang tidak diinginkan, terutama oleh generasi yang lebih tua dan pemimpin adat yang melihatnya sebagai ancaman terhadap otoritas dan kekuasaan budaya mereka. Hal ini membuat masyarakat lebih sulit untuk menerima informasi baru, bahkan ketika informasi tersebut didukung oleh bukti ilmiah yang kuat mengenai dampak negatif pernikahan dini.

Resistensi terhadap perubahan praktik budaya juga muncul karena faktor sosial-ekonomi. Dalam beberapa masyarakat tradisional, pernikahan dini dipandang sebagai strategi ekonomi keluarga, baik untuk mengurangi beban ekonomi dengan "melepas" tanggung jawab terhadap anak perempuan, maupun karena adanya insentif ekonomi seperti mas kawin. Hal ini menyebabkan orang tua dan keluarga secara aktif mempertahankan praktik tersebut, sekalipun mereka sebenarnya sadar terhadap konsekuensi kesehatan dan psikososial yang mungkin muncul akibat pernikahan dini. Kondisi tersebut semakin memperkuat resistensi masyarakat, sehingga program intervensi yang tidak sensitif terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat justru dapat menemui hambatan yang besar dan sulit untuk berhasil.

Selain itu, faktor agama dan kepercayaan juga turut berkontribusi dalam membentuk resistensi ini. Dalam banyak komunitas, nilai-nilai agama sering dijadikan pembenaran terhadap praktik pernikahan dini. Interpretasi sempit terhadap teks-teks keagamaan terkadang digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik ini, sehingga upaya untuk mengubah norma sosial dianggap sebagai tindakan yang melawan agama atau keyakinan yang dianut masyarakat. Dalam kondisi demikian, resistensi masyarakat terhadap perubahan norma budaya dan sosial menjadi semakin kuat, dan tidak jarang diiringi dengan penolakan atau bahkan konflik sosial.

Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi yang matang dan komprehensif agar program intervensi perubahan norma sosial dan budaya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Salah satu strategi yang paling penting adalah pendekatan dialogis dan partisipatif. Pendekatan ini mengutamakan diskusi terbuka dengan seluruh elemen masyarakat, terutama dengan tokoh adat, pemuka agama, dan para pemimpin komunitas yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan opini publik. Melalui dialog ini, pemahaman yang mendalam tentang alasan-alasan di balik praktik-praktik budaya

tertentu dapat diperoleh, dan berbagai kesalahpahaman atau persepsi negatif dapat diluruskan secara bertahap.

Strategi lain yang juga penting adalah pendekatan berbasis bukti atau *evidence-based approach*. Dalam konteks ini, program intervensi harus disusun berdasarkan data dan fakta ilmiah yang jelas, yang menunjukkan secara konkret dampak negatif praktik-praktik seperti pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kondisi ekonomi masyarakat. Dengan menyediakan bukti nyata yang dikemas dalam cara yang mudah dipahami oleh komunitas lokal, resistensi masyarakat bisa diminimalkan karena mereka dapat melihat sendiri manfaat langsung dari perubahan norma sosial dan budaya tersebut bagi kesejahteraan mereka secara kolektif.

Selain itu, pelibatan aktif masyarakat dalam perancangan dan implementasi program intervensi juga sangat krusial untuk menghadapi tantangan resistensi tersebut. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, mereka tidak hanya menjadi objek perubahan, melainkan subjek yang ikut menentukan arah dan metode perubahan yang akan diterapkan. Hal ini menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap program, sehingga masyarakat lebih bersedia berpartisipasi dalam perubahan tersebut. Mereka juga lebih mampu untuk menghadapi tekanan sosial dan stigma negatif karena merasa bahwa perubahan yang dilakukan adalah inisiatif bersama, bukan sekadar imbauan atau tekanan dari luar.

Tidak kalah penting adalah pendekatan bertahap dan konsisten dalam mengimplementasikan perubahan norma sosial dan budaya. Perubahan budaya tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba atau radikal, karena hal ini akan memicu reaksi balik yang kuat. Sebaliknya, program intervensi harus dirancang secara bertahap, diawali dengan edukasi dan kampanye kesadaran, diikuti dengan keterlibatan para pemuka masyarakat, serta pelaksanaan secara konsisten dari waktu ke waktu. Dengan cara ini, resistensi dapat dikurangi secara perlahan, sehingga perubahan norma sosial dan budaya terjadi secara alami, bukan secara paksa.

Dalam konteks yang lebih luas, pendekatan ini memerlukan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, institusi pendidikan, hingga media massa. Sinergi antar sektor ini dapat memperkuat pesan-pesan perubahan dan membantu menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi perubahan yang diinginkan. Dengan demikian, stigma dan resistensi masyarakat terhadap perubahan praktik budaya tidak lagi menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi, melainkan menjadi tantangan yang dapat dikelola secara efektif demi terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik, sehat, dan sejahtera secara sosial, ekonomi, serta budaya.

H. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Menarche dan Pencegahan Pernikahan Dini

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memberikan edukasi mengenai menarche dan pencegahan pernikahan dini, khususnya dalam konteks kesehatan reproduksi remaja. Dalam lingkungan sosial-budaya yang kompleks, tenaga kesehatan sering kali menjadi garda terdepan yang berhubungan langsung dengan remaja perempuan dan keluarganya. Dengan pengetahuan medis yang kuat serta kemampuan berkomunikasi secara efektif, tenaga kesehatan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan yang terjadi pada masa menarche serta risiko-risiko yang terkait dengan pernikahan dini.

Pertama, tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kesehatan reproduksi secara menyeluruh, baik kepada remaja perempuan maupun keluarganya. Edukasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari informasi dasar mengenai perubahan fisiologis yang terjadi saat menarche, seperti siklus menstruasi, tanda-tanda fisik, dan emosional yang menyertainya, hingga cara menjaga kebersihan diri selama menstruasi. Remaja perempuan perlu memahami bahwa menarche merupakan bagian normal dari perkembangan tubuh mereka, dan bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dianggap tabu. Edukasi ini juga perlu menekankan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sejak dini, agar remaja perempuan dapat mengenali kondisi kesehatan mereka dengan baik dan terhindar dari berbagai masalah kesehatan reproduksi di masa depan.

Selain itu, keluarga, khususnya orang tua, juga merupakan kelompok sasaran yang sangat penting dalam edukasi kesehatan reproduksi ini. Tenaga kesehatan perlu memastikan bahwa orang tua memahami betul pentingnya memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada remaja perempuan saat mengalami menarche. Dalam banyak kasus, orang tua yang kurang informasi sering kali tidak mampu memberikan dukungan yang diperlukan, bahkan cenderung memperlakukan menstruasi sebagai sesuatu yang memalukan. Oleh karena itu, edukasi kepada keluarga harus diarahkan untuk mengubah persepsi ini, sehingga mereka lebih terbuka dan suportif dalam mendampingi anak perempuannya melewati fase penting ini dengan lebih nyaman dan percaya diri.

Di sisi lain, peran tenaga kesehatan juga sangat penting dalam menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja, khususnya di lingkungan yang masih sangat terpengaruh oleh budaya lokal. Layanan kesehatan yang ramah remaja bukan hanya berarti fasilitas kesehatan yang mudah diakses oleh remaja, melainkan juga layanan yang memperhatikan aspek privasi, kenyamanan, dan sensitivitas budaya setempat. Tenaga kesehatan harus mampu menciptakan suasana yang

nyaman dan aman bagi remaja perempuan untuk bertanya, berdiskusi, dan mencari informasi tentang kesehatan reproduksi tanpa rasa takut atau malu. Dalam konteks ini, kemampuan tenaga kesehatan untuk berkomunikasi secara empatik, tidak menghakimi, serta memahami konteks budaya setempat sangat penting agar remaja perempuan mau terbuka dan jujur dalam menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Pendekatan layanan yang sensitif budaya lokal juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap norma, nilai, dan tradisi yang berlaku di komunitas tertentu. Dalam beberapa komunitas, misalnya, ada norma-norma tertentu yang membatasi perempuan muda untuk berbicara terbuka mengenai isu-isu reproduksi atau bahkan mengunjungi fasilitas kesehatan tanpa pendamping keluarga. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu mencari cara-cara kreatif dan tepat untuk menjangkau remaja perempuan tersebut, misalnya dengan mengadakan kegiatan edukasi di luar fasilitas kesehatan, seperti di sekolah atau tempat-tempat komunitas lainnya, serta melibatkan pemuka agama atau tokoh adat untuk mendukung kampanye kesehatan reproduksi ini. Cara ini akan membantu remaja perempuan lebih mudah menerima informasi yang diberikan karena merasa didukung oleh lingkungan sosialnya.

Lebih jauh lagi, tenaga kesehatan berperan penting dalam pemberdayaan komunitas melalui pendampingan dan konseling yang berkelanjutan. Pendampingan ini tidak terbatas pada kegiatan sekali waktu, tetapi harus menjadi proses yang berkelanjutan dalam komunitas. Melalui konseling, tenaga kesehatan dapat membantu remaja perempuan mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul terkait menarche atau tekanan sosial yang mengarah pada pernikahan dini. Remaja perempuan yang mengalami tekanan untuk menikah lebih awal, misalnya, dapat memperoleh dukungan emosional dan psikologis melalui sesi konseling yang intensif. Dalam proses ini, mereka akan diberikan pemahaman yang jelas tentang dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan reproduksi, gangguan psikologis, serta terhambatnya akses pendidikan dan kesempatan ekonomi.

Di tingkat komunitas yang lebih luas, tenaga kesehatan juga dapat berperan sebagai fasilitator dan agen perubahan dengan menggerakkan berbagai kegiatan pemberdayaan komunitas. Pendampingan dalam bentuk kelompok diskusi, pelatihan, dan lokakarya kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi remaja serta dampak buruk dari praktik pernikahan dini. Di sini, peran tenaga kesehatan tidak hanya sebagai penyedia informasi semata, tetapi juga sebagai mitra komunitas dalam membangun komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan remaja perempuan.

tenaga kesehatan memiliki peran sentral dalam memberikan edukasi, menyediakan layanan kesehatan reproduksi ramah remaja, serta melakukan pemberdayaan komunitas melalui pendampingan dan konseling. Dengan pendekatan yang sensitif budaya serta pemberdayaan yang efektif, tenaga kesehatan tidak hanya membantu remaja perempuan untuk menjalani masa menarche secara sehat, tetapi juga berkontribusi besar dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Melalui peran ini, tenaga kesehatan dapat membantu menciptakan generasi perempuan muda yang lebih sehat, mandiri, berdaya, dan memiliki masa depan yang lebih baik secara sosial, ekonomi, dan kesehatan.

I. Simpulan

Menarche merupakan peristiwa biologis penting yang menandai dimulainya masa reproduktif seorang perempuan. Meskipun menarche menunjukkan kematangan seksual secara biologis, hal ini tidak serta merta mencerminkan kesiapan fisik, psikologis, dan emosional seorang remaja perempuan untuk memasuki kehidupan pernikahan dan kehamilan. Di banyak komunitas lokal, menarche sering kali dijadikan indikator bahwa seorang remaja perempuan telah siap untuk menikah. Akibatnya, praktik pernikahan dini masih banyak terjadi, didorong oleh berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, sosial, budaya, hingga interpretasi agama yang keliru.

Pernikahan dini membawa dampak negatif yang kompleks dan luas terhadap kesehatan reproduksi remaja perempuan. Secara fisiologis, remaja perempuan yang menikah dan hamil dini memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi kesehatan seperti preeklampsia, anemia, perdarahan postpartum, kelahiran prematur, serta kematian ibu dan bayi. Secara psikologis, pernikahan dini dapat memicu stres, kecemasan, depresi, hingga trauma emosional yang berkepanjangan akibat ketidaksiapan mental dalam menghadapi berbagai tanggung jawab sebagai istri dan ibu di usia muda.

Selain itu, pernikahan dini juga memiliki konsekuensi serius terhadap status pendidikan dan ekonomi perempuan. Remaja perempuan yang menikah dini sering kali putus sekolah, sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas. Situasi ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, yang memperkuat ketergantungan ekonomi perempuan terhadap keluarga atau suami, serta memperbesar ketimpangan gender dalam masyarakat.

Budaya lokal memegang peranan kunci dalam mempertahankan atau mencegah praktik pernikahan dini. Norma, nilai, dan tradisi lokal yang mengaitkan menarche dengan kesiapan menikah sering kali memperkuat praktik ini. Namun

demikian, budaya lokal juga memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan apabila diberikan pendekatan edukasi yang sensitif dan partisipatif. Melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemimpin komunitas dalam kampanye anti pernikahan dini terbukti efektif dalam menciptakan perubahan sikap secara berkelanjutan.

Tantangan utama dalam upaya perubahan praktik budaya ini meliputi resistensi masyarakat, stigma sosial, serta hambatan ekonomi dan interpretasi agama. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pendekatan dialogis yang partisipatif dan bertahap sangat diperlukan. Pelibatan aktif masyarakat, strategi edukasi yang berbasis bukti, serta sinergi lintas sektor menjadi solusi yang efektif untuk mengubah norma sosial dan budaya secara bertahap.

Tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam upaya edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini. Melalui edukasi yang komprehensif kepada remaja perempuan dan keluarga, layanan kesehatan ramah remaja yang sensitif budaya, serta pemberdayaan komunitas melalui pendampingan dan konseling berkelanjutan, tenaga kesehatan dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan generasi muda yang sehat, mandiri, dan berdaya.

Dengan demikian, pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan tenaga profesional kesehatan merupakan langkah kunci dalam mencegah pernikahan dini serta melindungi hak dan kesejahteraan remaja perempuan secara optimal.

J. Referensi

- Bearinger, L. H., Sieving, R. E., Ferguson, J., & Sharma, V. (2007). Global perspectives on the sexual and reproductive health of adolescents: Patterns, prevention, and potential. *The Lancet*, 369(9568), 1220–1231. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)60367-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60367-5)
- Fonner, V. A., Armstrong, K. S., Kennedy, C. E., O'Reilly, K. R., & Sweat, M. D. (2014). School-based sex education and HIV prevention in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *PLoS ONE*, 9(3), e89692. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089692>
- International Center for Research on Women (ICRW). (2018). *Child marriage and health in Indonesia: Evidence from national surveys*. ICRW.
- Jensen, R., & Thornton, R. (2003). Early female marriage in the developing world. *Gender and Development*, 11(2), 9–19. <https://doi.org/10.1080/13552070312331388022>

- Kirby, D. (2007). Emerging answers 2007: Research findings on programs to reduce teen pregnancy and sexually transmitted diseases. National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy.
- Malhotra, A., Warner, A., McGonagle, A., & Lee-Rife, S. (2011). Solutions to end child marriage: What the evidence shows. International Center for Research on Women. Retrieved from <https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/Solutions-to-End-Child-Marriage.pdf>
- Pennington, J. (2019). Menarche and sociocultural initiation rituals in rural Indonesia. *Journal of Adolescent Health*, 65(5), 630–637. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.05.012>
- UNICEF. (2020). Child marriage around the world: Trends and drivers. UNICEF. <https://www.unicef.org/reports/child-marriage-around-world-2020>
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations on adolescent sexual and reproductive health and rights. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241514606>
- Yount, K. M., Peterman, A., & Cheong, Y. F. (2014). Female empowerment and future fertility in Egypt. *Studies in Family Planning*, 45(4), 397–424. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4465.2014.00392.x>

K. Glosarium

Adat Istiadat

Kebiasaan atau tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas yang menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat tersebut.

Budaya Lokal

Nilai-nilai, norma, kepercayaan, serta praktik khas yang berkembang dalam suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu.

Kesehatan Reproduksi

Keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan terkait sistem reproduksi dan fungsinya, tetapi juga meliputi kehidupan seksual yang aman dan sehat.

Menarche

Peristiwa menstruasi pertama kali yang dialami perempuan, yang menandai awal masa pubertas dan kemampuan reproduksi.

Menarche Dini

Menarche yang terjadi lebih awal dibandingkan usia rata-rata populasi perempuan secara umum, umumnya sebelum usia 10 tahun, yang bisa menimbulkan dampak kesehatan fisik dan psikologis.

Norma Sosial

Aturan-aturan yang disepakati dalam suatu komunitas atau masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang memengaruhi perilaku individu di dalam komunitas tersebut.

Perkawinan Anak (Pernikahan Dini)

Pernikahan yang dilakukan sebelum individu mencapai usia 18 tahun, sering kali karena tekanan ekonomi, budaya, atau sosial yang mengabaikan kesiapan fisik, mental, dan emosional individu tersebut.

Pubertas

Periode transisi dari masa kanak-kanak menuju masa remaja yang ditandai dengan perubahan fisik, hormonal, dan psikologis yang signifikan, salah satunya adalah terjadinya menarche pada perempuan.

Ritual Menarche

Upacara atau kegiatan seremonial khusus yang diselenggarakan oleh komunitas tertentu untuk merayakan menstruasi pertama seorang perempuan, biasanya sebagai simbol transisi menuju dewasa secara sosial.

Sensitif Budaya

Pendekatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, rasa hormat, dan pemahaman terhadap nilai, norma, serta praktik budaya yang berlaku dalam suatu komunitas agar pesan atau intervensi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Stigma Sosial

Pandangan negatif atau label buruk yang diberikan oleh masyarakat terhadap individu atau kelompok tertentu, sering kali menciptakan isolasi sosial atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok tersebut.

Strategi Berbasis Budaya Lokal

Pendekatan intervensi atau edukasi yang dirancang dengan mempertimbangkan secara khusus nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku dalam komunitas lokal agar pesan yang disampaikan relevan, efektif, dan dapat diterima masyarakat.

Tenaga Kesehatan

Profesional yang memiliki pengetahuan medis, keterampilan, dan kompetensi dalam memberikan layanan kesehatan, edukasi, serta konseling kepada masyarakat mengenai isu kesehatan reproduksi dan berbagai aspek kesehatan lainnya.

PROFIL PENULIS



Priscilla Jessica Pihahesy, SKM., M.K.M. Lahir di Serui, Kepulauan Yapen, 3 November 1987. Ia meraih Magister Kesehatan (minat Kesehatan Ibu dan Anak) dari Universitas Sebelas Maret pada 2020. Priscilla mengabdikan sebagai Dosen Tetap pada Prodi D-III Kebidanan, Kampus Manokwari, Poltekkes Kemenkes Sorong. Mata kuliah yang diampu meliputi Promosi Kesehatan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Metodologi Penelitian, HIV/AIDS, Ilmu Sosial Budaya Dasar, **Sosioantropologi dalam Kebidanan**, dan **Keperawatan Maternitas**. Penulis Aktif dalam Tridharma dengan melakukan aktifitas penelitian, menulis buku dan artikel ilmiah, mengabdikan di masyarakat, menjadi pembicara seminar, serta reviewer di beberapa jurnal.. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: priscilla@poltekkessorong.ac.id/nunangpriscilla@gmail.com
Motto: "Kehidupan itu Anugerah, Hargailah!!!"



Bdn. Meli Doloksaribu, S.Tr.keb, M.Keb., Lahir di Pematangsiantar, 30 November 1988. Pendidikan Tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-III pada Program Studi Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sumatera Utara (STIKES-SU) tahun 2009, Pendidikan D-IV Bidan Pendidik pada Universitas Sumatera Utara (USU) dan lulus tahun 2015, Pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Ilmu Kebidanan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar dan lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan Profesi Bidan di Institut Kesehatan Sumatera Utara (INKES SUMUT) dan lulus pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sebagai bidan pelaksana di Praktik Bidan Mandiri di Kabanjahe. Saat ini penulis bekerja di Institut Kesehatan Sumatera Utara (INKES SUMUT) mengampu mata kuliah Inovasi Pelayanan Kebidanan Komplementer I dan II, Asuhan Kebidanan Pada Remaja dan Perimenopause, Asuhan Kebidanan Pada Perempuan dan Anak dengan Kondisi Rentan, Asuhan Kebidanan Pada Persalinan, Profesionalisme Kebidanan, Asuhan Kebidanan Pada Pranikah dan Prakonsepsi, Manajemen Pelayanan Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mengembangkan, menransformasi ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta aktif sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: melidoloksaribu88@gmail.com

Motto: "Selalu jadi versi terbaik dirimu sendiri bukan versi kelas dua dari orang lain"



PROFIL PENULIS



Vera Suzana Dewi Haris, SST., Bdn., M.Keb Lahir di Padang, 13 Januari 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Kebidanan pada Program Studi Kedokteran, Universitas Padjajaran tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Program Studi Kedokteran, Universitas Padjajaran tahun 2013 dan lulus tahun pada tahun 2015. Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Tangerang pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1999-2004 bekerja di Puskesmas Seberang Padang. Tahun 2004-2009 bekerja di TPMB Wenny Bukittinggi. Tahun 2009-2010 dosen di Universitas Gundharma, 2010-2016 dosen di Akademi Kebidanan Keris Husada Jakarta. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Mengampu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, asuhan kebidanan neonatus, bayi balita dan prasekolah. kegawatdaruratan maternal dan neonatal, asuhan kebidanan komunitas, keterampilan dasar kebidanan, ilmu sosial budaya dasar, kolaborasi antar profesi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai dosen, penulis buku ajar: Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan, Ilmu Sosial Budaya Dasar, Kolaborasi Antar Profesi, Bunga Rampai Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal. Publikasi Internasional, Scopus dan Nasional Terakreditasi SINTA, pelatihan dan workshop dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: vera.haris@poltekkesjakarta1.ac.id
Motto: "Dedication in Knowledge, Devotion in Care"



Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb Lahir di Kotamobagu, 16 Februari 1998. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-IV Kebidanan pada Program Studi Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Manado tahun 2015-2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin di Makassar dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2022 di Akademi Kebidanan Bunda Kotamobagu yang saat ini telah merger menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi Jainuddin Kotamobagu hingga tahun 2024. Kemudian terangkat PNS pada April 2024 di Poltekkes Kemenkes Manado, sehingga sampai saat ini mejadi dosen pengajar dengan homebased di Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Manado. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Praktek Klinik Kebidanan, Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan, Ilmu Kesehatan Anak, Praktek Kebidanan Fisiologis: Kehamilan, Persalinan, Nifas, KB/KR, Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah, Anatomi Fisiologi, Obstetri dan Ginekologi, Metodologi Penelitian, serta Asuhan Kebidanan Remaja dan Perimenopause. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, publikasi, seminar, pengabdian masyarakat, penelitian dan dewan redaksi Jurnal Imliah Bidan (JIDAN) Poltekkes Kemenkes Manado. Beberapa buku yang telah diterbitkan oleh penulis diantaranya Asuhan Persalinan dengan Perspektif Midwifery Era 5.0, Bunga Rampai Kesehatan Anak dan Pediatri, serta Keperawatan Medikal Bedah 3. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: deivitayan@gmail.com. Motto: "Be yourself and authentic"

Sinopsis

Buku *Bunga Rampai Siklus Hidup Perempuan: Perspektif Kebidanan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal* merupakan kumpulan karya ilmiah yang mengangkat dinamika kehidupan perempuan dari masa remaja, reproduksi, hingga lansia dalam bingkai keilmuan kebidanan yang berpadu dengan nilai budaya serta kearifan lokal. Kehidupan perempuan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya tempat ia berada. Tradisi, adat, serta kepercayaan lokal sering kali memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kesehatan perempuan, khususnya dalam hal kehamilan, persalinan, nifas, dan masa transisi lainnya.

Dalam buku ini, para penulis menyajikan uraian komprehensif mengenai praktik kebidanan yang tidak hanya berlandaskan pada ilmu pengetahuan modern, tetapi juga menghargai nilai-nilai lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Pembahasan mencakup integrasi antara evidence-based practice dengan pendekatan budaya, pemanfaatan kearifan lokal sebagai strategi promotif dan preventif, serta tantangan dan peluang dalam menerapkan pelayanan kebidanan yang peka budaya.

Keunggulan buku ini terletak pada keberaniannya menjembatani ilmu kebidanan dengan realitas kehidupan perempuan di masyarakat. Dengan menampilkan beragam studi kasus, praktik tradisional yang adaptif, hingga inovasi pelayanan berbasis kearifan lokal, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, bidan, dan tenaga kesehatan dalam memahami perempuan secara holistik.

Bunga Rampai Siklus Hidup Perempuan: Perspektif Kebidanan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga menjadi inspirasi untuk mengembangkan pelayanan kebidanan yang humanis, peka budaya, dan selaras dengan kebutuhan nyata perempuan di setiap tahap kehidupannya.

Buku Bunga Rampai Siklus Hidup Perempuan: Perspektif Kebidanan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal merupakan kumpulan karya ilmiah yang mengangkat dinamika kehidupan perempuan dari masa remaja, reproduksi, hingga lansia dalam bingkai keilmuan kebidanan yang berpadu dengan nilai budaya serta kearifan lokal. Kehidupan perempuan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya tempat ia berada. Tradisi, adat, serta kepercayaan lokal sering kali memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kesehatan perempuan, khususnya dalam hal kehamilan, persalinan, nifas, dan masa transisi lainnya.

Dalam buku ini, para penulis menyajikan uraian komprehensif mengenai praktik kebidanan yang tidak hanya berlandaskan pada ilmu pengetahuan modern, tetapi juga menghargai nilai-nilai lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Pembahasan mencakup integrasi antara evidence-based practice dengan pendekatan budaya, pemanfaatan kearifan lokal sebagai strategi promotif dan preventif, serta tantangan dan peluang dalam menerapkan pelayanan kebidanan yang peka budaya.

Keunggulan buku ini terletak pada keberaniannya menjembatani ilmu kebidanan dengan realitas kehidupan perempuan di masyarakat. Dengan menampilkan beragam studi kasus, praktik tradisional yang adaptif, hingga inovasi pelayanan berbasis kearifan lokal, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, bidan, dan tenaga kesehatan dalam memahami perempuan secara holistik.

Bunga Rampai Siklus Hidup Perempuan: Perspektif Kebidanan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga menjadi inspirasi untuk mengembangkan pelayanan kebidanan yang humanis, peka budaya, dan selaras dengan kebutuhan nyata perempuan di setiap tahap kehidupannya.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7426-12-3



9

786347

426123